CEDE
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico

# Análisis de la situación del desarrollo en la primera infancia en Colombia y recomendaciones de política

Jorge Cuartas
Ana María Restrepo-Sáenz
Diana Lopera
Tatiana Plata-Caviedes
Camila Alfonso
Juliana Borbón
Hans Cabra
Francisco Cardozo
Juan Camilo Cristancho
Santiago Gómez-Echeverry
Hernando Grueso
Lizette Pizza
Catalina Rey-Guerra
Jimena Rozo

Documento CEDE

#51

Octubre de 2026

Universidad de los Andes Colombia
Facultad de Economía

Serie Documentos Cede, 2026-51 ISSN 1657-7191 Edición electrónica. Octubre de 2026

© 2026, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE. Calle 19A No. 1 – 37 Este, Bloque W. Bogotá, D. C., Colombia Teléfonos: 3394949- 3394999, extensiones 2400, 2049, 2467

infocede@uniandes.edu.co
http://economia.uniandes.edu.co

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

La serie de Documentos de Trabajo CEDE se circula con propó-sitos de discusión y divulgación. Los artículos no han sido evaluados por pares ni sujetos a ningún tipo de evaluación formal por parte del equipo de trabajo del CEDE. El contenido de la presente publicación se encuentra protegido por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad intelectual, por tanto su utilización, reproducción, comunica-ción pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso, digital o en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y sólo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito del autor o titular. Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor, sólo serán aplicables en la medida en que se den dentro de los denominados Usos Honrados (Fair use), estén previa y expresamente establecidas, no causen un grave e injustificado perjuicio a los intereses legítimos del autor o titular, y no atenten contra la normal explotación de la obra.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación Reconoci-miento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Con la colaboración de:

Universidad de los Andes Colombia | Facultad de Ciencias Sociales

CEDE
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico

## Documento CEDE

**Descripción:** los documentos CEDE son producto de las investigaciones realizadas por al menos un profesor de planta de la Universidad de los Andes o sus investigadores formalmente asociados.

Universidad de los Andes Colombia | Facultad de Economía

# Análisis de la situación del desarrollo en la primera infancia en Colombia y recomendaciones de política

Jorge Cuartas[1]; Ana María Restrepo-Sáenz[2]; Diana Lopera[3]; Tatiana Plata-Caviedes[4]; Camila Alfonso[5]; Juliana Borbón[6]; Hans Cabra[7]; Francisco Cardozo[8]; Juan Camilo Cristancho[9]; Santiago Gómez-Echeverry[10]; Hernando Grueso[11]; Lizette Pizza[12]; Catalina Rey-Guerra[13]; Jimena Rozo[14]

## Resumen

La primera infancia es el periodo de mayor plasticidad neurobiológica y sienta los cimientos del desarrollo a lo largo de la vida. Este documento, elaborado por el colectivo CIMIENTOS, analiza la situación del desarrollo en la primera infancia en Colombia y formula recomendaciones de política a partir de una revisión de literatura, datos secundarios y 25 entrevistas semiestructuradas con informantes clave de la academia, el sector público, organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. Los hallazgos muestran brechas territoriales persistentes en pobreza infantil, crianza y violencia, educación inicial, salud y nutrición, cambio climático, migración y desplazamiento forzado, nuevas tecnologías y sistemas de datos. Aunque Colombia cuenta con un marco normativo robusto, la Política De Cero a Siempre, persiste una brecha entre la formulación de la política y su implementación efectiva, marcada por la priorización de la cobertura sobre la calidad, la fragmentación de los sistemas de información, la insuficiencia de financiación estructural y la debilidad de los mecanismos de seguimiento y evaluación. Las recomendaciones se organizan en cuatro dimensiones: calidad, datos e investigación, intersectorialidad y territorialización, y financiación. La evidencia nacional e internacional indica que cerrar estas brechas es una de las inversiones más costo-efectivas para el desarrollo del país.

**Códigos JEL:** I14, I24, I32, I38, J13, H52, O54
**Palabras clave:** primera infancia, desarrollo infantil temprano, política pública, educación inicial, pobreza infantil, Colombia

[1] Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Economía, Universidad de los Andes; Stanford Center on Early Childhood, Universidad de Stanford; Global TIES for Children, Universidad de Nueva York. jcuartas@uniandes.edu.co
[2] Departamento de Política Social e Intervención, Universidad de Oxford, ana.restreposaenz@spi.ox.ac.uk
[3] Departamento de Psicología, Universidad del Norte, cdlopera@uninorte.edu.co
[4] Departamento de Psicología, Universidad Nacional de Colombia, tplatac@unal.edu.co
[5] Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Universidad de Harvard, camilaalfonso@hks.harvard.edu
[6] Departamento de Psicología Aplicada, Universidad de Nueva York (NYU), juliana.borbon@nyu.edu
[7] Facultad de Educación, Universidad de los Andes, hw.cabra2017@uniandes.edu.co
[8] Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento, Universidad de Miami, foc9@miami.edu
[9] Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno, Universidad EAFIT, jcristana@eafit.edu.co
[10] Departamento de Sociología, Universidad Libre de Ámsterdam, s.gomez-echeverry@vu.nl
[11] Departamento de Política Social e Intervención, Universidad de Oxford, hernando.gruesohurtado@spi.ox.ac.uk
[12] Departamento de Psicología, Universidad de Harvard, lpizza@g.harvard.edu
[13] Fundación Apapacho, c.reyguerra@fundacionapapacho.org
[14] Doctorado en Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile, ljrozo@uc.cl

# Analysis of the State of Early Childhood Development in Colombia and Policy Recommendations

Jorge Cuartas[15]; Ana María Restrepo-Sáenz[16]; Diana Lopera[17]; Tatiana Plata-Caviedes[18]; Camila Alfonso[19]; Juliana Borbón[20]; Hans Cabra[21]; Francisco Cardozo[22]; Juan Camilo Cristancho[23]; Santiago Gómez-Echeverry[24]; Hernando Grueso[25]; Lizette Pizza[26]; Catalina Rey-Guerra[27]; Jimena Rozo[28]

## Abstract

Early childhood is the period of greatest neurobiological plasticity and lays the foundations for development across the life course. This document, prepared by the CIMIENTOS collective, analyzes the state of early childhood development in Colombia and formulates policy recommendations based on a literature review, secondary data, and 25 semi-structured interviews with key informants from academia, the public sector, multilateral organizations, and non-governmental organizations. The findings reveal persistent territorial gaps in child poverty, parenting and violence, early childhood education, health and nutrition, climate change, migration and forced displacement, new technologies, and data systems. Although Colombia has a robust legal framework, the From Zero to Forever Policy (De Cero a Siempre), a gap persists between policy formulation and effective implementation, marked by the prioritization of coverage over quality, fragmented information systems, insufficient structural financing, and weak monitoring and evaluation mechanisms. The recommendations are organized into four dimensions: quality, data and research, intersectorality and territorialization, and financing. National and international evidence indicates that closing these gaps is one of the most cost-effective investments available for the country's development.

**JEL codes:** I14, I24, I32, I38, J13, H52, O54
**Keywords:** early childhood, early childhood development, public policy, early childhood education, child poverty, Colombia

[15] School of Social Sciences and School of Economics, Universidad de los Andes; Stanford Center on Early Childhood, Stanford University; Global TIES for Children, New York University. jcuartas@uniandes.edu.co
[16] Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford, ana.restreposaenz@spi.ox.ac.uk
[17] Department of Psychology, Universidad del Norte, cdlopera@uninorte.edu.co
[18] Department of Psychology, Universidad Nacional de Colombia, tplatac@unal.edu.co
[19] Harvard Kennedy School, Harvard University, camilaalfonso@hks.harvard.edu
[20] Department of Applied Psychology, New York University (NYU), juliana.borbon@nyu.edu
[21] School of Education, Universidad de los Andes, hw.cabra2017@uniandes.edu.co
[22] Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Miami, foc9@miami.edu
[23] School of Finance, Economics and Government, Universidad EAFIT, jcristana@eafit.edu.co
[24] Department of Sociology, Vrije Universiteit Amsterdam, s.gomez-echeverry@vu.nl
[25] Department of Social Policy and Intervention, University of Oxford, hernando.gruesohurtado@spi.ox.ac.uk
[26] Department of Psychology, Harvard University, lpizza@g.harvard.edu
[27] Fundación Apapacho, c.reyguerra@fundacionapapacho.org
[28] Doctoral Program in Education, Pontificia Universidad Católica de Chile, ljrozo@uc.cl

**Agradecimientos:**

Agradecemos a las y los participantes en las entrevistas, quienes ofrecieron sus conocimientos para enriquecer las recomendaciones de política de este documento, incluyendo, en orden alfabético, a Ana María Nieto, Ana Rita Russo, Angy Mateus, Camilo Peña, Carlos Andrés Aragón, Carlos del Castillo, Carolina Casas, Carolina Maldonado, Carolina Piñeros, Constanza Alarcón, Diana Bejarano, Diana Carolina Parra, José Amar Amar, María Adelaida López, María Consuelo Gaitán, Milagros Nores, Natalia Quiñonez, Orazio Attanasio, Pedro Quijano, Sandra Durán, Sandra García, Sara Mestre, Viviana Quintero, Zulma Fonseca y personas que prefieren mantenerse anónimas. Tatiana Plata agradece a Natalia Conde, Nicolás Cortés y Luciana Ruiz, por su apoyo en la revisión inicial de literatura para la sección de educación inicial. También agradecemos especialmente a Manuela Puyana Di Marco por su apoyo en revisión del documento y organización de las referencias bibliográficas.

Esta publicación y sus autores hacen parte de CIMIENTOS, Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social, dedicado a promover el desarrollo infantil temprano y el uso de evidencia en las políticas y prácticas de primera infancia en Colombia y América Latina. Más información en https://cimientos.vercel.app/

**Contribuciones:**

J. Cuartas y A.M. Restrepo-Sáenz lideraron la conceptualización y edición de este documento. J. Cuartas, A.M. Restrepo-Sáenz, D. Lopera y T. Plata Caviedes desarrollaron la estructura original del documento. H. Cabra, J. Cuartas y C. Rey-Guerra lideraron la sección de pobreza. D. Lopera y J. Cuartas lideraron la sección de crianza. T. Plata, J. Rozo, C. Rey-Guerra y J. Cristancho lideraron la sección de educación inicial. J. Cristancho y J. Cuartas lideraron la sección de violencia. L. Pizza y J. Cuartas lideraron la sección de cambio climático. C. Alfonso lideró la sección de salud y nutrición. A.M. Restrepo-Sáenz lideró la sección de migración y desplazamiento forzados. F. Cardozo lideró la sección de nuevas tecnologías. S. Gómez-Echeverry, H. Grueso, F. Cardozo y J. Cuartas lideraron la sección de datos. H. Grueso lideró la sección de retornos a la inversión. J. Borbón, F. Cardozo y J. Cuartas lideraron el análisis de datos cualitativos. Todos los autores participaron en la recolección y análisis de datos cualitativos y la formulación de recomendaciones de política.

CIMIENTOS

Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social

**Lista de acrónimos:**

| | |
|---|---|
| ASQ | Ages and Stages Questionnaires |
| CDI | Centro de Desarrollo Infantil |
| CIMIENTOS | Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social |
| CIPI | Comisión Intersectorial de Primera Infancia |
| DANE | Departamento Administrativo Nacional de Estadística |
| DCAS | Política Nacional De Cero a Siempre |
| DAPRE | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| DPS | Departamento de Prosperidad Social |
| EAD | Escala Abreviada de Desarrollo |
| ECD | Escala Cualitativa de Desarrollo |
| ECDI | Indice de Desarrollo Infantil Temprano |
| ECV | Encuesta Nacional de Calidad de Vida |
| EE | Establecimientos Educativos |
| ENDS | Encuesta Nacional de Demografía y Salud |
| ENSIN | Encuesta Nacional de Situación Nutricional |
| ENUT | Encuesta Nacional del Uso del Tiempo |
| ELCA | Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes |
| ELCO | Encuesta Longitudinal de Colombia |
| GEIH | Gran Encuesta Integrada de Hogares |
| GSED | Escalas Globales de Desarrollo Temprano |
| ICBF | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar |
| IDELA | International Development and Early Learning Assessment |
| MEN | Ministerio de Educación Nacional |
| MP-N | Medida de Pobreza en la Niñez |
| PDET | Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| RIA | Ruta Integral de Atenciones |
| SDQ | Strengths and Difficulties Questionnaire |
| SSDIPI | Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia |
| SUIN | Sistema Único de Información de la Niñez |
| TVIP | Test de Vocabulario en Imágenes Peabody |
| UARIV | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas |

Contenido

Resumen ejecutivo ..... 6
Executive summary ..... 11
Introducción ..... 15
La ciencia del desarrollo en la primera infancia ..... 17
Los contextos de desarrollo de la primera infancia ..... 21
Marco de política de primera infancia y evaluaciones de la política ..... 22
Oportunidades y desafíos para la primera infancia en Colombia ..... 25
Objetivos ..... 28
Métodos ..... 29
Revisión de literatura ..... 29
Estudio cualitativo con informantes clave ..... 29
Resultados ..... 35
Pobreza y desarrollo infantil en Colombia ..... 35
Crianza e interacciones en el hogar ..... 39
Educación inicial y servicios de atención a la primera infancia ..... 43
Violencia en el hogar, las comunidades y en medio del conflicto armado ..... 47
Cambio climático y relación con la naturaleza ..... 54
Salud y nutrición ..... 58
Migración y desplazamiento forzados ..... 63
Nuevas tecnologías, inteligencia artificial y primera infancia ..... 69
Sistemas de datos, monitoreo y valoración del desarrollo infantil temprano ..... 73
Retornos a la inversión en la primera infancia ..... 77
Recomendaciones de política ..... 82
Calidad ..... 83
Datos e investigación ..... 84
Intersectorialidad y territorialización de la política ..... 85
Financiación ..... 86
Bibliografía ..... 88

# Resumen ejecutivo

La primera infancia, desde la gestación hasta los cinco años, constituye el periodo de mayor plasticidad neurobiológica y sienta las bases del desarrollo físico, cognitivo y socioemocional a lo largo del curso de vida. En Colombia, cerca de 4,5 millones de niñas y niños (8,3% de la población; DANE, 2025a) se encuentran en este rango de edad. Aunque la cobertura de las atenciones priorizadas de la Ruta Integral de Atenciones (RIA) alcanzó el 82% a nivel nacional en diciembre de 2024, esta cae a 54% en zonas rurales, evidenciando brechas territoriales persistentes que se profundizan por la violencia, la pobreza, las amenazas climáticas y el desplazamiento forzado.

Este documento, elaborado por el Colectivo de Investigación Multidisciplinar sobre Innovación en Niñez y Transformación Social (CIMIENTOS), sintetiza evidencia científica y de política pública sobre la primera infancia en Colombia con tres objetivos: analizar la situación del país en ámbitos clave frente a la política vigente, caracterizar las perspectivas de actores expertos de la academia, el sector público y organizaciones no gubernamentales y formular recomendaciones basadas en literatura, datos secundarios y entrevistas. La metodología combinó una revisión de literatura y un estudio cualitativo con 25 entrevistas semiestructuradas a informantes clave de institutos del Estado, ministerios, organismos multilaterales y academia, realizadas entre febrero y julio de 2026.

**Situación de la primera infancia en Colombia**

Los hallazgos evidencian rezagos importantes en múltiples dimensiones del desarrollo infantil. En materia de pobreza, la nueva Medida de Pobreza en la Niñez (MP-N) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), primer instrumento oficial centrado en privaciones individuales de la niñez, ubicó la pobreza de niñas, niños y adolescentes en 24,7% en 2025 (3,5 millones de menores), con una incidencia rural (45,8%) que casi triplica la urbana (16,1%) y que supera el 90% en Vichada y el 63,7% en Chocó (DNP, 2026). En cuanto a nutrición y salud, la medición indica que el 46,7% de la niñez enfrenta alimentación insuficiente o inadecuada y el 39,7% carece de cuidado parental adecuado (DNP, 2026). Frente al acceso a bienes de consumo, el informe señala que el 33,1% de

las niñas, niños y adolescentes no tiene computador en casa y que el 16,7% no tiene acceso a internet (DNP, 2026).

En crianza y prevención de la violencia, persisten prácticas violentas, donde cerca de 1,7 millones de niñas y niños han recibido castigo físico (Cuartas, 2018b), pese a que la tasa de violencia contra la primera infancia registrada por Medicina Legal descendió de 145,1 a 93,8 casos por 100.000 entre 2018 y 2023. En 2024 se notificaron 4.937 casos de violencia sexual y 13.732 de negligencia, y aunque programas basados en evidencia como Apapacho y Semillas de Apego muestran mejoras de hasta 0,31 desviaciones estándar en la calidad de la interacción cuidador-niño, aún no se han escalado totalmente.

En educación inicial, solo el 48,3% de niñas y niños de 0 a 5 años recibió atención integral en 2025 por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación Nacional (MEN), secretarías y cajas de compensación familiar (MEN, 2026c), con una brecha marcada entre la calificación docente en transición (95% con título profesional) y en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del ICBF (51%), y una calidad pedagógica promedio de apenas 2,34 sobre 4 en la última medición disponible (2017), lo que evidencia que la política ha priorizado la cobertura sobre la calidad de las interacciones.

En salud y nutrición, solo el 53,6% de las gestantes inicia control prenatal en el primer trimestre y la cobertura de vacunación (82,7%–89,4%) permanece por debajo de la meta del 95%, mientras la lactancia materna exclusiva cayó a 36,1% según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 2015, la más reciente disponible, y el sobrepeso infantil aumentó de 4,9% a 6,3%.

En cambio climático, violencia, migración y desplazamiento, el 47% del territorio nacional enfrenta riesgo alto o muy alto por temperaturas extremas, y Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos (7,2 millones; Defensoría del Pueblo, 2026), con una de cada cuatro niñas y niños en primera infancia viviendo en municipios afectados por la violencia, en un contexto donde las agendas climática, humanitaria y de desarrollo infantil continúan operando de forma desarticulada.

En tecnología y sistemas de datos, el 73% de niñas, niños y adolescentes tiene perfil en redes sociales, el 29% de ellos entre los 9 y 12 años, por debajo de la edad mínima permitida (Universidad de los Andes et al., 2024), y ninguna encuesta de hogares nacional incorpora mediciones directas del desarrollo infantil temprano, de modo que el país mide con solidez la cobertura, pero muy débilmente los procesos, la calidad y los posibles efectos de las nuevas tecnologías en la primera infancia.

La evidencia disponible confirma que la primera infancia constituye uno de los periodos de mayor retorno para la inversión pública. El invertir en educación inicial de calidad genera beneficios de entre 8 y 19 veces su costo (Nores et al., 2024), y programas colombianos como Semillas de Apego reportan relaciones beneficio-costo de entre 1,6 y 8,3 (Jaramillo & Bonet de Vivero, 2024). Incluso bajo supuestos conservadores de temporalidad y monetización, una estimación propia sitúa el retorno entre 1,3 y 1,5 veces la inversión, y hasta 2,0–2,5 veces si se asume una materialización más temprana de los beneficios, un resultado más modesto que las estimaciones internacionales pero consistente con ellas en dirección y orden de magnitud. La inversión temprana, en resumen, no compite con otras prioridades fiscales, sino que constituye la forma más costo-efectiva de prevenir el gasto reactivo que esas mismas prioridades terminan exigiendo más adelante.

**Oportunidades y recomendaciones de política**

Este panorama se produce en el marco de una política de Estado relativamente consolidada normativamente pero débil en su seguimiento. La Política De Cero a Siempre (DCAS) (Ley 1804 de 2016), coordinada por la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (CIPI), atiende integralmente a 1,8 millones de niñas y niños, con beneficios documentados en lenguaje que persisten hasta cinco años después (Bernal & Ramírez, 2018), y su cobertura pasó de cerca de 1,2 millones de niñas y niños en 2011 a 2,6 millones en 2024 (MEN, 2024). Estudios disponibles, (DNP, 2018; Yoshikawa et al., 2014) coinciden en señalar variabilidad territorial en la capacidad de implementación, debilidad en los mecanismos de evaluación de la calidad y sistemas de información desarticulados, y la Contraloría (2025) encontró que, pese a un cumplimiento formal del 95,47% del plan de mejoramiento del ICBF, su efectividad real fue de apenas 49,18%, en un contexto en el que tanto el propio ICBF (2024) como la Fiscalía General de la Nación (2025) han documentado hallazgos de corrupción en la prestación de servicios de primera infancia.

A partir de este diagnóstico, el documento organiza sus recomendaciones en cuatro dimensiones transversales relevantes a los temas priorizados en el reporte.

- **En calidad**, propone centrar la definición y medición de la calidad en las interacciones cotidianas con la primera infancia y en el bienestar de quienes cuidan, no solo en infraestructura o dotación, sino también en cambios estructurales para elevar y dignificar las labores de cuidado, traducir en estándares y en un sistema de seguimiento continuo, y fortalecer la formación y el acompañamiento del talento humano que presta estos servicios.
- **En datos e investigación**, plantea acordar un conjunto mínimo de indicadores y escalas comparables sobre desarrollo infantil temprano, armonizar las fuentes de datos existentes bajo protocolos de interoperabilidad, impulsar estudios geo-bioecológicos, longitudinales y rápidos, y poner los datos al servicio de la toma de decisiones mediante mecanismos de acceso abierto y responsable.
- **En intersectorialidad y territorialización**, recomienda reubicar la CIPI en la Presidencia de la República para restaurar su capacidad de convocatoria y seguimiento a ministerios e institutos y entidades territoriales, reconocer los entornos digitales y climáticos en la normativa de primera infancia, y fortalecer la respuesta institucional en emergencias humanitarias.
- **En financiación**, propone lograr un cambio estructural en la asignación presupuestal, incluyendo la educación inicial en el Sistema General de Participaciones, sustituir la contratación anual por esquemas plurianuales, financiar de forma permanente la medición de calidad, y garantizar que ninguna competencia se traslade al territorio sin sus recursos correspondientes.

En conjunto, CIMIENTOS sugiere que Colombia cuenta con un marco normativo robusto para la primera infancia, pero enfrenta una brecha persistente entre la formulación de política y su implementación efectiva. Esta brecha se refleja, entre otros aspectos, en la fragmentación de los sistemas de información; la insuficiencia de financiación estructural y sostenible; las limitaciones para adaptar las políticas, las atenciones, los servicios y los recursos a las realidades territoriales y a las necesidades diversas y cambiantes de sus poblaciones; la ausencia de objetivos compartidos

y de una comprensión transversal sobre la importancia de la primera infancia entre las distintas entidades y sectores del Estado y sus niveles; y la falta de mecanismos sistemáticos e independientes de seguimiento y evaluación. Cerrar estas brechas representa, de acuerdo con la evidencia nacional e internacional, una de las inversiones más costo-efectivas disponibles para el desarrollo del país.

# Executive summary

Early childhood, from gestation to age five, is the period of greatest neurobiological plasticity and lays the foundations for physical, cognitive, and socioemotional development across the life course. In Colombia, about 4.5 million children (8.3% of the population; DANE, 2025a) are in this age range. Although coverage of the prioritized services of the Comprehensive Care Pathway (Ruta Integral de Atenciones, RIA) reached 82% nationally in December 2024, it falls to 54% in rural areas, revealing persistent territorial gaps that are deepened by violence, poverty, climate threats, and forced displacement.

This document, prepared by the Multidisciplinary Research Collective on Innovation in Childhood and Social Transformation (CIMIENTOS, for its Spanish acronym), synthesizes scientific and policy evidence on early childhood in Colombia with three objectives: to analyze the country's situation in key domains in relation to current policy; to characterize the perspectives of expert stakeholders from academia, the public sector, and non-governmental organizations; and to formulate recommendations based on the literature, secondary data, and interviews. The methodology combined a literature review and a qualitative study with 25 semi-structured interviews with key informants from state institutes, ministries, multilateral organizations, and academia, conducted between February and July 2026.

**The situation of early childhood in Colombia**

The findings reveal significant gaps across multiple dimensions of child development. Regarding poverty, the new Child Poverty Measure (Medida de Pobreza en la Niñez, MP-N) of the National Planning Department (DNP), the first official instrument focused on children's individual deprivations, placed poverty among children and adolescents at 24.7% in 2025 (3.5 million minors), with a rural incidence (45.8%) nearly triple the urban rate (16.1%) and exceeding 90% in Vichada and 63.7% in Chocó (DNP, 2026). In terms of nutrition and health, the measure indicates that 46.7% of children face insufficient or inadequate diets and 39.7% lack adequate parental care (DNP, 2026). Regarding access to consumer goods, the report notes that 33.1% of children and adolescents do not have a computer at home and 16.7% lack internet access (DNP, 2026).

In parenting and violence prevention, violent practices persist: about 1.7 million children have experienced physical punishment (Cuartas, 2018b), even though the rate of violence against young children recorded by the National Institute of Legal Medicine (Medicina Legal) fell from 145.1 to 93.8 cases per 100,000 between 2018 and 2023. In 2024, 4,937 cases of sexual violence and 13,732 cases of neglect were reported, and although evidence-based programs such as Apapacho and Semillas de Apego show improvements of up to 0.31 standard deviations in the quality of caregiver–child interaction, they have not yet been fully scaled.

In early childhood education, only 48.3% of children aged 0 to 5 received comprehensive care in 2025 from the Colombian Family Welfare Institute (ICBF), the Ministry of National Education (MEN), local education secretariats, and family compensation funds (MEN, 2026c). There is a marked gap between teacher qualifications in the transition grade (95% with a professional degree) and in ICBF Child Development Centers (CDI) (51%), and average pedagogical quality scored just 2.34 out of 4 in the most recent available measurement (2017), showing that policy has prioritized coverage over the quality of interactions.

In health and nutrition, only 53.6% of pregnant women begin prenatal care in the first trimester, and vaccination coverage (82.7%–89.4%) remains below the 95% target, while exclusive breastfeeding fell to 36.1% according to the 2015 National Survey of Nutritional Status (ENSIN), the most recent available, and childhood overweight rose from 4.9% to 6.3%.

Regarding climate change, violence, migration, and displacement, 47% of the national territory faces high or very high risk from extreme temperatures, and Colombia has the second-largest internally displaced population in the world (7.2 million; Defensoría del Pueblo, 2026), with one in four young children living in municipalities affected by violence, in a context where the climate, humanitarian, and child development agendas continue to operate in isolation from one another.

In technology and data systems, 73% of children and adolescents have a social media profile, 29% of them between the ages of 9 and 12, below the minimum permitted age (Universidad de los Andes et al., 2024), and no national household survey includes direct measurements of early

childhood development. As a result, the country measures coverage robustly but measures processes, quality, and the potential effects of new technologies on early childhood only very weakly.

The available evidence confirms that early childhood is one of the periods with the highest returns on public investment. Investing in quality early childhood education yields benefits of 8 to 19 times its cost (Nores et al., 2024), and Colombian programs such as Semillas de Apego report benefit–cost ratios of 1.6 to 8.3 (Jaramillo & Bonet de Vivero, 2024). Even under conservative assumptions about timing and monetization, our own estimate places the return at 1.3 to 1.5 times the investment, and up to 2.0–2.5 times if benefits are assumed to materialize earlier—a more modest result than international estimates, but consistent with them in direction and order of magnitude. In short, early investment does not compete with other fiscal priorities; rather, it is the most cost-effective way to prevent the reactive spending that those same priorities end up requiring later on.

**Opportunities and policy recommendations**

This landscape unfolds within a state policy that is relatively well consolidated in legal terms but weak in its monitoring. The From Zero to Forever Policy (De Cero a Siempre, DCAS) (Law 1804 of 2016), coordinated by the Intersectoral Commission for Early Childhood (CIPI), provides comprehensive care to 1.8 million children, with documented language benefits that persist up to five years later (Bernal & Ramírez, 2018), and its coverage grew from about 1.2 million children in 2011 to 2.6 million in 2024 (MEN, 2024). Available studies (DNP, 2018; Yoshikawa et al., 2014) consistently point to territorial variability in implementation capacity, weak mechanisms for evaluating quality, and fragmented information systems. The Office of the Comptroller General (Contraloría, 2025) found that, despite formal compliance of 95.47% with ICBF's improvement plan, its actual effectiveness was only 49.18%, in a context in which both ICBF itself (2024) and the Office of the Attorney General (Fiscalía General de la Nación, 2025) have documented findings of corruption in the provision of early childhood services.

Based on this diagnosis, the document organizes its recommendations into four cross-cutting dimensions relevant to the topics prioritized in the report.

- **On quality**, it proposes centering the definition and measurement of quality on everyday interactions with young children and on the well-being of caregivers—not only on infrastructure or equipment, but also on structural changes that elevate and dignify care work—translating this into standards and a continuous monitoring system, and strengthening the training and coaching of the workforce that delivers these services.
- **On data and research**, it calls for agreeing on a minimum set of comparable indicators and scales for early childhood development, harmonizing existing data sources under interoperability protocols, promoting geo-bioecological, longitudinal, and rapid studies, and putting data at the service of decision-making through open and responsible access mechanisms.
- **On intersectorality and territorialization**, it recommends relocating the CIPI to the Office of the President of the Republic to restore its capacity to convene and monitor ministries, institutes, and territorial entities; recognizing digital and climate environments in early childhood regulations; and strengthening the institutional response to humanitarian emergencies.
- **On financing**, it proposes a structural shift in budget allocation, including early childhood education in the General System of Transfers (Sistema General de Participaciones), replacing annual contracting with multi-year arrangements, permanently funding quality measurement, and ensuring that no responsibility is transferred to the territorial level without its corresponding resources.

Overall, CIMIENTOS suggests that Colombia has a robust legal framework for early childhood but faces a persistent gap between policy formulation and effective implementation. Among other aspects, this gap is reflected in the fragmentation of information systems; insufficient structural and sustainable financing; limited capacity to adapt policies, services, programs, and resources to territorial realities and to the diverse and changing needs of local populations; the absence of shared goals and of a cross-cutting understanding of the importance of early childhood across state entities, sectors, and levels of government; and the lack of systematic, independent monitoring and evaluation mechanisms. According to national and international evidence, closing these gaps represents one of the most cost-effective investments available for the country's development.

# Introducción

El desarrollo en la primera infancia, desde la gestación hasta los cinco años, establece en gran parte los cimientos para la salud física, la salud mental, el aprendizaje, las trayectorias socioeconómicas y el bienestar a lo largo de la vida (Black et al., 2017; Draper et al., 2024; Nores et al., 2024). Por esto, las políticas públicas y programas de desarrollo infantil temprano son una de las bases más importantes del desarrollo individual, familiar, cognitivo, comunitario y social. Las capacidades de un país para construir una sociedad próspera, en paz y en armonía con el medio ambiente dependen de su éxito en promover generaciones que alcancen su potencial de desarrollo, empezando desde la primera infancia. El costo de la inacción, es decir, no invertir en políticas y programas de desarrollo infantil, es extremadamente alto y puede limitar el desarrollo y progreso individual, comunitario, social y global. Por ejemplo, un estudio reciente estima que el costo de no invertir en educación y cuidado inicial de calidad puede corresponder a pérdidas entre el 0,7% y el 6,8% del producto interno bruto (PIB), mientras que invertir en estos elementos traería beneficios que son de ocho a 19 veces mayores a los costos de implementar dichas inversiones (Nores et al., 2024).

La situación de las niñas y niños en Colombia ha tenido avances significativos en los últimos años, pero también enfrenta retos para la garantía de sus derechos y la promoción de su pleno desarrollo. De acuerdo a las proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2025a), prevalecía un promedio de 4,5 millones de niñas (48,9%) y niños (51,1%) en el periodo de primera infancia, lo cual corresponde a un poco más del 8,5% de la población del país. De estos, un 82% tenía acceso a seis de las diez atenciones priorizadas por la política pública en diciembre de 2024, con importantes brechas a nivel regional (MEN, 2024). Aún millones no tienen acceso a una educación inicial de calidad, sufren de violencia en el hogar (como por ejemplo castigo físico o violencia psicológica) y en sus comunidades, viven en hogares en situación de pobreza o en zonas afectadas por amenazas climáticas, han sido discriminados por su raza o estatus socioeconómico, o han sido víctimas del conflicto armado o de desplazamiento forzado, entre otras adversidades e inequidades estructurales (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013; Cuartas, 2021; Gobierno de Colombia, 2023).

En este marco, la Política Nacional De Cero a Siempre (DCAS) marcó un punto de inflexión al articular diversos programas dirigidos a promover el desarrollo integral de niñas y niños, con el doble propósito de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios. En efecto, actualmente 1,8 millones de niñas y niños en primera infancia reciben una atención integral por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mediante modalidades institucionales, familiares y comunitarias, y propias e interculturales. Estudios empíricos muestran que, al ofrecer de forma integral servicios de nutrición, salud, y educación temprana adaptada a cada edad, DCAS ha tenido beneficios significativos en las capacidades de lenguaje, los cuales persisten incluso cinco años después (Bernal & Ramírez, 2018).

En el 2014, expertos de universidades internacionales y UNICEF realizaron una evaluación externa de los mecanismos de implementación, gobernanza, financiación y sostenibilidad de la Estrategia Integral de Desarrollo de la Primera Infancia en Colombia (Yoshikawa et al., 2014). En este informe se resaltan fortalezas como la coordinación de diferentes sectores y disciplinas, desde el nivel nacional hasta el local; la inversión sustancial en la infancia; las capacitaciones de calidad a los prestadores de servicios, tal como las madres comunitarias; y el uso innovador de servicios basados en la comunidad para alcanzar a poblaciones rurales. De igual forma, el informe resalta desafíos como la variabilidad en la articulación de actores locales; las dificultades para alcanzar cobertura integral en áreas rurales; la falta de mecanismos efectivos para evaluar la calidad de la implementación; y la falta de alineación entre los sistemas de datos centralizados y locales.

Informes de gestión del Diálogo Interamericano en 2024 y del Estado (ICBF, 2023) han dado cuenta de los avances y retos desde el 2014, como el continuo enfoque en la cualificación del talento humano y la persistencia de dificultades con la consolidación de la arquitectura institucional y con capitalizar los avances en cobertura para ahora promover mayor calidad en los servicios y atenciones. Del mismo modo, investigaciones empíricas han examinado aspectos específicos de los logros y los desafíos de DCAS; por ejemplo, Rojas Romero et al. (2025) establecieron que sólo 54% de las niñas y niños en áreas rurales tienen cobertura universal de las atenciones priorizadas, y que todavía falta adecuación de la estrategia a las prácticas culturales y

sociales de cada región. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado una evaluación integral de los diferentes aspectos de la implementación de DCAS por parte de expertos externos al Estado.

En este contexto, es importante construir sobre las evaluaciones, informes de progreso y otras investigaciones en Colombia para entender la situación actual de la primera infancia en dimensiones clave y coyunturales, para así contribuir a esfuerzos existentes para informar la política, investigación y conversación pública en torno a la promoción del desarrollo infantil temprano en el país.

## La ciencia del desarrollo en la primera infancia

La primera infancia, es decir, el periodo que comprende desde el embarazo hasta los cinco años de edad (como se establece en DCAS), es un periodo de inmenso potencial. Durante este momento del curso de vida, el sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, digestivo y demás sistemas biológicos se desarrollan articuladamente y de forma rápida (Berens & Nelson, 2019; Knudsen, 2004; Knudsen et al., 2006). Si bien los genes dan un "plano" o guía general del curso del desarrollo, la ciencia del desarrollo humano ha demostrado que son los entornos y las experiencias los que terminan de moldear ese desarrollo en una danza recíproca entre genes y experiencias (Berens & Nelson, 2019; Britto et al., 2017; Draper et al., 2024; Jensen et al., 2017; Wachs & Rahman, 2013). La primera infancia, de hecho, se considera un periodo sensible del desarrollo ya que es el momento con mayor neuroplasticidad (esto es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento) a lo largo del curso de vida (Knudsen, 2004). En otras palabras, los entornos y experiencias durante la primera infancia moldean el cerebro, y por ende los demás sistemas biológicos y el desarrollo, y de esta forma establecen las bases para el aprendizaje, salud física, salud mental y bienestar a lo largo de la vida (Black et al., 2017; National Scientific Council on the Developing Child, 2020; Nores et al., 2024).

De acuerdo con DCAS, el desarrollo infantil temprano es comprendido como un derecho, una responsabilidad compartida y es definido como un proceso integral de transformaciones que ocurre desde la gestación hasta los cinco años de edad, en el cual interactúan factores biológicos, emocionales y sociales que permiten desplegar progresivamente las potencialidades de las niñas y los niños para vivir plenamente (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2016). El

desarrollo es situado: ocurre en interacción con los entornos y por esto depende de las oportunidades, los vínculos afectivos y las experiencias de cuidado en contexto.

La ciencia del desarrollo de la primera infancia, expuesta en la literatura de la psicología del desarrollo, pediatría, neurociencia, economía y salud pública (entre otras disciplinas), sugiere que el desarrollo temprano se compone de distintas áreas o dominios que pueden entenderse de forma individual pero también están profundamente interconectados de forma tal que "habilidades generan habilidades" (Masten & Cicchetti, 2010; McCoy, 2022; Tamis-LeMonda, 2022). Por ejemplo, niñas o niños con mayores habilidades sociales que interactúen de forma asertiva con adultos y pares podrían promover así más interacciones y oportunidades de aprendizaje que promueven su desarrollo cognitivo. Reconocer la singularidad (e interconexión) entre áreas o dominios es crítico para atender las necesidades puntuales de las niñas y los niños y así brindar atenciones pertinentes y efectivas. Por ejemplo, una niña o niño podría tener rezagos en su desarrollo socioemocional por lo que la política pública debería poder estructurar sistemas de medición y monitoreo que permitan identificar dichas particularidades y garantizar servicios, atenciones, programas e intervenciones específicos para promover el desarrollo socioemocional, lo que a su vez, promovería otros procesos de desarrollo, como el desarrollo cognitivo.

A pesar de la importancia de reconocer las áreas o dominios del desarrollo, en la política colombiana aún no existe un consenso sobre cómo organizar o estructurarlos. Por ejemplo, la Escala Abreviada del Desarrollo (Peñuela et al., 2017), utilizada principalmente por el Ministerio de Salud para identificar tempranamente riesgo de rezagos en el desarrollo de forma cuantitativa, diferencia entre el desarrollo (1) motor grueso, (2) motor-fino, (3) audición y lenguaje y (4) personal-social. Por su parte, la Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil (ICBF, 2016), utilizada ampliamente por el ICBF y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), propone tres tipos de relaciones (con los demás, consigo mismo, con el mundo) desde las que pueden observarse "procesos psicológicos y áreas del desarrollo" incluyendo (1) comunicación (verbal y no verbal), (2) interacción (independencia y cooperación), (3) construcción de normas (autonomía), (4) identidad (social, personal y de género), (5) autoestima, (6) manejo corporal, (7) conocimiento de los objetos, (8) relaciones de causalidad, (9) representación de la realidad social. Así mismo, el componente de valoración del desarrollo en la Medición de la Calidad de la

Educación Inicial en Colombia (Maldonado-Carreño et al., 2022) considera el desarrollo (1) cognitivo, (2) social, (3) emocional, (4) comunicativo y (5) motor. En otros documentos oficiales (MEN, 2010) se discute el desarrollo (1) cognitivo, (2) lingüístico, (3) social y (4) afectivo. Por último, en estudios poblacionales como la Encuesta Longitudinal de Colombia (ELCO) y la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) se utilizan otros instrumentos como el Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP) o el Ages and Stages Questionnaires (ASQ), que utilizan otros dominios distintos.

A su vez, a nivel internacional los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4.2.1 (United Nations Development Programme, 2015) consideran tres dominios generales del desarrollo, cada uno constituido por diferentes subdominios. Primero, el dominio salud, compuesto por desarrollo motor grueso, motor fino y autocuidado. Segundo, aprendizaje, compuesto por lenguaje expresivo, alfabetización, competencia matemática, escritura, función ejecutiva. Por último, el bienestar psicosocial, compuesto por habilidades emocionales, habilidades sociales, comportamientos internalizantes y comportamientos externalizantes.

Con el objetivo de sintetizar y organizar lo expuesto en la ciencia, la política nacional y los objetivos de política global, en la presente investigación consideramos la siguiente taxonomía, con dominios como componentes interconectados del desarrollo en la primera infancia:

1. *Cognitivo*, incluidas habilidades para procesamiento de información, la memoria, y habilidades de razonamiento. También consideramos acá la función ejecutiva, a pesar que reconocemos esta también tiene componentes sociales y emocionales y hay discusión en el campo sobre su clasificación.
2. *Lenguaje*, incluyendo lenguaje receptivo (ej. identificación de letras y entendimiento de lenguaje escrito y hablado) y expresivo (ej. hablar o escribir)
3. *Motor*, incluyendo desarrollo motor fino (ej. manipulación de objetos pequeños) y grueso (ej. sentarse, saltar, caminar).
4. *Social y emocional*, incluyendo comportamientos prosociales, autorregulación, empatía, y habilidades de resolución de conflictos

5. *Salud mental y comportamental*, incluyendo problemas internalizantes (relacionados a miedo, tristeza, o problemas somáticos) y externalizantes (asociados a agresividad e impulsividad).

La Tabla 1 presenta una correspondencia inicial entre los dominios considerados por los principales instrumentos y marcos de referencia nacionales e internacionales y la taxonomía adoptada en esta investigación. Este ejercicio permite identificar puntos de convergencia entre las distintas clasificaciones, así como organizar sus componentes bajo un marco común para el análisis del desarrollo integral en la primera infancia. No obstante, es necesario trabajar en una taxonomía unificada entre sectores para garantizar así un lenguaje común que facilite el avanzar en los objetivos estratégicos relacionados con la primera infancia en el país.

**Tabla 1**. Escalas y marcos organizados por la taxonomía propuesta

| | | **Escalas y marcos** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Taxonomía propuesta** | | Escala Abreviada del Desarrollo (Peñuela et al., 2017) | Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil (ICBF, 2016) | Medición de la Calidad de la Educación Inicial en Colombia (Maldonado-Carreño et al., 2022) | Modelos usados por el Ministerio de Educación (MEN, 2010) | ODS 4.2.1 (United Nations Development Programme, 2015) |
| **Dominios** | Cognitivo y función ejecutiva | N/A | -Conocimiento de los objetos<br>-Relaciones de causalidad<br>-Representación de la realidad social | -Cognitivo | -Cognitivo | -Aprendizaje (competencia matemática y función ejecutiva) |
| | Lenguaje | -Audición y lenguaje | -Comunicación (verbal y no verbal) | -Comunicativo | -Lingüístico | -Aprendizaje (lenguaje expresivo, alfabetización, escritura) |
| | Motor | -Motor-fino<br>-Motor grueso | -Manejo corporal | -Motor | N/A | -Salud (desarrollo motor grueso, motor fino) |
| | Social y emocional | -Personal-social | -Interacción (independencia y cooperación)<br>-Construcción de normas (autonomía)<br>-Identidad (social, personal y de género) | -Social<br>-Emocional | -Social<br>-Afectivo | -Salud (autocuidado)<br>-Bienestar psicosocial (habilidades emocionales, habilidades sociales) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Salud mental y comportamental | N/A | -Autoestima | N/A | N/A | -Bienestar psicosocial (comportamientos internalizantes y comportamientos externalizantes) |

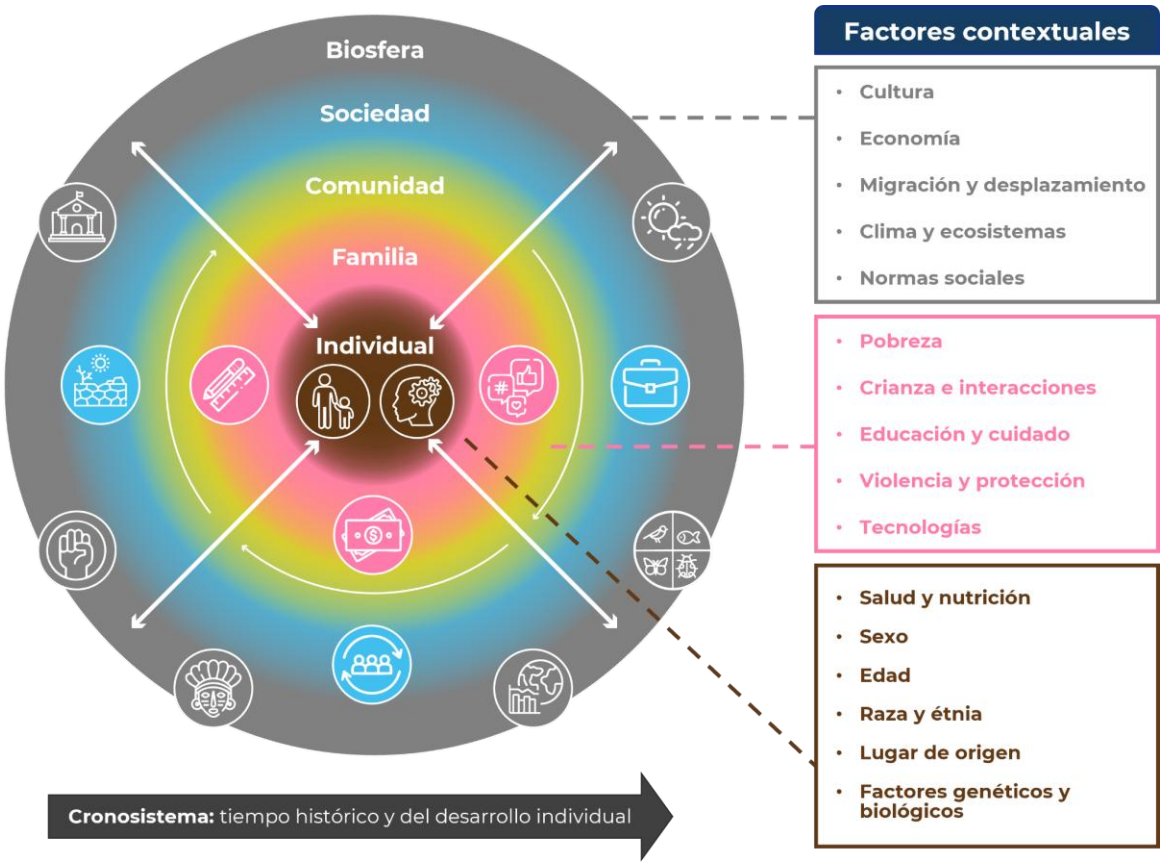
## Los contextos de desarrollo de la primera infancia

El desarrollo humano, incluyendo el desarrollo cognitivo y de las funciones ejecutivas, del lenguaje, motor, social y emocional, la salud mental y comportamental, se produce en la interrelación de los sistemas individuales, familiares, comunitarios, institucionales, sociales, culturales y medioambientales. Esta perspectiva del desarrollo, propuesta en el modelo bioecológico del desarrollo (Bronfenbrenner & Morris, 2006) y ampliada recientemente en el modelo geo-bioecológico del desarrollo (Cuartas & Morris-Perez, 2026), permite dar una mirada holística y situada al desarrollo humano.

De acuerdo con la perspectiva geo-bioecológica (Cuartas & Morris-Perez, 2026), la interacción entre características individuales y los distintos contextos, junto con el curso del tiempo histórico y el transcurso de la vida de una persona, establece el desarrollo infantil temprano (ver Figura 1). Factores como la biología y psicología individual, la disponibilidad de bienes y servicios básicos, la educación de madres y padres, los comportamientos parentales (ej. involucramiento en actividades de aprendizaje temprano y métodos de crianza), la asistencia a centros de educación y cuidado inicial, la disponibilidad de espacios verdes y agua limpia, la seguridad o violencia en la comunidad, las condiciones laborales de madres, padres o cuidadores, el conflicto armado, las políticas públicas, las normas sociales, y la temperatura ambiental y calidad del aire (entre otros) son fundamentales para entender el desarrollo.

Una propiedad central de la perspectiva ecológica es la *reciprocidad*: el contexto influye en el desarrollo humano tanto como el desarrollo influye en el contexto. La niña o el niño en desarrollo es un actor activo en su propio proceso de desarrollo, y alcanzar su potencial de desarrollo es crítico para también promover un desarrollo comunitario, social y medioambiental positivo.

**Figura 1.** Modelo geo-bioecológico de desarrollo humano




Fuente: elaboración de los autores y diagramación del diseñador Felipe Perdomo, con base en Cuartas y Morris-Perez (2026)

## Marco de política de primera infancia y evaluaciones de la política

DCAS, promulgada como política de Estado mediante la Ley 1804 de 2016 para garantizar su continuidad más allá de los gobiernos de turno, asigna a la CIPI el papel de eje coordinador institucional en su implementación. A partir de allí, la política se despliega en programas territoriales adaptados al contexto de niñas y niños, que se concretan en atenciones dirigidas a ellos. Estas atenciones buscan fortalecer los sistemas, servicios, programas e intervenciones estructurantes, así como los esquemas de gobernanza y financiación, que inciden de manera sustancial en los entornos de desarrollo y, por tanto, en el desarrollo infantil temprano.

**Definiciones básicas relacionadas con las políticas de primera infancia**

- **Políticas:** Conjunto de decisiones, acciones y estrategias que adopta el Estado, en colaboración con la sociedad, para identificar, atender y resolver problemas colectivos o para garantizar derechos y promover el bienestar social. En este documento, nos enfocamos en políticas de desarrollo infantil que buscan beneficiar a niñas y niños directa o indirectamente a través de servicios, programas e intervenciones.
- **Sistemas:** La estructura institucional que articula servicios, programas e intervenciones para dar respuesta integral, coherente y sostenida a necesidades sociales. En otras palabras, son conjuntos organizados de instituciones, normas, actores, recursos y acciones que trabajan de forma coordinada para alcanzar un objetivo común. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar coordina acciones para garantizar los derechos y desarrollo de las niñas y los niños.
- **Servicios:** Acciones o prestaciones continuas y estructuradas para satisfacer necesidades o garantizar derechos de la población. Por ejemplo, los Servicios de Educación Inicial que ofrece el ICBF.
- **Atenciones:** Concepto central en DCAS que se refiere a las acciones intencionadas orientadas a garantizar que los entornos donde los niños y niñas se desarrollan tengan las condiciones que garanticen el pleno desarrollo infantil (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013). Las atenciones se organizan en la RIA.
- **Estructurantes:** En DCAS, los estructurantes son los mecanismos que hacen posible que las atenciones sean integrales, coordinadas y sostenibles. Incluyen 1) cuidado y crianza de la niñez; 2) salud, alimentación y nutrición; 3) educación temprana; 4) recreación; y 5) ejercicio de la ciudadanía y participación.
- **Programas e intervenciones:** Conjuntos organizados de acciones, planificadas usualmente mediante una teoría de cambio y con base en evidencia, que buscan generar un cambio medible en variables de resultado específicas para una población en un contexto y tiempo determinado.
- **Gobernanza**: Políticas, procesos, asignación de recursos y mecanismos mediante los que se toman decisiones, asignan responsabilidad, coordinan acciones, y gestionan políticas públicas y servicios.
- **Sistemas de financiación**: Procesos y mecanismos de financiamiento, incluyendo asignación de rubros presupuestales, recursos y la estimación de costos de los servicios, programas e intervenciones.
- **Entornos**: Espacios físicos, sociales y culturales donde las niñas y los niños se desarrollan. En DCAS, se enfatiza el entorno del hogar, el entorno de la institución de salud, el entorno educativo y el entorno del espacio público.

Reconociendo la importancia de invertir en la primera infancia, Colombia estableció la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia "De Cero a Siempre" (Ley 1804 de 2016), diseñada por la CIPI, que busca promover el desarrollo infantil a través de esfuerzos intersectoriales que articulen y promuevan los planes, programas, proyectos y acciones para

brindar la atención integral a cada niña o niño de acuerdo con su edad, contexto y condición (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013).

DCAS busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de niñas y niños de cero a cinco años de edad. La estrategia está cimentada en la Constitución Política de Colombia (1991) y en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), y define el desarrollo como el proceso singular de transformaciones no lineales o universales, sino particulares a cada individuo. Al igual que la Ley 1098 de 2006, se enmarca en el principio de corresponsabilidad, desde el cual las acciones estratégicas deben ser lideradas por el Estado, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de niñas y niños. De este modo, DCAS busca pasar de un modelo fragmentado de servicios a la infancia a un modelo de programas institucionalizados completamente integrados, con el doble propósito de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios.

La integralidad de DCAS se refleja en los diversos sectores que integran la CIPI. Establecida en el Decreto 4875 de 2011, esta Comisión estaba integrada inicialmente por la Presidencia de la República; los ministerios de Salud y Protección Social, Educación, y Cultura; el DNP; el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS); y el ICBF. Más adelante, el Decreto 695 de 2023 expandió la Comisión para incluir también a los ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio, y de Deporte; al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE); a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); y la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Esta reciente expansión refleja la perspectiva de derechos que caracteriza a DCAS. Se concibe a niñas y niños como sujetos de derechos que participan en la vida de la sociedad y se desarrollan a partir de la interacción con otros, por lo cual requieren que los adultos a su alrededor garanticen las condiciones de calidad necesarias para su edad, características, y capacidades particulares (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013). Así, la estrategia es tanto exhaustiva como flexible, pues busca ofrecer los múltiples apoyos necesarios para la salud, aprendizaje y comportamiento infantil con una generalidad que permite modificaciones y adaptaciones a nivel local e individual (Yoshikawa et al., 2014).

**Oportunidades y desafíos para la primera infancia en Colombia**

La política nacional DCAS marcó un punto de inflexión al integrar y articular diversos programas dirigidos al cuidado y la promoción del desarrollo infantil, con el doble propósito de ampliar su cobertura y calidad. Un informe de progreso de políticas de primera infancia en Colombia demuestra que el país ha logrado avances significativos en intersectorialidad, cobertura y medición del desarrollo infantil, entre otros (NiñezYa, 2024). Por ejemplo, en cobertura, antes del lanzamiento de De Cero a Siempre, alrededor del 2011, aproximadamente 1,2 millones de niños eran atendidos a través de programas comunitarios basados en el hogar; en 2024, el número de niños cubiertos ascendió a alrededor de 2,6 millones (MEN, 2024). Como otro ejemplo, mediante el establecimiento del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDIPI) se observa que a corte diciembre de 2024 un 82% de niñas y niños menores de 6 años recibían seis de las 10 atenciones priorizadas en la política pública, con brechas marcadas ya que tan sólo un 54% recibía dicha cantidad en zonas rurales y 56% en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (MEN, 2024). Esto representa un avance considerable frente al 2022, cuando tan sólo 53% de niñas y niños recibían al menos seis atenciones priorizadas.

A pesar de avances significativos, el país enfrenta retos y oportunidades para realizar el potencial de DCAS y promover el pleno desarrollo infantil temprano. Uno de ellos es la financiación. La inversión en primera infancia del Presupuesto General de la Nación pasó de cerca de $5,0 billones en 2018 a $5,9 billones en 2021 y a $7 billones en 2024 (ICBF, 2025a). Sin embargo, este crecimiento ha sido principalmente nominal: ajustados por inflación, los recursos de 2024 se ubican por debajo del nivel de 2018, que equivaldría a cerca de $7,3 billones a precios de 2024. Además, considerando todas las fuentes de financiación, la inversión en primera infancia representó alrededor del 0,83% del PIB en 2024 (unos $7 millones por niño al año), por debajo del 1,16% del PIB estimado por CEPAL y ONU Mujeres para financiar sistemas integrales de cuidado (ONU Mujeres & Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022). Es entonces claro que hay oportunidades de incrementar dicha inversión para maximizar la cobertura y calidad de las atenciones.

Por otra parte, la expansión de la cobertura y atenciones no siempre ha estado acompañada por un aseguramiento riguroso de la calidad de las atenciones y servicios. Como se mencionó

anteriormente, desde 2014, una evaluación externa (Yoshikawa et al., 2014) ya señalaba que el monitoreo de atenciones y servicios a menudo se limitaba a la verificación de listas de chequeo sobre condiciones estructurales, sin capturar adecuadamente la "calidad de proceso," es decir, la riqueza y calidez de las interacciones pedagógicas y de cuidado. Este desafío ha persistido, como se refleja en informes recientes del ICBF (2023) y la Medición de la Calidad de la Educación Inicial en Colombia (Maldonado-Carreño et al., 2022).

Un posible factor que ha dificultado monitorear y mejorar la calidad de atenciones y servicios puede relacionarse con la valoración de la calidad y la recolección de información fiable y robusta sobre calidad. Por ejemplo, si bien el SSDIPI recoge información crucial sobre acceso a atenciones, acceso o cobertura no son lo mismo que calidad, o no reflejan, por ejemplo, el estado del desarrollo de las niñas y niños o las características de los contextos donde se desarrollan. Un reporte reciente de UNICEF muestra que Colombia sobresale en la región en cuanto a utilizar múltiples instrumentos para valorar el desarrollo infantil de manera poblacional, en el sector educativo y en el sector salud (Garibotto & Curbelo, 2023), lo cual ha potenciado aún más con otros avances tales como la Medición de la Calidad de la Educación Inicial en Colombia (Maldonado-Carreño et al., 2022). No obstante, el país aún enfrenta el reto de incorporar valoraciones del desarrollo infantil confiables y válidas en sistemas nacionales y longitudinales, que permitan hacer seguimiento en el tiempo, y donde pueda explorarse cómo políticas, programas, servicios y factores contextuales influyen en el desarrollo de la primera infancia.

Otra limitante que afecta la calidad de las atenciones ha sido el reto en la gobernanza de la política, la cual ha sido afectada por la corrupción (Fiscalía General de la Nación, 2017) y la dificultad en la coordinación entre las entidades responsables (Departamento Nacional de Planeación, 2018), las cuales ocurren en tres niveles: 1) nacional; 2) gobierno nacional y territorial; y 3) la dirección central del ICBF y las direcciones regionales.

En términos de corrupción, el ICBF (2024) y la Fiscalía General de la Nación (2025) han denunciado actos de corrupción por parte de algunos de los operadores, los cuales los cometen con el objetivo de beneficiarse financieramente (Fiscalía General de la Nación, 2025). Entre los actos ilegales que se resaltan están: desarrollar sus servicios en un menor tiempo al establecido

contractualmente, inflar los precios de los alimentos y, por último, la presentación de información financiera inexacta para demostrar una capacidad operativa superior a la real. Así mismo, el ICBF menciona que los operadores están conectados con clanes políticos (ICBF, 2024).

Respecto al estado de la arquitectura institucional de la CIPI, los principales retos que enfrentan las instituciones son en materia de coordinación. En primer lugar, entre las entidades a nivel nacional, el principal reto que se identifica es la dificultad en la coordinación en la transición de los niños y niñas de los programas del ICBF a los programas educativos del Ministerio de Educación (Departamento Nacional de Planeación, 2018). Esta limitante también se encuentra sustentada en la evaluación realizada por Bernal y Ramírez en 2018, que menciona que la atenuación de los efectos positivos sobre el lenguaje infantil entre el 2013 y 2016 podría deberse a que no hubo coordinación plena con el sector de educación formal para la transición de los niños (Bernal & Ramírez, 2018).

El desafío en la coordinación a nivel nacional con las alcaldías locales se presenta en la asimetría estructural entre quien diseña y quien ejecuta. El nivel nacional define lineamientos técnicos (RIA, rutas curriculares, orientaciones), pero el territorio los recibe con capacidad técnica, financiera y de talento humano desigual y, sobre todo, inestable por la alta rotación asociada a contratos de prestación de servicios (Departamento Nacional de Planeación, 2018).

Finalmente, la supervisión por parte de la Dirección de Primera Infancia del ICBF a las direcciones regionales es un tema menos documentado; no obstante, un dato de la Contraloría en el seguimiento de la Política de Cero a Siempre es que el ICBF cumplió formalmente el 95,47% de su plan de mejoramiento, pero su efectividad real fue de apenas 49,18%, con fallas que ya habían sido objeto de observaciones en vigencias anteriores. Eso apunta a un reto de seguimiento y corrección efectiva: el nivel central emite instrucciones y las regionales reportan cumplimiento en el papel, pero en el control interno se dificulta verificar y corregir la ejecución real en el terreno, permitiendo que los mismos hallazgos se repitan período tras período (Contraloría de la República, 2025).

## Objetivos

En este contexto de grandes progresos, retos y oportunidades, el propósito del presente documento es realizar un diagnóstico de algunos temas específicos del marco de política y la situación actual de la primera infancia en Colombia e identificar recomendaciones de política que beneficien el ecosistema de esta población. Específicamente, el estudio tiene tres objetivos:

1. Analizar la situación de la primera infancia en Colombia en ámbitos identificados a partir de la literatura y de datos secundarios, y examinar su relación con la política pública vigente.
2. Caracterizar las perspectivas y recomendaciones de política de personas expertas de la academia, sector público y organizaciones no gubernamentales en relación a la primera infancia en Colombia.
3. Sintetizar recomendaciones de política sobre la primera infancia con base en la revisión de literatura, datos secundarios y perspectivas y recomendaciones de expertas y expertos.

El documento no presentará un diagnóstico exhaustivo ni revisión sistemática de toda la literatura o información sobre la primera infancia. Por ejemplo, este documento no cubrirá extensamente temas esenciales tales como tendencias demográficas (entre otros) que ya han sido ampliamente explorados en otros esfuerzos. Lo que buscará es participar en las conversaciones y esfuerzos existentes en el país y examinar algunos factores de riesgo y protección que, de acuerdo con la evidencia recolectada, deben ser considerados de forma significativa en los próximos años en la política pública de primera infancia en Colombia.

# Métodos

En este estudio realizamos (a) una revisión de literatura y (b) un estudio cualitativo descriptivo (Creswell & Plano Clark, 2017) sobre las perspectivas y recomendaciones de política de personas expertas de la academia, sector público y organizaciones no gubernamentales en relación a la primera infancia en Colombia. El componente cualitativo del estudio, incluyendo la recolección de información mediante entrevistas a informantes clave realizadas entre febrero y julio de 2026, fue aprobado por el comité de ética de la Universidad del Norte el día 27 de noviembre del 2025 mediante el acta número 347.

## Revisión de literatura

Un primer componente de este estudio fue una revisión de literatura sobre la primera infancia. Para dicha revisión, todos los autores de la investigación, que tienen diversa experticia en temas específicos de primera infancia, hicieron un listado sobre los ejes temáticos a priorizar en el documento, al igual que artículos clave relacionados que se consideró debían informar el trabajo.

Después de esto, se realizaron búsquedas de literatura adicional en Google Scholar y SciELO, utilizando palabras clave en español e inglés relacionadas con primera infancia (e.g., “desarrollo infantil temprano”; “early childhood”) y los ejes temáticos priorizados por el grupo investigador, incluyendo pobreza (e.g., “pobreza infantil”; “child poverty”), crianza (e.g., “disciplina infantil”; “parenting”), educación inicial (e.g., “pre-k”; “care and education”), conflicto y violencia (e.g., “críimen”; “armed conflict”), desplazamiento (e.g., “desplazado”; “internal displacement”; “migrante”; “migración forzada”), cambio climático y naturaleza (e.g., “desastres naturales”; “climate change”) y nuevas tecnologías (e.g., “redes sociales”; “inteligencia artificial”).

## Estudio cualitativo con informantes clave

*Selección de la muestra*

Cuarenta y siete personas mayores de 18 años fueron invitadas a participar en entrevistas semiestructuradas para conocer sus perspectivas sobre los avances, retos y recomendaciones de

política sobre primera infancia. Para ser elegibles, las personas debieron participar en el desarrollo o implementación de políticas públicas, programas o investigaciones relacionados a políticas públicas o programas de primera infancia en Colombia. El muestreo fue intencional y la invitación a hacer parte del estudio se realizó a través de un mensaje vía correo electrónico adjuntando el consentimiento informado y la descripción del estudio. Posteriormente, cada miembro del grupo investigador agendó entrevistas virtuales con los individuos que consintieron participar en el estudio.

De las 47 invitaciones, se realizaron 25 entrevistas con 24 personas involucradas con la Política Nacional de DCAS y entidades e instituciones del Gobierno (ej. ICBF, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar), ministerios, organizaciones no gubernamentales y multilaterales (ej. UNICEF, Red PaPaz, aeioTU) y en universidades (ej. Universidad Pedagógica, Universidad del Norte, Universidad de los Andes). La Tabla 2 presenta una descripción del perfil de las personas entrevistadas.

**Tabla 2.** Sociodemográficos de personas entrevistadas

| | (*n* = 24) |
|---|---|
| Rango de edad, *n (%)* | |
| 35-44 | 6 (25,0%) |
| 45-54 | 10 (41,7%) |
| 55-64 | 5 (20,8%) |
| 65 o más | 3 (12,5%) |
| Género, *n* femenino (%) | 18 (75,0%) |
| Educación, *n* (%) | |
| Pregrado | 3 (12,5%) |
| Especialización | 1 (4,2%) |
| Maestría | 10 (41,7%) |
| Doctorado | 10 (41,7%) |
| Tipo de institución, *n* (%) | |
| Universidad | 8 (33,3%) |
| Entidad pública | 7 (29,2%) |

| | |
|---|---|
| Empresa social / ONG | 5 (20,8%) |
| Multilateral | 2 (8,3%) |
| Consultoría independiente | 2 (8,3%) |
| Años de experiencia en Primera Infancia o tema relacionado, *M [rango]* | 22,1 [13 – 50] |
| No reportado, n (%) | 8 (33,3%) |

*Nota: M = media; n = número de participantes.*

*Instrumento para las entrevistas*

Se utilizó un instrumento semiestructurado con 18 preguntas orientadoras para guiar la entrevista, dejando espacio también para una conversación abierta que condujera a preguntas adicionales de seguimiento para profundizar en temáticas a medida que avanzaba la entrevista. El instrumento semiestructurado constó de siete secciones:

1. *Introducción y confirmación verbal de consentimiento informado*: breve presentación del estudio y del/la investigador/a, explicación del propósito y duración de la entrevista, y confirmación verbal del consentimiento informado previo al inicio.

2. *Datos sociodemográficos básicos*: recoge información general sobre la persona entrevistada (como edad, género, nivel educativo, cargo e institución, ámbito de trabajo y años de experiencia) junto con una breve descripción de su trayectoria profesional y académica en temas de primera infancia.

3. *Estado del desarrollo de la primera infancia:* indaga las percepciones del participante sobre la situación actual del desarrollo de la primera infancia en Colombia de manera general, identificando avances, transformaciones positivas, desafíos persistentes, y desigualdades territoriales o poblacionales que afectan el pleno desarrollo infantil temprano.

4. *Marco de política:* explora las perspectivas sobre el diseño, implementación y evolución de DCAS, incluyendo aciertos y fallas, mecanismos de evaluación y medición de

resultados, adaptaciones regionales y poblacionales, coordinación intersectorial, seguimiento y financiación.

5. *Eje específico:* profundiza en la situación del desarrollo infantil y en la implementación de la política frente a un tema particular de interés o especialización de la persona entrevistada (por ejemplo, violencia en el hogar o educación inicial).

6. *Recomendaciones de política:* recoge propuestas para fortalecer la política de primera infancia en el corto, mediano y largo plazo, así como sugerencias sobre actores o instituciones clave para futuras consultas.

7. *Cierre:* finaliza con un agradecimiento y espacio para comentarios adicionales o temas no abordados.

Todas las entrevistas se llevaron a cabo de forma virtual a través de Zoom y otras plataformas digitales (p. ej., Teams y Google Meet) y fueron grabadas con el consentimiento de los participantes. En la mayoría de los casos, se utilizaron las herramientas de transcripción automática de dichas plataformas; posteriormente, estas versiones fueron validadas y corregidas manualmente mediante el contraste directo con los audios originales para garantizar la fidelidad del contenido.

*Análisis de datos*

El análisis de los datos cualitativos se desarrolló en varias fases combinando un proceso de codificación manual inicial con el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo para el análisis a mayor escala.

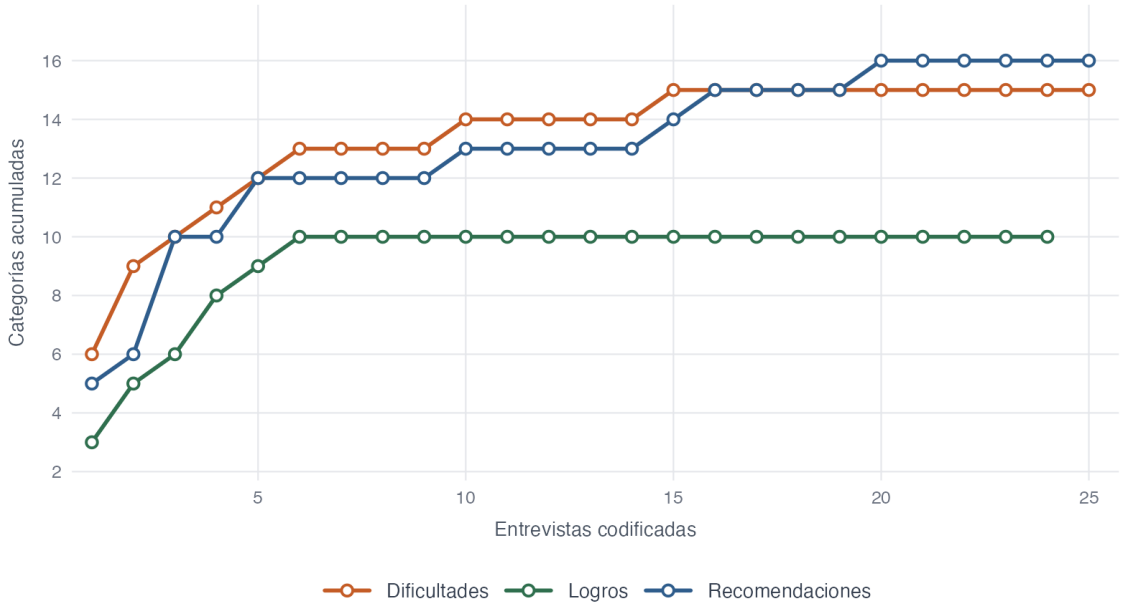
El análisis de datos se realizó en seis etapas (Figura 2). Primero, las transcripciones se anonimizaron mediante el paquete de R *ghosted* (Shankar et al., 2026). A cada entrevista se le asignó un código de identificación y se eliminaron los datos personales; posteriormente, el equipo investigador revisó manualmente las transcripciones para identificar cualquier información que aún permitiera reconocer a los participantes. Segundo, mediante un primer prompt de extracción, el contenido de cada entrevista se dividió en tres dimensiones definidas a priori: logros, dificultades y recomendaciones. Tercero, dentro de cada dimensión, el equipo investigador

codificó manualmente cuatro entrevistas mediante un análisis de contenido descriptivo, orientado a identificar y organizar los temas presentes en el material. Esta codificación permitió construir una primera versión del libro de códigos de cada dimensión y diseñar un segundo prompt, destinado a la codificación asistida por inteligencia artificial. Cuarto, el prompt de codificación se aplicó a esas mismas cuatro entrevistas y sus resultados se compararon con la codificación manual. A partir de las diferencias identificadas, se refinaron el libro de códigos y las instrucciones del prompt. Quinto, la versión ajustada del prompt se aplicó de manera secuencial a las 21 entrevistas restantes y de forma independiente en cada dimensión. Para analizar cada entrevista se utilizó el libro de códigos acumulado hasta ese momento y, antes de pasar a la siguiente, se incorporaron los códigos nuevos. Sexto, el equipo investigador agrupó los códigos en categorías analíticas más amplias y examinó su acumulación a lo largo de las entrevistas. Este procedimiento permitió construir la curva de saturación de categorías que se presenta en la Figura 3.

**Figura 2.** Procedimientos para el análisis de datos cualitativos



**Figura 3**. Curva de saturación de categorías cualitativas



# Resultados

La sección de resultados se estructura en ocho ámbitos temáticos prioritarios para la primera infancia en Colombia: pobreza, crianza, educación inicial, violencia, cambio climático, nutrición, desplazamiento y migración, y tecnología. En términos generales, el análisis de cada ámbito aborda tres componentes: la magnitud y las principales características del problema; sus efectos sobre el desarrollo y el bienestar de niñas y niños en la primera infancia; y el marco de política pública, junto con los programas e intervenciones existentes. Adicionalmente, se examinan dos dimensiones transversales, los sistemas de datos, monitoreo y valoración del desarrollo infantil temprano y el retorno a la inversión en este momento del curso de vida, que inciden en la comprensión, priorización y respuesta institucional frente a los distintos ámbitos analizados. A lo largo de la sección también buscamos entender diferencias por sexo, discapacidad, pertenencia étnica y la interculturalidad, y la ruralidad en resultados observados. Sin embargo, la profundidad con la que estas dimensiones pueden abordarse varía entre los ámbitos, debido a la disponibilidad limitada y desigual de información y datos desagregados.

## Pobreza y desarrollo infantil en Colombia

### 1. Magnitud del problema

Crecer en un ambiente de pobreza en Colombia significa enfrentar barreras estructurales desde el nacimiento que trascienden la falta de ingresos (Attanasio et al., 2022; Dávalos & Monroy, 2025). Por ejemplo, acceder a una buena nutrición y/o a una educación de calidad se hace complejo, y en muchos casos casi imposible, cuando los hogares no tienen suficientes recursos financieros para adquirir una canasta mínima de bienes y servicios que les permita saciar sus necesidades básicas (Laverde Rojas et al., 2019). Estas restricciones limitan el abanico de oportunidades que tienen las niñas y niños colombianos para construir un proyecto de vida digno (Dávalos & Monroy, 2025; Fergusson et al., 2024). Dado que las niñas y niños no generan ingresos, su bienestar está condicionado por la capacidad de su entorno para transformar recursos en salud, cuidado y estimulación. En ese sentido, se hace necesario hablar de pobreza infantil desde una mirada multidimensional y que ponga a las niñas y niños en el centro de la discusión.

Una gran parte de la literatura dedicada a los estudios de pobreza y del desarrollo sitúa al ingreso como el principal indicador de pobreza (Atkinson, 1987; OECD, 2024; Orshansky, 1965/1988) y al hogar como la unidad de análisis para comprender la distribución de esa pobreza (Brown et al., 2022; Vijaya et al., 2014). Aunque esta aproximación ha contribuido a comprender las privaciones materiales que experimentan las familias, tiene serias limitaciones para medir el bienestar infantil. Por un lado, asume una relación lineal entre ingreso y bienestar (Santos, 2019). Por otro lado, asume que el hogar es un agente racional capaz de maximizar el bienestar colectivo (Santos, 2019). Bajo esta óptica, la responsabilidad del bienestar de las niñas y niños recae en los adultos, sin embargo, en contextos de alta pobreza esa obligación generalmente corre a cargo de una sola persona: la madre (Chatterjee, 2023; Jaramillo-Echeverri et al., 2025). Por ejemplo, datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) para el año 2024 muestran que las mujeres dedican más tiempo a actividades del hogar y de cuidado que los hombres (DANE, 2025a).

Mientras que la pobreza monetaria se restringe a la evaluación de los flujos de ingreso, el enfoque multidimensional (IPM) ofrece una visión integral del bienestar al analizar el acceso efectivo a salud, educación y calidad de vida (Evans et al., 2024). Si bien el IPM constituye un gran avance, se requiere un giro hacia la niñez en la medición. Las privaciones infantiles difieren de las del adulto: el déficit no es el desempleo, sino la falta de cuidado, el rezago psicomotor, la vulnerabilidad alimentaria y la falta de acceso a oportunidades para la estimulación temprana. Expertos en el tema enfatizan que las mediciones de pobreza infantil deberían enfocarse en el individuo y no el hogar para visibilizar privaciones que de otro modo quedan ocultas (Dirksen & Alkire, 2021; García & Ritterbusch, 2015).

En respuesta a esta necesidad metodológica estructural, en agosto de 2026 el DNP presentó la Medida de Pobreza en la Niñez (MP-N), el primer instrumento oficial en Colombia enfocado exclusivamente en la convergencia de privaciones individuales de este grupo poblacional (DNP, 2026). Este reporte revela que la incidencia de la pobreza en la niñez se ubicó en 24,7% en 2025, lo que equivale a 3,5 millones de menores de edad (1 de cada 4) enfrentando privaciones simultáneas. Aunque esta cifra representa una reducción positiva de 4,4 puntos porcentuales frente al 29,1% registrado en 2023, las brechas estructurales continúan siendo alarmantes (DNP, 2026).

La infantilización de la pobreza sigue siendo un problema severo. Mientras que en el 2023 la pobreza monetaria nacional se ubicó en 34,6% (DANE, 2025b), la incidencia en hogares con niñas y niños menores de 6 años alcanzó el 32,8% (Observatorio del Bienestar de la Niñez et al., 2024). Este diagnóstico exige un abordaje interseccional fuertemente marcado por la lotería geográfica: los datos de la MP-N indican que la pobreza en la niñez en la zona rural (45,8%) triplica la incidencia de la zona urbana (16,1%), alcanzando niveles críticos superiores al 60% en departamentos como Vichada, Guainía, Vaupés, La Guajira y Chocó (DNP, 2026). Asimismo, existen brechas socioeconómicas de género desde temprana edad, donde las niñas asumen roles de cuidado no remunerado, generando una pobreza de tiempo que limita su educación y esparcimiento (Fergusson et al., 2024; ONU Mujeres et al., 2017).

## 2. Efectos de la pobreza en el desarrollo de la primera infancia

La pobreza extrema deriva en inseguridad alimentaria y retraso en el crecimiento, comprometiendo el desarrollo cerebral y físico en la primera infancia (Skinner & Kennedy, 2025; UNICEF, 2025). Esta crisis es confirmada por la medición del DNP, la cual señala que, para 2025, la privación por alimentación insuficiente o inadecuada afectó al 46,7% de las niñas, niños y adolescentes del país (DNP, 2026). Las presiones económicas derivadas de estas carencias detonan niveles tóxicos de estrés, afectando sistemas biológicos de respuesta a estrés (y otros) que pueden inhibir la plasticidad cerebral y comprometer las trayectorias de desarrollo (National Scientific Council on the Developing Child, 2005, 2014).

De igual manera, la pobreza multidimensional obstaculiza el acceso a bienes y servicios que podrían permitir que las familias construyan un proyecto de vida (Dávalos & Monroy, 2025; Fergusson et al., 2024). Desde la economía del hogar, el acceso a bienes durables como neveras, lavadoras y juguetes es un proxy de la capacidad del hogar para garantizar salud y capital humano (Cabra & Rozo, 2024). Estudios señalan que la falta de una nevera afecta la dieta (Karlsson & Subramanian, 2023), y la carencia de una lavadora absorbe horas productivas que recaen injustamente en mujeres y niñas, exacerbando las brechas socioeconómicas (Malhi et al., 2025). Proveer estos bienes libera tiempo para la estimulación temprana y el cuidado parental (Cabra, 2023), un factor fundamental si se tiene en cuenta que el 39,7% de la niñez colombiana sufre la privación de no contar con el cuidado de un padre, madre o cuidador (DNP, 2026).

En cuanto al entorno socioecológico, la pobreza en los barrios afecta el desarrollo infantil a través de externalidades como la violencia y la calidad de las interacciones vecinales (Leventhal & Brooks-Gunn, 2000). Los datos de la Encuesta Longitudinal de Colombia (ELCO) evidencian fallas en la distribución de infraestructura; la distancia a Centros de Desarrollo Infantil (CDI) o bibliotecas, particularmente en zonas rurales, opera como una barrera de entrada para las familias de bajos ingresos (Fergusson et al., 2024).

## 3. Marco de política pública

Una de las intervenciones más exitosas de política social para reducir la pobreza han sido las Transferencias Monetarias Condicionadas (CCTs), consistentes en la entrega de dinero a familias vulnerables condicionado a controles médicos y asistencia escolar (Ladhani & Sitter, 2020). En Colombia, estos programas iniciaron en el 2000 con Familias en Acción (Acosta et al., 2024) y continúan con Renta Ciudadana y Renta Joven. Numerosas evaluaciones demuestran efectos positivos en la reducción de la pobreza monetaria y el mejoramiento de indicadores de salud y educación (Attanasio et al., 2014; Onsay et al., 2025; Rawlings & Rubio, 2003).

Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto: la imposición de condicionalidades asume que las barreras son únicamente de demanda. Si el diseño institucional no provee una oferta concurrente de bienes públicos, las transferencias terminan sobrecargando a las mujeres con exigencias operativas, sin resolver la pobreza de tiempo ni la falta de activos en el hogar. La entrega aislada de dinero exhibe rendimientos decrecientes si el hogar carece de bienes durables (activos) para transformar ese ingreso en desarrollo cognitivo, y si el entorno carece de infraestructura de cuidado. Un gran desafío es el escalamiento: pasar de experimentos pequeños a programas nacionales que mantengan la calidad.

Una política social eficiente debe integrar la mitigación del riesgo de ingresos con una provisión intencionada de bienes públicos. Es necesario pensar en la niñez como el foco de toda la política social, estableciendo como prioridad innegociable que ningún niño y niña quede por fuera del sistema educativo y de cuidado en la primera infancia o carezca de interacciones significativas durante estos años.

# Crianza e interacciones en el hogar

## 1. Efectos, características y predictores de las prácticas de crianza

Una relación sólida y positiva entre niñas y niños con sus padres o cuidadores principales, así como comportamientos parentales positivos, constituyen las influencias más determinantes para garantizar el pleno desarrollo infantil temprano. Las prácticas de crianza cariñosas, sensibles y contingentes a las necesidades de la infancia, que incluyan oportunidades de aprendizaje temprano, métodos de disciplina no violentos y el involucramiento activo en el juego, el canto, la danza y la lectura, entre otras, promueven el desarrollo cognitivo, social y emocional a lo largo de la vida (Britto et al., 2017). Por el contrario, una relación caracterizada por la impredecibilidad, la falta de respuesta a las necesidades de las niñas y los niños o la violencia, puede comprometer seriamente el desarrollo humano. Por ejemplo, la negligencia y la falta de un vínculo emocional fuerte en la primera infancia afectan la salud física y la arquitectura neuronal, incrementando la susceptibilidad a desórdenes de salud mental a lo largo de la vida (Nelson et al., 2025). De igual forma, el castigo físico (incluyendo las nalgadas o palmadas) incrementa el riesgo de conductas agresivas y un desarrollo adverso, con consecuencias a largo plazo en el aprendizaje, la salud mental y el comportamiento en la etapa adulta (Cuartas, Gershoff, et al., 2025; Heilmann et al., 2021).

Las prácticas de crianza varían sustancialmente entre familias, regiones y países y de acuerdo a factores demográficos, socioeconómicos y contextuales. Por ejemplo, desde una perspectiva global, se ha encontrado gran variabilidad en el involucramiento parental en actividades de aprendizaje temprano a través de países que se relacionan con indicadores de riqueza económica como el PIB (Cuartas, Jeong, et al., 2020). Los métodos de disciplina también varían sustancialmente, con mayores prevalencias de castigo físico y violencia psicológica en África, Asia y Latinoamérica relativo a Europa y Norteamérica (Cuartas et al., 2019). Al interior de cada país, a su vez, el involucramiento de las madres tanto en actividades de aprendizaje como en disciplina suele ser sustancialmente mayor al de los padres hombres (Cuartas, Jeong, et al., 2020).

En Colombia, las prácticas de crianza presentan una importante variabilidad según factores sociodemográficos y económicos. Datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) 2024 muestran una distribución desigual del cuidado, donde las mujeres dedican el 12,8% de su

tiempo diario a la primera infancia frente al 8,1% de los hombres (DANE, 2025). A nivel nacional, la ELCO 2019 indica que un 72% de cuidadores de niños y niñas en primera infancia les lee libros, 93% juegan dentro de la casa, 80% juegan fuera de la casa, 79% le enseñan letras o números, y más del 50% realiza actividades artísticas o musicales (NiñezYa, 2024). Otras fuentes nacionales indican que más del 90% de los cuidadores reporta haber interactuado con niños menores de cinco años mediante juego o conversación en los últimos tres días, mientras que entre el 60% y el 80% participa en actividades como cantar, dibujar o leer (Rey-Guerra et al., 2022); sin embargo, persisten prácticas perjudiciales, ya que alrededor de 1,7 millones de niños han recibido castigo físico (Cuartas, 2018b). Estas prácticas presentan marcadas brechas socioeconómicas: los hogares con mayores ingresos reportan mayor involucramiento en actividades de estimulación, mientras que el castigo físico es más frecuente en contextos de pobreza; por ejemplo, el tiempo diario dedicado a la lectura o narración de cuentos varía entre 30–35 minutos en estratos bajos y 60–70 minutos en estratos altos (DANE, 2018). Asimismo, se observan diferencias de género, con mayor involucramiento de las mujeres en la crianza, en línea con normas sociales que reproducen roles tradicionales (Rey-Guerra et al., 2026).

Las prácticas parentales, al igual que el desarrollo infantil, están inmersas en un contexto geo bioecológico, en el cual factores individuales, sociales, culturales y naturales operan en distintos niveles. A nivel de los cuidadores, factores como el nivel educativo, el bienestar psicológico y la salud mental, la confianza en sus propias habilidades parentales, así como sus conocimientos, actitudes, creencias y expectativas sobre las prácticas de crianza y el desarrollo infantil, pueden influir en la calidad de las interacciones con niñas y niños (Bornstein, 2015; Cuartas, Rey-Guerra, et al., 2025; Cuartas, Rey-Guerra, et al., 2020). Por el contrario, ciertos factores de riesgo en los cuidadores pueden afectar negativamente la relación y las interacciones, tales como la violencia de pareja, el consumo de sustancias psicoactivas y la exposición a experiencias adversas o traumáticas (Britto et al., 2017).

A nivel comunitario y social, el nivel socioeconómico de los cuidadores es un determinante clave de las prácticas de crianza (Conger et al., 2000; Kalil & Ryan, 2020). En Colombia, se ha encontrado que las condiciones de pobreza multidimensional, especialmente en contextos urbanos, funcionan como estresores crónicos que erosionan las actitudes hacia el cuidado del sueño y la estimulación cognitiva, posiblemente debido a mayores niveles de estrés, la falta de redes de apoyo

y la precariedad del entorno (Amar-Amar et al., 2023; Romero Royert et al., 2023). Estas dificultades se entrelazan con actitudes culturales en las que aún prevalecen representaciones sociales que legitiman el castigo físico y la inequidad de género como prácticas culturalmente aceptadas (Lansford et al., 2015; Tobón Berrio et al., 2025). Asimismo, la violencia urbana o asociada al conflicto armado se ha vinculado con un mayor riesgo de prácticas de crianza violentas y con un menor involucramiento en oportunidades de aprendizaje temprano en Colombia (Cuartas, 2018a; Cuartas et al., 2018). Finalmente, a un nivel más amplio, condiciones globales como el cambio climático alteran la estabilidad familiar y actúan como factores de riesgo para prácticas de crianza negativas, como la negligencia y la violencia (Cuartas, Ramírez-Varela, et al., 2026).

Algunos factores contextuales aún no han sido tan explorados en investigación en el país, entre ellos el posible rol de los medios de comunicación masivos y las redes sociales en la configuración de las prácticas de crianza y, por ende, en el desarrollo infantil temprano. También hay evidencia limitada sobre la crianza de niños con discapacidades. Otra dimensión que ha recibido atención limitada se relaciona con las diferencias culturales entre grupos étnicos en Colombia. La mayor parte de la investigación sobre crianza y desarrollo infantil ha seguido, tradicionalmente, perspectivas del "norte global", imponiendo modelos de crianza centrados en el día a día cuidador-niño y en configuraciones familiares nucleares que reconocen de manera limitada la importancia de las familias extensas y de formas de organización del cuidado más comunitarias o con distintas cosmovisiones (Álvarez Torres et al., 2012; Draper et al., 2023). En consecuencia, existe una necesidad clara de generar mayor evidencia que permita comprender las concepciones y prácticas de crianza a lo largo del país, desde una perspectiva cultural y contextualizada.

## 2. Marco de política, programas e intervenciones

Dada la importancia de las prácticas de crianza en el desarrollo infantil temprano, existe un creciente interés en promover una crianza positiva en Colombia. El país ha consolidado un sólido marco legal que reconoce a niñas y niños como sujetos de derechos y establece la corresponsabilidad entre la familia, el Estado y la sociedad, a través del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016), que posiciona la crianza como un asunto de interés público. Este marco se complementa con lineamientos de política como los CONPES de primera infancia, el reconocimiento de la diversidad de arreglos familiares, incluida la familia

de crianza (Ley 2388 de 2024), y la prohibición del castigo físico y los tratos crueles (Ley 2089 de 2021). Todo ello se implementa mediante una arquitectura institucional intersectorial, liderada por el ICBF y la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, que articula acciones en salud, educación y protección para apoyar la crianza y el desarrollo infantil en el país.

En relación con las intervenciones y programas, la evidencia global señala la necesidad de estrategias de carácter ecológico, que incluyen, por ejemplo, el cambio de normas sociales mediante estrategias de medios, el fortalecimiento de apoyos económicos a las familias, o la psicoterapia en casos que requieran atención más especializada (Little et al., 2026). Dentro de este conjunto de estrategias, los programas de crianza han recibido especial atención, en particular aquellos orientados a promover conocimientos, actitudes y expectativas positivas, así como el bienestar de los cuidadores, con el fin de fortalecer las relaciones e interacciones con niñas y niños. Este tipo de programas ha demostrado ser efectivo para reducir la violencia en la crianza y promover prácticas positivas que favorecen el desarrollo infantil temprano (Backhaus et al., 2025; Jeong et al., 2021).

En Colombia existen programas de crianza y componentes de crianza integrados en la política social con resultados prometedores. La implementación del programa Mi Familia del ICBF, que atendió a más de 64.000 familias en 2020, mostró mejoras en los vínculos afectivos y las prácticas de crianza positiva, junto con reducciones en el castigo físico, según evaluaciones de operaciones y resultados (Econometría–SEI, 2023; ICBF, 2021). Asimismo, la incorporación del programa Apapacho en servicios familiares y comunitarios del ICBF y la integración de intervenciones de aprendizaje temprano en Hogares Comunitarios FAMI o la infraestructura de Familias en Acción evidenciaron mejoras en cuidado cariñoso, disciplina no violenta, crianza y desarrollo infantil temprano (Attanasio et al., 2014; Bernal et al., 2023; Cuartas, Borbón, et al., 2026). Un último ejemplo es el Programa Semillas de Apego, que ha demostrado efectos prometedores en mejorar la salud mental de los cuidadores e interacciones con los niños en contextos de desplazamiento y conflicto armado (Moya et al., 2024).

En general, los programas de crianza efectivos comparten ingredientes clave que orientan el diseño de futuras estrategias para promover la crianza. Estos incluyen contenidos dirigidos a fomentar la participación en actividades de aprendizaje temprano, la promoción de métodos no violentos de disciplina y resolución de conflictos, así como el cuidado de la salud mental y el bienestar de los

cuidadores. Todo ello se implementa mediante enfoques participativos que construyen sobre sus habilidades y fortalezas, como discusiones grupales, demostraciones, práctica guiada y retroalimentación (Gardner et al., 2023; UNICEF, 2020).

A pesar de la evidencia prometedora, persisten retos y vacíos de conocimiento para maximizar la sostenibilidad y la escalabilidad de los programas de crianza, entendidas no solo como la ampliación de la cobertura, sino también como el mejoramiento de la calidad y la costo efectividad. En Colombia, muchos programas no han sido escalados ni incorporados en los manuales operativos del ICBF, y la política pública aún carece de criterios claros para comprender, medir y mejorar la calidad de los servicios de crianza, lo que evidencia la necesidad de avanzar en calidad además de cobertura. Asimismo, existe incertidumbre sobre la sostenibilidad de los efectos en el largo plazo y sobre las estrategias necesarias para mantenerlos; en este contexto, la tecnología podría desempeñar un rol relevante, dado que la evidencia sugiere que herramientas como chatbots y programas basados en tecnologías emergentes pueden servir como refuerzos y generar impactos positivos en la crianza y el desarrollo (Fink et al., 2026). Otros retos clave incluyen fortalecer la participación de los hombres (padres y otros cuidadores), asegurar la pertinencia cultural mediante adaptaciones a comunidades étnicas y de diferentes orígenes y culturas, y mejorar los sistemas de caracterización de las familias para ofrecer servicios más ajustados a las necesidades específicas de la población.

## Educación inicial y servicios de atención a la primera infancia

Según la Ley 1804 de 2016, la educación inicial es un derecho impostergable de las niñas y niños menores de seis años, que se enmarca en la atención integral y hace parte del sistema educativo, según lo previsto en la Ley 115 de 1994. Según el Decreto 1411 de 2022, la educación inicial se organiza en dos ciclos, el primero va de los 0 a los 3 años de edad (lo que incluye la atención a las madres gestantes), y el segundo ciclo desde los 3 a los 6 años de edad, y corresponde a la educación preescolar, que incluye los grados de prejardín, jardín y transición.

### 1. La situación actual de la cobertura de educación inicial y preescolar

En Colombia, la oferta de educación inicial se organiza en distintas modalidades del ICBF y en los grados de preescolar de colegios oficiales y no oficiales, además de los jardines privados. El ICBF ofrece servicios familiares, comunitarios, institucionales y propios e interculturales, dirigidos a diversos grupos y contextos (ICBF, s.f.; MEN, 2026b). En 2025, 2.059.762 (48,3% de la población total de 4.259.990) de niñas y niños entre los 0 y los 5 años recibieron atención integral por parte de ICBF, MEN, Secretarías de integración social o cajas de compensación familiar (MEN, 2026c). En ese mismo año, el 57,5% de los niños y niñas de 5 a 6 años estaba matriculado en grado transición (MEN, 2026a). No obstante, 73,6% de la matrícula se concentra en zonas urbanas y 26,4% en zona rural. Finalmente, 1,12% de los niños atendidos tenía diagnóstico de discapacidad (MEN, 2026c), aunque no se dispone de la información del total de niños con discapacidad para estimar la cobertura de esta población.

**2. Calidad de los servicios de educación inicial y preescolar**

Colombia cuenta con lineamientos de calidad para la educación inicial definidos por el ICBF y el MEN y en 2017, el país alcanzó un hito de gran importancia con la primera Medición de la calidad de la educación inicial. En una muestra representativa nacional, el MEN y el ICBF evaluaron la calidad estructural y de proceso en cerca de 300 CDIs y 597 aulas de pre-jardín y jardín. Se encontró que el 86% de las instituciones contaba con condiciones adecuadas de seguridad e higiene, pero en promedio disponía de menos del 50% de los materiales para el aprendizaje considerados necesarios por el MEN. Por su parte, la calidad pedagógica obtuvo un promedio de 2,34 en una escala de 1 a 4, correspondiente a un nivel moderado (Maldonado-Carreño et al., 2022).

En 2021, el MEN midió la calidad de las aulas de transición en 416 establecimientos educativos (EE) a nivel nacional. En calidad estructural, se encontraron niveles similares de seguridad y materiales pedagógicos a los de los CDIs, aunque los EE contaban con más materiales impresos y libros (Maldonado-Carreño et al., 2018, 2022; MEN, 2021). La calidad de proceso también fue similar a la de los CDIs, con un promedio de 2,31. Sin embargo, también se encontraron algunas diferencias entre ambos contextos: las actividades de música, literatura y artes predominaron tanto en los CDIs como en los EE, pero fue mucho mayor la prevalencia de actividades de música y literatura en los primeros. Por su parte, en los CDIs eran poco frecuentes las actividades con grafías

y números, lo que sí se observó en la mayoría de aulas de transición (Maldonado-Carreño et al., 2018; MEN, 2021). Esto refleja el énfasis en las actividades rectoras en la educación inicial, pero también un vacío en la práctica en los CDIs para desarrollar habilidades de preparación escolar, como escritura y matemáticas, pese a que los lineamientos técnicos de la educación inicial no las restringen. Adicionalmente, a pesar de que en ambos contextos fue alta la frecuencia de las actividades rectoras (a excepción de las relacionadas con la exploración del medio), la calidad con la que se realizaban esas actividades fue en general baja (Colombia Aprende, 2018; MEN, 2021), lo que también evidencia la necesidad de seguir avanzando en la apropiación de los lineamientos técnicos.

En 2025 se realizó una nueva medición de la calidad de transición (MEN, 2025), cuyos resultados aún no se han publicado. Sin embargo, su inclusión en el Plan de Desarrollo 2022-2026 refleja el reconocimiento de la necesidad de evaluar la calidad de estos servicios y permitirá nuevos análisis sobre su pertinencia en el país.

### 3. Asociaciones entre la calidad y el desarrollo infantil

Monitorear y promover la calidad de los servicios de educación inicial es fundamental por su impacto en el desarrollo infantil. En cuanto a la calidad estructural, se ha encontrado que condiciones físicas inadecuadas, como riesgos y ambientes poco higiénicos, se asocian con peores resultados en razonamiento matemático temprano y desarrollo socioemocional (Maldonado-Carreño et al., 2022). Asimismo, en transición, mejores dotaciones de aula y talento humano adicional (talleristas u otros docentes) se han relacionado con mejores desempeños en múltiples dominios, especialmente en contextos rurales (MEN, 2021). Sin embargo, la evidencia indica que la calidad de proceso es la dimensión más estrechamente vinculada al desarrollo infantil. Las actividades intencionales de lenguaje, matemáticas, exploración, juego simbólico y artes se asocian consistentemente con mejores resultados en lenguaje, desarrollo socioemocional y habilidades cognitivas, incluyendo las funciones ejecutivas (Maldonado-Carreño et al., 2018, 2022; MEN, 2021). En este contexto, la formación docente ha demostrado ser clave: mayores niveles de educación formal y experiencia se han relacionado con mejores resultados en los niños (Maldonado-Carreño et al., 2022). Por ello, las intervenciones centradas exclusivamente en

aumentar recursos, sin fortalecer las capacidades pedagógicas, pueden ser ineficaces o incluso generar respuestas no deseadas (Andrew et al., 2024).

## 4. Retos para la calidad en términos políticos y psicológicos

A pesar de los avances institucionales y del fortalecimiento de la comunidad que trabaja por la primera infancia, persisten retos importantes para garantizar la calidad de los servicios de educación inicial en el país. Primero, parece existir una brecha entre la comprensión de los lineamientos técnicos y su implementación. Aunque en 2021, los docentes de transición reportaron comprenderlos ampliamente (MEN, 2021), las mediciones de calidad evidencian dificultades para materializarlos en la práctica. Además, falta información sobre su implementación en modalidades no evaluadas, como la comunitaria, familiar y propia del ICBF, lo que plantea la necesidad de seguir reflexionando sobre cómo definir y medir la calidad en la diversidad de contextos colombianos.

Segundo, según señalan varios de los entrevistados, persiste cierta fragmentación entre las entidades del sector educativo —ICBF, Ministerio de Educación y secretarías— y entre los niveles nacional y local, pese a que el trabajo intersectorial es una fortaleza de la política de primera infancia. Tercero, existen importantes diferencias en la formación y condiciones laborales de los educadores del ICBF y del magisterio: en la medición de la calidad del 2021, 95% de los docentes de los EE tenía título profesional o superior, mientras que en la medición del 2017 solo el 51% de los educadores de los CDIs tenían este nivel educativo (Maldonado-Carreño et al., 2022; MEN, 2021). Esta brecha educativa se acompaña de mejores condiciones laborales para los docentes del magisterio y de desafíos para formalizar y mejorar las condiciones de las trabajadoras del ICBF. A pesar de que se están empezando a realizar acciones para formalizar el trabajo de un grupo de madres comunitarias, una de las personas entrevistadas menciona que no hay una política clara que lleve a mejorar las condiciones laborales de todas las maestras del ICBF, y parece insostenible financieramente para este instituto hacerlo.

Finalmente, la salud mental de los educadores constituye un reto creciente. A nivel internacional se ha reportado que los educadores de educación inicial tienen altos niveles de estrés (Jennings & Greenberg, 2009; Jennings et al., 2020). Aunque la evidencia colombiana es limitada, estudios disponibles reportan agotamiento emocional y despersonalización moderados, baja realización

personal y niveles de burnout entre el 5% y 16% de los educadores (Ferro, 2017; Muñoz et al., 2020). Entre los principales estresores se encuentran salarios insuficientes, alta carga laboral, escasas oportunidades de crecimiento, poco tiempo personal, limitada participación en decisiones y relaciones conflictivas con las familias (González González, 2018; Rojas & Puerto, 2019).

### 5. Marco de política, programas e intervenciones

En Colombia han surgido múltiples esfuerzos para fortalecer la calidad de la educación inicial mediante enfoques institucionales y de política pública, de los que resaltamos dos casos puntuales. Por un lado, los modelos de fortalecimiento de las capacidades de los agentes educativos, que responden a la necesidad de integración de los lineamientos técnicos del país en la práctica pedagógica. Un ejemplo es el modelo de aeioTU, que combina monitoreo sistemático, uso de evidencia y formación intensiva, y ha mostrado resultados positivos en el desarrollo infantil (Nores et al., 2019). Aunque el Gobierno y diversas organizaciones continúan impulsando este tipo de iniciativas, hace falta sistematizar estas experiencias y evaluar sus resultados. Además, la formación debe responder a las necesidades de las educadoras, incluidas sus condiciones laborales y de salud mental; en este sentido, se destacan iniciativas del ICBF para promover la salud mental de los maestros como Sanar para Crecer (ICBF, 2023). Sin embargo, dado el carácter sistémico del desarrollo, estos esfuerzos deben acompañarse de cambios en los sistemas con los que interactúan los educadores, lo que incluye mejoras importantes en sus condiciones laborales.

La segunda experiencia que se destaca es el uso de los resultados de monitoreo y evaluación para favorecer procesos de fortalecimiento de la calidad. Un ejemplo es el programa Evaluar para Avanzar, liderado por el MEN, el cual se implementó en aulas de preescolar hasta el grado 11, e incluyó a docentes, directivos y equipos de las Secretarías de Educación para fortalecer el liderazgo, el acompañamiento técnico y la mejora continua desde una perspectiva sistémica (Colombia Aprende, 2023). Sin embargo, se hace necesario evaluar la efectividad de estas estrategias y ampliarlas a las aulas del ciclo 1 de la educación inicial.

## Violencia en el hogar, las comunidades y en medio del conflicto armado

### 1. Magnitud del problema

Históricamente, la infancia en Colombia ha estado marcada por niveles críticos de violencia. La evidencia sugiere que este fenómeno opera bajo una lógica de retroalimentación: la exposición al maltrato en el entorno familiar incrementa significativamente el riesgo de participar en conductas violentas a lo largo de la vida. A su vez, la violencia contextual, como el conflicto armado o la inseguridad urbana, permea las dinámicas domésticas, creando ciclos viciosos de violencia intergeneracional y multicausal.

En términos generales, Save the Children (2021) sitúa a Colombia en la posición 132 de 186 países dentro de su índice de protección a la infancia. En esta clasificación, el primer puesto representa los niveles más altos de protección, mientras que el puesto 186 indica el mayor riesgo por violencia contextual y otras amenazas. Los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indican que la tasa de violencia contra niñas y niños en primera infancia se ha reducido de 145,1 en 2018 a 93,8 en 2023. Sin embargo, esto sigue siendo un problema significativo, considerando que para 2024 se notificaron 4.937 casos de violencia sexual, 13.732 de negligencia y abandono, 2.584 de violencia física y 649 de violencia psicológica (ICBF, 2024). A esto se suman los más de 1,7 millones de niños expuestos a otras formas de castigo físico (ver capítulo de crianza) que usualmente no son reportados en las estadísticas oficiales.

Frente a la violencia contextual, más de 1,1 millones (o 1 de cada 4) de niños y niñas menores de seis años en Colombia viven en municipios altamente afectados por el conflicto armado, principalmente en zonas rurales, cifra que supera el promedio mundial de 1 de cada 6 (Østby & Rustad, 2024). Según el Registro Único de Víctimas, se contabilizan más de 160.000 niños en primera infancia como víctimas directas de este conflicto (Unidad para las Víctimas, 2026). Fuera de dicha violencia, la primera infancia también crece en contextos de violencia urbana y criminalidad. Colombia registra entre 24 y 27 homicidios por cada 100.000 habitantes desde hace una década, entre las diez tasas más altas del mundo (Banco Mundial, 2026), y esta violencia se concentra desproporcionadamente en los barrios de bajos ingresos (Cotte Poveda, 2012) donde opera la mayoría de la oferta pública de educación inicial (Maldonado-Carreño et al., 2022). Por ejemplo, un estudio longitudinal en Bogotá y Cartagena reveló que, en 2019, los Hogares Comunitarios registraron en promedio 1,27 homicidios en un radio de 500 metros, alcanzando picos de hasta 8 casos en algunas zonas (Cristancho et al., 2026).

## 2. Impacto de la violencia en el desarrollo infantil

La violencia infligida directamente durante la primera infancia puede generar efectos a largo plazo en el desarrollo, el aprendizaje, el comportamiento y la salud física y mental. El abandono o la negligencia en los primeros años de vida pueden derivar en dificultades persistentes en las relaciones interpersonales, el desarrollo cognitivo y el logro académico (Nelson et al., 2025). Asimismo, la violencia sexual y física exacerba los riesgos de padecer afecciones cardiovasculares y digestivas, así como trastornos de depresión y ansiedad (McLaughlin et al., 2021). Como se mencionó anteriormente, incluso formas de violencia física socialmente aceptadas, como el castigo físico, representan un riesgo significativo. Por ejemplo, un estudio realizado con más de 6.000 adolescentes en Colombia demostró que la exposición temprana al castigo físico se asocia con menores niveles de comportamiento prosocial y una mayor agresividad, lo que potencialmente perpetúa ciclos viciosos de violencia (Cuartas, Ward, et al., 2020).

La violencia, además, no solo afecta a quienes la experimentan directamente, sino también a quienes habitan los mismos entornos. Ante la ocurrencia de un crimen violento, los miembros de una comunidad pueden enterarse por múltiples vías, ruido durante el incidente, rumores, redes sociales o presencia policial, lo que genera respuestas inmediatas de estrés, ansiedad y miedo. Incluso en ausencia de victimización directa, estos eventos alteran la percepción de seguridad y pueden modificar comportamientos cotidianos, como restringir la movilidad, evitar espacios públicos o reducir interacciones sociales. En contextos donde estos eventos son frecuentes, estas respuestas dejan de ser excepcionales y pasan a formar parte de la vida diaria, contribuyendo a la normalización de la violencia y al debilitamiento de la cohesión social.

Sin embargo, en la primera infancia, estos mecanismos operan de manera particular. Dado que niñas y niños en este momento del curso de vida tienen una comprensión limitada de estos eventos y de su significado, es menos probable que los efectos se expliquen por su interpretación directa de la violencia y más por los cambios en el comportamiento de sus cuidadores (padres, familiares y docentes). La evidencia muestra que, tras la ocurrencia de hechos violentos en el entorno cercano, los adultos presentan incrementos en síntomas de estrés (Cuartas & Leventhal, 2020). Estos cambios se traducen en modificaciones en las prácticas de crianza: mayor uso de castigo físico, menor paciencia en las interacciones (Cuartas, 2018a), y decisiones de protección que pueden limitar la exploración y el juego de los niños, como mantenerlos en casa o restringir su participación en actividades comunitarias (Koppensteiner & Menezes, 2021). De esta manera, las

dinámicas macro de violencia se filtran hacia el hogar, afectando directamente los entornos inmediatos de desarrollo infantil y contribuyendo a la transmisión intergeneracional del estrés y la desventaja.

Estos mismos mecanismos pueden extenderse a los entornos institucionales diseñados para proteger y promover el desarrollo infantil. Aunque espacios como los centros de educación inicial suelen considerarse relativamente protegidos frente a choques externos, la evidencia sugiere que no son inmunes a la violencia contextual. En particular, Cristancho et al. (2026) muestran que la proximidad de estos centros del ICBF a homicidios disminuye la calidad de las interacciones pedagógicas, afectando dimensiones clave como el apoyo emocional, la estimulación cognitiva y la organización del aula. En particular, un aula de calidad promedio (percentil 50 del estudio) cae aproximadamente al percentil 30 tras un homicidio cercano, y ese deterioro persiste hasta mes y medio. Esto sugiere que los efectos de la violencia no solo operan a través del hogar, sino también a través de los sistemas de cuidado y educación, amplificando su impacto sobre el desarrollo infantil.

La evidencia sobre el conflicto armado en Colombia muestra que las experiencias de victimización no sólo afectan a quienes las viven directamente, sino también a sus descendientes, a través de canales económicos, emocionales y sociales (Moya et al., 2024). Por ejemplo, un estudio en Tumaco mostró un efecto “dosis-respuesta” entre exposición a eventos violentos derivados del conflicto armado y problemas de salud mental en madres de niñas y niños en primera infancia, los cuales, a su vez, se asociaban con problemas en la crianza y problemas de salud mental en sus hijos e hijas (Sánchez-Ariza et al., 2023). En conjunto, estos mecanismos configuran ciclos de violencia que se refuerzan mutuamente: la violencia contextual incrementa el estrés y la inestabilidad en los hogares, lo que a su vez deteriora las prácticas de crianza y el desarrollo infantil, aumentando el riesgo de perpetuar comportamientos violentos en el largo plazo. Estos hallazgos además resaltan la necesidad de abordar la violencia como un fenómeno multidimensional que conecta el hogar, la comunidad y las instituciones, y de diseñar intervenciones que, simultáneamente, fortalezcan la calidad de la educación inicial, promuevan prácticas de crianza positivas y mitiguen los efectos del contexto violento sobre las familias.

## 3. Marco de política, programas e intervenciones

Colombia cuenta con uno de los marcos normativos más sólidos de América Latina para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia, sustentado en la Constitución y en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que establece la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en la garantía de sus derechos. A partir de esta base, se han desarrollado diversas normas para prevenir y atender situaciones como el abuso sexual, el maltrato, la explotación sexual comercial, las violencias basadas en género y los efectos del conflicto armado. Entre los avances más relevantes se destacan la Ley 1146 de 2007, que fortaleció la prevención y atención integral de la violencia sexual y creó un comité nacional de coordinación interinstitucional; las Leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009, orientadas a combatir la explotación sexual de menores de edad en distintos contextos, incluidos el turismo y los entornos digitales; y la Ley 2137 de 2021, que estableció el Sistema Nacional de Alertas Tempranas para mejorar la identificación de riesgos y la respuesta institucional frente a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

El país también ha avanzado en el reconocimiento explícito de formas de violencia históricamente naturalizadas dentro de los hogares. Un hito significativo fue la aprobación de la Ley 2089 de 2021, mediante la cual Colombia prohibió el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier forma de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes. La norma reconoce que los procesos de crianza deben estar fundamentados en el respeto por la dignidad y los derechos de la infancia, y extiende esta prohibición a todos los entornos donde transcurre la vida de niñas y niños. Este avance fue particularmente relevante porque alineó la legislación colombiana con la evidencia científica que demuestra los efectos negativos del castigo físico sobre el desarrollo infantil y la salud mental a largo plazo (Cuartas, 2021).

De manera complementaria, Colombia ha fortalecido la respuesta institucional frente a las violencias basadas en género y aquellas que afectan de manera diferencial a niñas y adolescentes. La Ley 1257 de 2008 estableció medidas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, que fuera de afectarlas directamente puede traer consecuencias perjudiciales profundas también en el desarrollo de los niños que habitan sus hogares (Jeong et al., 2020). Adicionalmente, el Decreto 1710 de 2020 creó el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, concebido como una estrategia de

gestión en salud pública que busca coordinar las acciones de prevención, atención, acceso a la justicia y seguimiento para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

La protección de la infancia víctima del conflicto armado constituye otro componente central del marco de política pública. La Ley 1448 de 2011 reconoció los derechos de las víctimas del conflicto y estableció mecanismos de reparación integral, mientras que otras normas posteriores han buscado garantizar el acceso a la justicia y la atención especializada para las víctimas de violencia sexual ocurrida en contextos de conflicto armado. Estas disposiciones reconocen que la violencia no afecta únicamente a quienes experimentan directamente los hechos victimizantes, sino también a las familias, comunidades y trayectorias de desarrollo de niñas y niños.

Más recientemente, el país ha comenzado a transitar desde una aproximación centrada en la atención de casos hacia una visión preventiva de carácter sistémico. Este cambio quedó reflejado en el compromiso nacional "A Tiempo", presentado por Colombia durante la Primera Conferencia Ministerial Mundial para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez en Bogotá en 2024. Este compromiso propone la construcción de un sistema transectorial orientado a la prevención, identificación temprana, gestión de alertas y seguimiento de situaciones de riesgo y violencia contra niñas, niños y adolescentes. El enfoque parte de la premisa de que la protección infantil requiere "llegar a tiempo y actuar juntos", fortaleciendo la coordinación entre instituciones, comunidades y familias para detectar señales tempranas de vulneración y responder oportunamente antes de que los daños se consoliden.

Frente a intervenciones y programas, la evidencia internacional indica que la prevención y respuesta a la violencia en la primera infancia requiere enfoques sistémicos que actúen sobre los factores de riesgo individuales, familiares, comunitarios e institucionales. El paquete técnico INSPIRE (WHO, 2016) destaca la importancia de combinar acciones normativas, servicios de apoyo, fortalecimiento económico de las familias y programas de crianza para prevenir la violencia contra niños y niñas. De manera consistente, revisiones recientes (Cuartas et al., 2024) muestran que las estrategias más efectivas son aquellas que fortalecen las capacidades de cuidado y promueven relaciones seguras y afectivas entre cuidadores y niños. Dentro de estas estrategias, los programas de crianza ocupan un lugar central por su potencial para reducir prácticas violentas de disciplina y promover entornos protectores para el desarrollo infantil (Backhaus et al., 2023; Jeong

et al., 2021). En este documento destacamos dos programas de crianza prometedores para la prevención y respuesta a la violencia contra niñas y niños.

En primer lugar, la Estrategia Apapacho y el Programa Apapáchar buscan prevenir el castigo físico y otras formas de violencia mediante el fortalecimiento de creencias, actitudes y prácticas de crianza positiva entre madres, padres y otros cuidadores. La estrategia combina encuentros grupales presenciales, herramientas de acompañamiento virtual y materiales de aprendizaje para promover el cuidado sensible, la regulación emocional y la disciplina no violenta. La evaluación piloto de Apapacho (Cuartas, Borbón, et al., 2026) con 267 cuidadores en dos ciudades y la evaluación experimental de Apapáchar con 2.500 cuidadores en cuatro ciudades encontraron mejoras en las creencias sobre cuidado responsivo, reducción de la aprobación y uso del castigo violento, así como incrementos en prácticas de estimulación infantil y disciplina no violenta. Los hallazgos cualitativos también documentaron una mejor relación entre cuidadores e hijos, mayor comprensión de las necesidades infantiles y un fortalecimiento de la autorregulación emocional de los adultos.

El segundo programa es Semillas de Apego, una intervención psicosocial grupal dirigida a cuidadores y niños pequeños afectados por el conflicto armado y otras experiencias de violencia, fundamentada en la teoría del apego y orientada a fortalecer las capacidades de cuidado sensible, la salud mental de los cuidadores y el desarrollo socioemocional infantil. Una evaluación experimental (Moya et al., 2024) encontró que ocho meses después de finalizada la intervención, los participantes presentaban mejoras de 0,17 desviaciones estándar en salud mental, así como efectos positivos de 0,31 y 0,15 desviaciones estándar en la calidad y el estilo de las interacciones cuidador-niño, respectivamente. Asimismo, se observaron mejoras de 0,10 desviaciones estándar en salud mental infantil y de 0,23 desviaciones estándar en desarrollo infantil temprano, lo que sugiere que fortalecer el bienestar psicológico de los cuidadores puede constituir un mecanismo efectivo para proteger a los niños y niñas de los efectos de la violencia contextual.

A pesar de estos avances normativos y experiencias prometedoras, persisten importantes desafíos de implementación. Diversos diagnósticos coinciden en que la fragmentación institucional, las diferencias de capacidad entre territorios, las limitaciones en los sistemas de información y la insuficiente articulación entre sectores continúan dificultando la detección temprana, la atención

integral y el seguimiento de los casos de violencia. En consecuencia, uno de los principales retos para los próximos años no parece ser la creación de nuevas normas, sino la consolidación de sistemas integrados de prevención y respuesta que permitan traducir el amplio marco legal existente en mejoras reales y sostenibles en la protección de la primera infancia.

# Cambio climático y relación con la naturaleza

### 1. Magnitud del problema

Colombia enfrenta amenazas climáticas y ambientales cada vez más severas, exacerbadas por el cambio climático. Cerca del 47% del territorio nacional presenta un riesgo alto o muy alto por temperaturas extremas y otros impactos asociados, y más del 80% de la población ya experimenta eventos como inundaciones y deslizamientos (Banco Mundial, 2023; Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2017). Estas condiciones han impulsado un aumento del desplazamiento por riesgo climático, con más de 3,6 millones de personas afectadas entre 2008 y 2021. Proyecciones del IDEAM indican que para 2050 la temperatura podría aumentar hasta 1,4 °C (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2024), intensificando aún más los eventos extremos. Estos riesgos no se distribuyen de manera equitativa: las regiones históricamente más golpeadas por el conflicto armado y la pobreza suelen ser también las más vulnerables a los impactos climáticos (Cuartas, Moya, et al., 2025). Asimismo, la exposición a amenazas ambientales, como la contaminación del aire o del agua, se relaciona con factores como la pobreza del hogar o el color de piel, situando en mayor riesgo a poblaciones tradicionalmente excluidas y marginadas que habitan zonas más afectadas por diversos riesgos climáticos y contextuales (Aguilar-Gomez et al., 2025).

En lo que refiere a la primera infancia, el Índice de Riesgo Climático de la Infancia desarrollado por UNICEF (2021) ubica a Colombia en la posición 61 de 163 países en cuanto a riesgo para la primera infancia, donde la posición número uno representa el mayor nivel de riesgo. Este índice se calcula considerando (1) la severidad y frecuencia de amenazas climáticas como olas de calor y desastres naturales, y (2) la vulnerabilidad de la infancia asociada a la falta de acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, salud y educación. Los riesgos climáticos además pueden afectar dichos servicios; por ejemplo, según los Informes de Situación Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (2010–2024), entre 2010 y 2024 los desastres naturales

afectaron, por año, una media de 315 establecimientos educativos que incluyen el nivel de preescolar. De igual forma, la evidencia indica que los desastres pueden exacerbar la pobreza de los hogares (Sanchez & Calderon, 2015). Todo ello refuerza la idea de que el cambio climático actúa como un multiplicador de riesgo, afectando en mayor medida a niños y niñas que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y exacerbando otros riesgos contextuales.

**2. Efectos en el desarrollo en la primera infancia**

Dentro de este contexto, la primera infancia suele considerarse una población particularmente vulnerable a los riesgos climáticos y ambientales. Por una parte, los sistemas biológicos que regulan la temperatura corporal y responden a posibles contaminantes ambientales están aún en desarrollo durante los primeros años de vida, por lo que no son tan eficientes para enfrentar estas amenazas en comparación con los adultos. Además, en esta etapa los choques de estrés frecuentes, severos o altamente impredecibles pueden afectar el desarrollo de la arquitectura cerebral, dada la gran maleabilidad del cerebro a las experiencias tempranas. Por último, las niñas y los niños pequeños dependen enteramente de adultos cuidadores, por lo que su bienestar frente a un riesgo climático depende de la disponibilidad de al menos un adulto sensible y atento a responder.

En general, aunque los estudios aún son escasos, la evidencia indica que las amenazas climáticas pueden afectar el sano desarrollo infantil temprano. Un estudio comparativo de seis países encontró que la exposición a temperaturas superiores a lo habitual para una región determinada puede reducir la probabilidad de alcanzar un desarrollo adecuado para la edad, particularmente en habilidades cognitivas relacionadas con matemáticas y lenguaje emergentes, con efectos más fuertes en hogares en situación de pobreza y sin acceso adecuado a servicios de agua y saneamiento (Cuartas, Balza, et al., 2026). Otros estudios han mostrado que experimentar riesgos climáticos en la primera infancia puede generar efectos en cascada a largo plazo, aumentando el riesgo de problemas de salud mental (Adhvaryu et al., 2024; Ai & Tan, 2023). Adicionalmente, la exposición a desastres naturales como huracanes o derrames de petróleo puede llevar a secuelas posteriores en el largo plazo como estrés postraumático y desórdenes del sueño sostenidos por varios meses (Lai et al., 2020; Osofsky et al., 2015). Evidencia de Colombia muestra resultados similares; por ejemplo, un estudio encontró que el fenómeno de La Niña atípico de 2010 y 2011 afectó el

desarrollo cognitivo y socioemocional de niñas y niños en municipios más impactados por las lluvias e inundaciones (Brando & Santos, 2014).

### 3. Relación entre los niños y niñas con la naturaleza

Aparte de los efectos directos que el cambio climático y los desastres naturales tienen en el desarrollo físico y psicológico de las niñas y niños, ellos también están expuestos a las interpretaciones sociales de estos eventos y en particular a creencias sobre la naturaleza y sobre cómo los seres humanos deben relacionarse con ella. Estas creencias sociales son fundamentales no sólo para entender las causas de la crisis ambiental (principalmente antropogénicas) sino también como motivadores (o inhibidores) de las acciones necesarias para mitigar esta crisis y avanzar hacia transiciones sostenibles (Ives et al., 2018; Wamsler et al., 2023).

La evidencia indica que, desde temprano en la niñez, habitantes de comunidades urbanas tienden a percibir al ser humano como separado de la naturaleza y superior a ella (Pizza & Kelemen, 2023), atribuyendo menores capacidades a animales no humanos (Neldner et al., 2026), lo cual impacta sus actitudes ambientales. Específicamente, estas creencias de separación de la naturaleza y superioridad humana están asociadas a menor preocupación por el deterioro ambiental y menores intenciones de realizar comportamientos proambientales para mitigarlo (Betz & Coley, 2022; Pizza & Kelemen, 2023; Uenal et al., 2022). En el contexto colombiano, se han encontrado tendencias similares, por ejemplo solo una pequeña proporción de niños (37%) incluye personas y elementos sociales en sus dibujos sobre la naturaleza (Suárez Arias et al., 2020). Asimismo, hay evidencia de que estas creencias impactan las actitudes ambientales en edades tempranas. Específicamente, la exposición a creencias sobre la superioridad de los seres humanos por encima de cualquier otra entidad natural llevó a evaluaciones más positivas de acciones que deterioran el medio ambiente como el gasto de energía (Pizza & Posada, 2026).

Por otro lado, comunidades indígenas que tienden a percibir al ser humano como parte de la naturaleza y envuelto en relaciones de reciprocidad con todos los seres vivos (Bang et al., 2007; Kimmerer, 2013) demuestran mayor preocupación por el deterioro ambiental y mayor involucramiento con acciones sostenibles. Aunque muchas comunidades indígenas colombianas

habitan territorios fuertemente impactados por el cambio climático y los desastres naturales, su cosmovisión y en particular sus relaciones de reciprocidad con los demás seres vivos les ha llevado a desarrollar acciones para proteger los ecosistemas y favorecer transiciones hacia la sostenibilidad. Aunque los sistemas de conocimiento indígena no tienden a ser reconocidos al mismo nivel que el conocimiento científico (Lam et al., 2020), investigación reciente ha documentado que programas desarrollados por comunidades locales e indígenas tienen gran potencial para generar transiciones hacia sociedades más sostenibles por su enfoque en estrategias a largo plazo y de impacto de las comunidades así como de los niveles institucionales. Estos programas de las comunidades indígenas y locales son muestra de que las representaciones sociales de la naturaleza y de cómo los seres humanos pueden interactuar con ella, pueden tener un gran impacto en la resiliencia de las comunidades y en su involucramiento exitoso en actividades de mitigación del daño ambiental, desde la primera infancia.

## 4. Política pública en torno a la respuesta al cambio climático y los desastres naturales en Colombia

En general, las características del deterioro ambiental y el carácter impredecible de los desastres naturales dificultan tanto la evaluación de sus impactos como el diseño de respuestas de política pública. En Colombia, la agenda de cambio climático y niñez tiene una trayectoria relativamente reciente. Un hito importante fue la Ley 99 de 1993, mediante la cual se creó el Ministerio de Medio Ambiente y se incorporó el principio de desarrollo sostenible, enfatizando la responsabilidad de proteger los recursos ambientales para las generaciones futuras. Posteriormente, la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) reconoció el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un ambiente sano, mientras que la Ley 1523 de 2012 creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), estableciendo mecanismos de prevención, reducción y manejo de riesgos asociados a fenómenos naturales. A su vez, la Ley 1804 de 2016 consolidó la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, reconociendo la importancia de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo integral durante los primeros años de vida.

En materia climática, los compromisos internacionales también han impulsado avances normativos. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y,

posteriormente, el Acuerdo de París fortalecieron el reconocimiento global de los impactos de la crisis climática sobre la salud y el bienestar humano, incluyendo los de niñas y niños. En Colombia, estos compromisos se tradujeron en la Ley 1931 de 2018, que establece las directrices para la gestión del cambio climático, y en la Ley 2169 de 2021 o Ley de Acción Climática, que define metas de carbono neutralidad y resiliencia climática para mediados de siglo. Sin embargo, aunque estos instrumentos reconocen la necesidad de adaptación frente al cambio climático, la incorporación explícita de las necesidades de la primera infancia sigue siendo limitada. Asimismo, la escasez de evidencia acerca de los impactos diferenciados que la crisis climática tiene sobre niñas y niños en distintos territorios dificulta la identificación de prioridades y el diseño de intervenciones específicas (Franco et al., 2024).

A pesar de estos avances normativos, la integración entre las agendas de cambio climático, gestión del riesgo y desarrollo infantil temprano sigue siendo incipiente. Colombia cuenta con instrumentos robustos para cada uno de estos ámbitos, pero su implementación ha ocurrido en gran medida de forma paralela. Como resultado, las necesidades específicas de la primera infancia suelen ser poco visibles en los sistemas de alerta temprana, los planes de adaptación, los mecanismos de respuesta ante emergencias y las estrategias de recuperación posteriores a los desastres. La reciente nota de política sobre atención integral a la primera infancia en contextos de crisis prolongadas señala que, aunque existen importantes capacidades institucionales para la atención de emergencias, persisten desafíos de coordinación, financiación y monitoreo que limitan la inclusión sistemática de la primera infancia dentro de los procesos de gestión del riesgo y respuesta humanitaria (Cuartas, Moya, et al., 2025).

# Salud y nutrición

### 1. Magnitud del problema

En la Política de Cero a Siempre, la salud y la nutrición son dos de las atenciones priorizadas para niñas y niños, garantizadas desde la gestación hasta los seis años (Ley 1804 de 2016). Aunque se complementan, cada componente cubre acciones distintas: salud abarca las atenciones médicas básicas, controles de crecimiento y desarrollo desde el embarazo, vacunación, detección temprana

de afectaciones físicas y salud oral, mientras que nutrición comprende la promoción de la lactancia materna y la seguridad alimentaria y nutricional (Presidencia de la República de Colombia, 2013).

El boletín *Datos para el Cambio de la Primera Infancia* (ICBF, 2025b) muestra el estado de la atención en salud con corte al 2024. En salud materno-fetal hay avances: 97-98 % de los partos se atienden con personal calificado, aunque solo el 53,6 % de las gestantes inicia control prenatal en el primer trimestre. En vacunación, el país sigue por debajo de la meta del 95 %, ya que la cobertura de BCG, que protege al recién nacido de formas graves de tuberculosis (Instituto Nacional de Salud, 2013), y de la tercera dosis de pentavalente, que previene meningitis, neumonía, discapacidad permanente o muerte (Secretaría de Salud de Bogotá, 2026), osciló entre 82,7 % y 89,4 % a nivel nacional, con Buenaventura, Vaupés y Vichada como las más rezagadas. La mortalidad de menores de cinco años ha bajado en los últimos dos años, pero sus principales causas siguen siendo congénitas y perinatales, seguidas de infecciones respiratorias agudas (ICBF, 2025b).

Para reportar el estado actual de la lactancia materna y el estado nutricional de los niños, se hace uso de la encuesta ENSIN, la cual es un estudio estadístico que mide los problemas nutricionales de la población colombiana (ICBF, 2026), y la cual debe ser realizada cada cinco años. No obstante, la ENSIN del 2015 fue publicada en el 2018, es decir, tiene un retraso de 11 años, lo cual limita de manera significativa la focalización de políticas y programas. En este sentido, el reporte del estado actual del acceso a la lactancia materna se tomará en cuenta usando la ENSIN del 2010 (ICBF, 2011) y la ENSIN 2015 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015), y respecto al estado nutricional, se tomará en cuenta el sistema de seguimiento del Instituto Nacional de Salud, el ICBF y el DANE, los cuales muestran un panorama actualizado. Así mismo, para dar una claridad de los datos de la ENSIN 2010, 2015 y su comparación con las metas de la ODS (UNICEF, 2023), se presenta la Tabla 3.

El acceso a la lactancia materna exclusiva, muestra una tendencia preocupante: según la ENSIN, aumentó de forma sostenida hasta 2005 (46,9 %), pero desde entonces ha retrocedido a 42,8 % en 2010 y 36,1 % en 2015, última cifra oficial, por debajo de la meta ODS de superar el 50 %, pese a los avances en políticas de promoción (ICBF, 2025b).

**Tabla 3.** Indicadores de nutrición en primera infancia en Colombia: ENSIN 2010 y 2015 frente a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

| | ENSIN 2010 (%) | ENSIN 2015 (%) | Meta 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible (%) |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva | 56,6 | 36,1 | 51 |
| Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años | 13,2 | 10,8 | 5 |
| Prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años | 0,9 | 1,6 | 1 |
| Tasa de mortalidad por desnutrición de menores de 5 años | - | 6,8 | 5 |
| Prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años | 4,9 | 6,3 | Reducir y mantener la prevalencia de sobrepeso infantil por debajo del 5%. |

*Fuente: Elaboración propia con base en ENSIN 2010, ENSIN 2015 y metas ODS 2030.*

En nutrición infantil, con datos de SIVIGILA (INS), el ICBF y el DANE a 2025, la desnutrición aguda en menores de cinco años tiende a la baja: se redujo 16,23 % en 2025 frente a 2024, con una proyección similar para 2026. La mejora es parcial, pues el 21,2 % de los niños recuperados recae antes de tres meses. Los lugares más afectados, La Guajira, Chocó, Vichada, Magdalena, Guaviare, Risaralda, Arauca, Cartagena, Amazonas, Vaupés y Cesar, tienen alta población indígena y rural, donde los menores de dos años son los más vulnerables (Instituto Nacional de Salud, 2025).

La mortalidad por desnutrición también tiende a la baja, pasando de 772 casos en 2023, 665 en 2024 y 509 en 2025, aunque Chocó, Bolívar y La Guajira siguen muy por encima del promedio nacional (Instituto Nacional de Salud, 2026).

En sobrepeso, el dato más reciente sigue siendo el de la ENSIN 2015: uno de cada cuatro niñas y niños entre 5 y 12 años presenta exceso de peso (Red PaPaz, 2026), un panorama que evidencia el auge de los ultraprocesados (Organización Panamericana de la Salud, 2019) y que también erosiona la lactancia materna, pues muchos padres la sustituyen por leches de fórmula (Instituto Nacional de Salud, 2026).

El aumento del consumo de ultraprocesados sigue siendo un problema central de salud pública: su escaso o nulo contenido de alimentos enteros y su alto aporte de energía, azúcares y grasas saturadas exponen a los niños y niñas a deficiencias de micronutrientes y mayor propensión al

sobrepeso (Petridi et al., 2025). Su consumo también moldea preferencias y hábitos duraderos, pues el exceso de azúcar, sodio y saborizantes dificulta la aceptación posterior de frutas y verduras y afecta el apetito y la energía; además, sus aditivos estimulan al cerebro a desear más consumo, aumentando la probabilidad de ansiedad, hiperactividad o desánimo (Red PaPaz, 2024). Buena parte del problema responde a estrategias de mercadeo dirigidas a la niñez, con personajes, imágenes llamativas y afirmaciones de salud (Munguía et al., 2026).

Finalmente, las debilidades en salud y nutrición en la primera infancia colombiana responden también a causas estructurales: la desigualdad y la pobreza generan inseguridad alimentaria, agravada por factores étnicos y de zona de residencia (Rojas, 2023), a lo que se suma un sistema sanitario y de protección social débil, con acceso limitado a agua potable, saneamiento y atención oportuna, el conflicto armado, la falta de educación y la crisis climática (Arcila Carmona et al., 2023).

**2. Efectos en el desarrollo de la primera infancia**

La nutrición y la salud son pilares del desarrollo en la primera infancia, sobre todo durante la gestación y los primeros 1.000 días de vida, cuando el cerebro y el cuerpo demandan más nutrientes por el ritmo acelerado de crecimiento (UNICEF, s. f.).

La lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses previene infecciones, desnutrición y deterioros en el desarrollo cognitivo y social a largo plazo (Feleke et al., 2021). La malnutrición infantil, por su parte, se clasifica en cuatro modalidades: desnutrición aguda (pérdida severa de peso y masa muscular), desnutrición crónica (baja estatura para la edad), deficiencia de micronutrientes (carencia de vitaminas y minerales esenciales) y sobrealimentación (consumo excesivo de calorías) (Save the Children, 2026).

Sus consecuencias son distintas, pero igual de graves: la desnutrición limita el potencial físico y cognitivo de los menores de cinco años y se convierte en determinante de pobreza multigeneracional. La desnutrición aguda es el riesgo más inmediato, pues sin tratamiento oportuno puede causar la muerte (ICBF, 2025b); la crónica, aunque rara vez fatal a corto plazo, deja daños permanentes en el sistema inmunológico y el desarrollo cerebral (Acción contra el Hambre, 2025a); y la sobrealimentación eleva el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles

desde edades tempranas, como diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular (Organización Mundial de la Salud, 2025).

## 3. Marco de política, programas e intervenciones

El Estado colombiano ha construido un marco progresivo de protección en salud y nutrición para la primera infancia. La Constitución de 1991 consagra la salud y una alimentación nutritiva como derecho fundamental de niñas y niños, extendido a las mujeres gestantes (Constitución Política de Colombia, 1991). En el ámbito de salud, antes de la Política de Cero a Siempre, el país ya tenía un esquema de atención sustentado en la Ley 100 de 1993, con priorización de la mujer gestante para reducir la mortalidad infantil; pero fue con Cero a Siempre que la atención integral a la primera infancia se volvió prioridad nacional.

Bajo esta política, el Ministerio de Salud y Protección Social lidera las atenciones en salud: su primera intervención fue garantizar la afiliación en salud de todo recién nacido, y desde ahí ha ampliado la atención a gestantes con las Salas Amigas de la Lactancia en el trabajo, el Plan Decenal de Salud Pública y leyes de protección a la maternidad (ICBF, 2025). A través de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAPMS), la gestante y el niño o niña reciben al menos doce consultas de valoración, y mediante el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) acceden a vacunación gratuita y obligatoria, 22 vacunas contra 30 enfermedades (ICBF, 2025).

En nutrición, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2008) integró la atención nutricional como línea estratégica desde 2016. Junto con Cero a Siempre, el ICBF lidera: Mil Días para Cambiar el Mundo, que previene la malnutrición en todas sus formas con énfasis en salud, alimentación, lactancia, crianza y participación (ICBF, 2017); los Centros de Recuperación Nutricional (13 centros en 9 departamentos), que atienden desnutrición aguda durante 30-60 días con equipos de medicina, nutrición y enfermería; los Centros de Recuperación Nutricional Comunitarios (16 unidades en 10 departamentos) para zonas rurales dispersas; y las Unidades de Búsqueda Activa (UBA), equipos móviles que identifican y activan rutas de atención para niños con desnutrición aguda y gestantes con bajo peso (ICBF, 2025).

Frente a la sobrealimentación, el ICBF solo ofrece orientaciones generales en sus guías para cuidadores, sin un programa específico para menores de cinco años. Sí existen avances legales

para reducir el consumo de ultraprocesados, aún insuficientes: la Ley 2120 de 2021 (etiquetado frontal) y la Ley 2277 de 2022 (impuestos disuasorios) (Gaceta del Congreso, 2026).

En conclusión, Colombia avanza en la atención hospitalaria del parto y en la reducción de la desnutrición aguda y la mortalidad infantil, gracias a la expansión de la búsqueda activa en zonas rurales, la atención nutricional integrada en Cero a Siempre y los avances legales en protección materna y regulación de ultraprocesados. SIVIGILA ha fortalecido el seguimiento y la coordinación entre DANE, ICBF y Ministerio de Salud, mejor reflejada en el trabajo conjunto de las UBA y los Centros de Recuperación Nutricional.

No obstante, persisten retos importantes: la falta de datos actualizados por el atraso de más de una década en la ENSIN; la caída sostenida en la lactancia materna exclusiva; y el creciente consumo de ultraprocesados, que altera las prácticas alimentarias del país e incide en la salud y nutrición de los menores de cinco años.

# Migración y desplazamiento forzados

### 1. Magnitud del problema

En Colombia, miles de familias se ven forzadas diariamente a abandonar sus hogares y comunidades debido a las situaciones derivadas del conflicto armado y los desastres naturales, como se ha discutido en apartados anteriores de este informe. Asimismo, por su ubicación entre Centroamérica y Suramérica, Colombia ha sido durante décadas un país de tránsito para personas de distintas nacionalidades que buscan establecerse en el norte del continente o desplazarse hacia el sur, debido, entre otras razones, a la inestabilidad o la persecución política en sus países de origen. En este contexto, en 2023 la crisis de desplazamiento en Colombia fue identificada como una de las más desatendidas del mundo (Luna, 2024).

No es fácil contar con cifras precisas sobre la magnitud del desplazamiento y la migración forzada de niñas y niños en la primera infancia. Como se evidenció en las entrevistas realizadas para este informe, los registros administrativos no siempre utilizan los mismos rangos etarios, los censos

efectuados durante las emergencias no siempre contabilizan a la primera infancia y algunas situaciones, como el conflicto armado colombiano, se han prolongado durante tantas décadas que es difícil dimensionar con exactitud la magnitud histórica del problema frente a esta población.

En cuanto al desplazamiento forzado asociado al conflicto armado, las más de seis décadas de violencia han situado a Colombia como el segundo país con mayor número de personas desplazadas internamente, con 7,2 millones (Defensoría del Pueblo, 2026). Además, como se mencionó anteriormente en este informe, se estima que el 25 % de la primera infancia colombiana vive en municipios afectados por el conflicto (DANE, 2024). En mayo de 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó que los desplazamientos internos habían aumentado un 117 % frente al mismo periodo del año anterior, como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado. Según la organización, esta situación podría haber generado las mayores necesidades humanitarias registradas en el país durante la última década (ICRC, 2025).

Los fenómenos naturales, cuya frecuencia e intensidad se ven agravadas por el cambio climático, también pueden obligar a las familias a desplazarse, como se señala en el apartado dedicado a cambio climático en este mismo informe. El DANE (2024) calcula que alrededor de 1,07 millones de niñas y niños en la primera infancia viven en municipios priorizados por su nivel de riesgo climático. La incidencia de estos fenómenos sobre el desplazamiento es considerable: en 2023, los desplazamientos internos ocasionados por desastres superaron los asociados al conflicto armado durante ese mismo año (Uniandes, s.f.).

Finalmente, la migración transfronteriza se intensificó durante las últimas décadas, tanto por la llegada de personas con vocación de permanencia como por el tránsito de población hacia otros países. Actualmente, más de 2,7 millones de personas venezolanas residen en Colombia, sin contar a quienes se encuentran en situación migratoria irregular, lo que convierte al país en el principal receptor de población venezolana (OM3, 2025). En 2025, el 6,86 % de esta población correspondía a niñas y niños en la primera infancia, equivalentes a 188.510 personas (Migración Colombia, 2025).

Al mismo tiempo, Colombia ha sido históricamente un país de tránsito para personas que se desplazan hacia el norte o el sur del continente, fenómeno que se ha intensificado en las últimas décadas. Entre sus antecedentes se encuentran la salida de población haitiana tras el terremoto de 2010 (Fidalgo, 2020) y la crisis venezolana, que en 2015 provocó un éxodo masivo de personas venezolanas que transitaban por el país o buscaban establecerse en él (GIFMM, 2024). La magnitud de estos movimientos ha sido considerable. En 2023, más de 540.000 personas procedentes de más de 35 países fueron registradas mientras transitaban de Colombia a Panamá a través del Tapón del Darién. Solamente durante la primera mitad de ese año, alrededor de 30.000 niñas y niños fueron registrados en esta ruta (UNHCR, 2024; UNICEF, 2024). Aunque en 2025 la migración transfronteriza desde Colombia hacia el norte del continente disminuyó cerca de un 91 %, principalmente debido a cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos y Panamá, comenzaron a reportarse movimientos en sentido contrario, desde el norte hacia el sur del continente, también en tránsito por Colombia. La magnitud de estos flujos aún no se conoce con claridad debido a las limitadas capacidades de monitoreo y respuesta (GTPIE, 2026; IRC & CJN, 2025). Sin embargo, se estima que, entre enero de 2025 y enero de 2026, por cada persona que salió de Colombia hacia el norte, siete se desplazaron en sentido contrario, hacia el sur (OIM, 2026).

## 2. Impacto en el desarrollo infantil

La primera infancia expuesta a la migración o al desplazamiento forzado enfrenta riesgos propios de estos procesos, que se superponen con otras adversidades abordadas en este informe, como la pobreza, la violencia, la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático. La naturaleza y magnitud de estas afectaciones varían según las condiciones previas de las familias y el momento del proceso migratorio o de desplazamiento, desde la crisis que origina el movimiento y el trayecto hasta las etapas posteriores de asentamiento o retorno.

Desde el inicio, las condiciones económicas y sociales de las familias influyen en las circunstancias en las que pueden desplazarse y buscar un lugar seguro. Menores recursos pueden traducirse en trayectos más precarios y mayores dificultades para acceder posteriormente a condiciones mínimas de bienestar (Bueno, 2024). Esto puede implicar, por ejemplo, atravesar a pie el Tapón del Darién

con apoyo de redes ilegales, realizar trayectos en embarcaciones precarias o sin medidas adecuadas de seguridad, o caminar durante largos periodos enfrentando cambios de temperatura y altura y sin certeza sobre dónde dormir (Acción contra el Hambre, 2025b; MMC, 2025; MMC & ProLAC, 2025).

Durante estos trayectos, niñas y niños pueden estar expuestos a múltiples vulneraciones de sus derechos, independientemente de su nacionalidad o de la causa del desplazamiento (OACDH, 2015). Entre los riesgos documentados se encuentran la exposición a terrenos y condiciones climáticas adversas; la falta de agua potable y alimentos, con riesgo de deshidratación y desnutrición; jornadas de movimiento poco acordes con sus capacidades físicas; y el contacto con grupos criminales y redes ilegales. También se han documentado riesgos de violencia, abuso sexual, secuestro, violencia basada en género, robo y trata, así como periodos prolongados con pocas oportunidades de juego, estimulación y socialización (Daga et al., 2024; Defensoría del Pueblo, 2024a; Duvillier et al., 2023; GIFMM, 2023; Luna, 2024). A esto se suma el estrés asociado con el peligro, la incertidumbre y los cambios constantes. Cuando la respuesta de estrés se mantiene activada de manera prolongada y no existen factores que ayuden a mitigarla, puede afectar distintos sistemas fisiológicos a corto y largo plazo (Nelson & Gabard-Durnam, 2020; National Scientific Council on the Developing Child, 2014), además de asociarse posteriormente con afectaciones socioemocionales y de salud mental, como ansiedad, depresión y estrés postraumático (Daga et al., 2024; Gillespie et al., 2022).

El desplazamiento y la migración también afectan directamente a madres, padres y otros cuidadores, generando una vía adicional de impacto sobre la primera infancia. Las afectaciones físicas, psicológicas y emocionales que experimentan los cuidadores pueden alterar las condiciones en las que ocurre la crianza y limitar, incluso cuando existe la intención de hacerlo, su capacidad para ofrecer estabilidad, protección y cuidado sensible a las necesidades de niñas y niños (Cuartas, 2021; GIFMM, 2024; Gillespie et al., 2022; Sánchez-Ariza et al., 2023). Una salud mental deteriorada y mayores dificultades para regular las propias emociones pueden incrementar el riesgo de negligencia y de respuestas impulsivas o violentas frente al comportamiento infantil (Daelmans et al., 2021; Eltanamly et al., 2021; Evans, 2019; Miller et al., 2021). Esto resulta particularmente relevante en contextos, como el del desplazamiento o migración forzada, en los

que la incertidumbre, la inestabilidad y las necesidades básicas insatisfechas también pueden aumentar la desregulación emocional de niñas y niños.

Estas afectaciones directas e indirectas pueden acumularse con adversidades experimentadas antes, durante y después del desplazamiento. Las familias pueden iniciar el movimiento tras haber estado expuestas previamente al conflicto armado u otras experiencias con consecuencias físicas, emocionales o psicológicas, y posteriormente enfrentar inestabilidad habitacional, dificultades para acceder a servicios esenciales y ausencia de redes de apoyo durante el trayecto o el asentamiento (Daga et al., 2024; Defensoría del Pueblo, 2024a; Duvillier et al., 2023). Además, las personas afrodescendientes, indígenas, con discapacidad o pertenecientes a comunidades marginalizadas pueden enfrentar riesgos adicionales derivados de la exclusión, discriminación y maltrato antes, durante y después del movimiento, en un contexto en el que persisten importantes vacíos de información sobre sus experiencias (Canal Laiton, 2025; Luna, 2024). La acumulación y repetición de estas adversidades, incluidos nuevos desplazamientos, puede profundizar situaciones de vulnerabilidad ya existentes.

Finalmente, llegar a un lugar de destino o regresar al lugar de origen no implica necesariamente el fin de estas afectaciones. Alcanzar condiciones mínimas de estabilidad y acceder a vivienda, salud, educación y apoyo institucional puede tomar tiempo y constituir en sí mismo una fuente adicional de estrés. Las familias también pueden enfrentar xenofobia y discriminación en las comunidades receptoras y, en algunos casos, asentarse en territorios que presentan a su vez condiciones de conflicto o alta exposición a fenómenos naturales, prolongando así las condiciones de inseguridad que acompañaron el desplazamiento (Cuartas, Moya, et al., 2025; Gillespie et al., 2022; Sánchez-Ariza et al., 2023).

## 3. Marco de política, programas e intervenciones

En Colombia existe un marco normativo amplio para la protección de la primera infancia en contextos de desplazamiento, migración y emergencia. La Ley 1804 de 2016, que establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, prioriza a niñas y niños expuestos a vulneraciones de derechos y establece la corresponsabilidad de los

distintos sectores en la garantía de su atención integral. A esto se suman normas específicas sobre desplazamiento forzado por conflicto armado (Ley 387 de 1997, Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional y Ley 1448 de 2011), migración (Ley 2136 de 2021) y gestión del riesgo de desastres (Ley 1523 de 2012).

Sin embargo, expertos nacionales consultados para este informe identificaron cinco vacíos principales entre este marco y la respuesta que recibe la primera infancia durante las emergencias. Primero, persiste una limitada priorización de la primera infancia desde el inicio de la respuesta y una comprensión desigual entre actores sobre sus necesidades específicas. Segundo, falta traducir el marco de política en acciones concretas para esta población, diferenciando las atenciones requeridas durante la emergencia de aquellas necesarias en etapas posteriores de estabilización. Esto incluye especificar las atenciones de la Ruta Integral de Atenciones pertinentes para contextos de emergencia y definir cómo deben implementarse en los territorios. Colombia ha tenido grandes avances y aprendizajes en lograr movilizar la arquitectura institucional para responder a emergencias, pero la intencionalidad en la respuesta a la primera infancia aún debe fortalecerse.

Tercero, la respuesta continúa organizándose principalmente por sectores, como salud, protección o agua, saneamiento e higiene, sin una articulación suficiente alrededor de las necesidades integrales de la primera infancia. Esta fragmentación también se refleja en la coexistencia de sistemas responsables de distintos tipos de emergencia, lo que exige fortalecer su articulación, tanto nacional como local, alrededor de la política de primera infancia. Cuarto, existen vacíos en el seguimiento y los sistemas de información: los registros de distintos actores no siempre se integran ni desagregan la información por momentos del curso de vida, dificultando identificar y hacer seguimiento a la primera infancia afectada.

Finalmente, persisten retos de financiación y oportunidad de la respuesta. Los mecanismos utilizados durante emergencias del 2025 han mostrado que es posible movilizar recursos nacionales hacia los territorios, pero se requieren mecanismos financieros sostenibles y ágiles que permitan responder localmente sin depender de procesos administrativos prolongados o exclusivamente de recursos de cooperación internacional.

Con respecto a las iniciativas implementadas, Colombia cuenta con capacidades institucionales relevantes para responder a emergencias, como la movilización de recursos y esfuerzos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y la atención súbita con las unidades móviles y Equipos Móviles de Respuesta y Atención al Migrante (ERAM) del ICBF. Sin embargo, como se señaló anteriormente, es necesario fortalecer en estas respuestas la priorización explícita de la primera infancia.

Dentro de la arquitectura humanitaria, distintos sectores articulados en la Mesa de Trabajo de Primera Infancia en Emergencias desarrollan respuestas desde sus respectivos ámbitos de acción. Entre las iniciativas con un enfoque explícito en desarrollo infantil y relaciones de cuidado se han implementado programas basados en la evidencia dirigidos a promover el desarrollo integral de niñas y niños y fortalecer las relaciones de cuidado, tanto entre familias en movimiento como entre aquellas ya asentadas. Entre ellos se encuentran los Puntos de Información y Orientación (PIO) de UNICEF (Diálogo Interamericano, 2025), Jugar para Soñar del International Rescue Committee y la Corporación Juego y Niñez (Valenzuela et al., 2023), y Hola Sésamo (Daga et al., 2024). Sin embargo, la reducción de la financiación humanitaria ha llevado al cierre o reducción de varias de estas iniciativas.

Adicionalmente, desde la academia y organizaciones de la sociedad civil se han desarrollado otras iniciativas basadas en la evidencia como Semillas de Apego, centrada en la salud mental de cuidadores de primera infancia (Jaramillo & Bonet de Vivero, 2024), y las estrategias de difusión de contenidos mediante redes sociales y radios comunitarias desarrolladas por Fundación Apapacho a partir de los contenidos de Parenting for Lifelong Health dirigidos a madres, padres, cuidadores, operadores de intervenciones y comunidades en general (Fundación Apapacho, 2026).

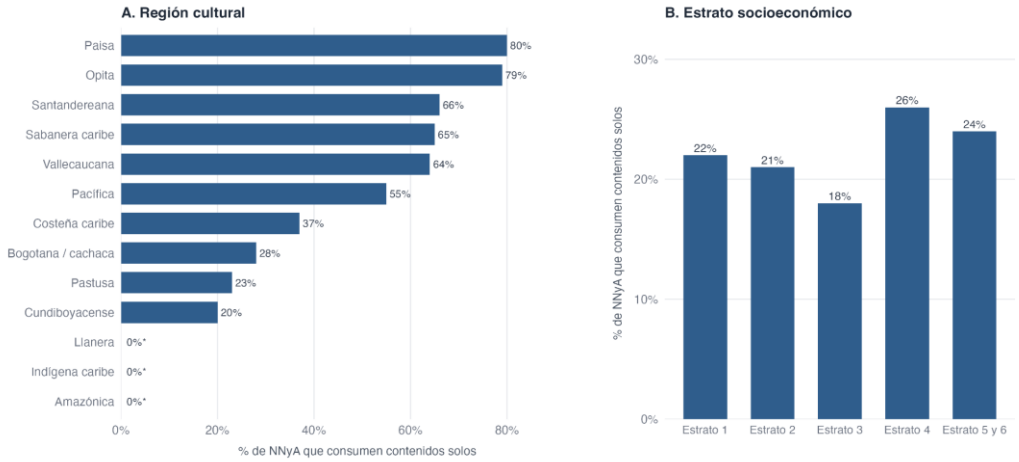
## Nuevas tecnologías, inteligencia artificial y primera infancia

### 1. Prevalencia

En pocos años, el entorno digital se ha vuelto parte de la vida cotidiana de niñas y niños desde la primera infancia. Las pantallas, las plataformas y, más recientemente, los sistemas de inteligencia artificial (IA) -algoritmos que perfilan al usuario y devuelven respuestas ajustadas a sus intereses, como chatbots (ChatGPT, Gemini), asistentes de voz (Alexa, Siri) y motores de recomendación de redes sociales- modulan las interacciones cuidador-niño y, por extensión, los procesos de desarrollo. Para la primera infancia esto es particularmente importante: el cerebro y los sistemas de regulación están en pleno desarrollo, la dependencia del cuidador es máxima, y los hábitos digitales construidos en estos años afectarán las trayectorias posteriores de uso de la tecnología.

La presencia de pantallas en los hogares colombianos es alta y transversal a los estratos socioeconómicos (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2024). De acuerdo con el estudio Infancia y medios audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (2024), niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años pasan en promedio 8,9 horas diarias frente a pantallas entre semana y el 61% tiene celular propio. Esta exposición también se refleja en el uso de redes sociales. En un estudio realizado por la Universidad de los Andes en niñas, niños y adolescentes entre los 9 y los 12 años, el 73% reportó tener un perfil en alguna red social; de estos, el 29% tenía una edad inferior a la mínima permitida por los términos y condiciones de las plataformas (Universidad de los Andes et al., 2024). La IA ingresa al hogar con muy baja fricción, ya que basta un celular conectado para acceder a chatbots y AI companions. Frente a esta masificación, la brecha crítica ha dejado de ser el hardware y se ha desplazado al “software”, es decir, la brecha actual es el conocimiento, la alfabetización digital y los criterios de uso que les permiten a los cuidadores acompañar, filtrar y dar sentido a las interacciones digitales. Los cuidadores, sin embargo, no suelen acompañar esas interacciones: el consumo en solitario de medios audiovisuales en niñas, niños y adolescentes varía poco entre estratos (18-26%) y es bastante marcado en algunas regiones culturales de acuerdo con los datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (Figura 4).

**Figura 4.** Consumo solitario de medios audiovisuales en niñas, niños y adolescentes




## 2. Efectos en el desarrollo

La evidencia sobre los efectos de la exposición temprana a nuevas tecnologías es aún incipiente, pero converge hacia los cuatro grandes mecanismos que podrían exacerbar algunos riesgos para el desarrollo temprano.

Primero, el uso temprano e intensivo de pantallas se asocia con peores indicadores de salud mental años después: en una muestra global de 27.969 jóvenes, incluida Colombia, cuanto menor la edad de adquisición del primer teléfono inteligente, peor el bienestar mental adulto, con incrementos en pensamientos suicidas, agresividad y sensación de desconexión, especialmente en mujeres (Sapien Labs, 2023).

Segundo, las pantallas pueden reducir oportunidades de práctica para habilidades fundamentales: un estudio longitudinal canadiense con 2.441 díadas madre-hijo encontró que mayor tiempo de pantalla a los 24 meses predice peor desempeño en tamizajes del desarrollo a los 36 meses (Madigan et al., 2019), y en preescolares de 3 a 5 años un mayor uso de pantallas se asoció con menor integridad de la materia blanca en tractos cerebrales del lenguaje (Hutton et al., 2020).

Tercero, los entornos digitales y de IA incorporan estrategias persuasivas, recompensas variables, manipulación emocional por personajes, validación afectiva de chatbots, diseñadas para maximizar el enganche; análisis muestran que la inmensa mayoría de las aplicaciones dirigidas a menores de cinco años incluyen estos mecanismos (Meyer et al., 2019).

Cuarto, niñas y niños están expuestos a riesgos directos, contenidos sobre autolesión y violencia, contacto con desconocidos, perfilación algorítmica, casos emergentes de grooming por IA, entre otros, riesgos que se amplifican cuando los algoritmos perfilan a usuarios menores de edad (Universidad de los Andes et al., 2024).

Esta evidencia, sin embargo, no cubre cómo las nuevas tecnologías y la IA afectan las relaciones de las niñas, niños y adolescentes con su cuidador, la calidad de la educación inicial, o la prevención de violencia (entre otros factores de la ecología del desarrollo). Por ende, es necesario adelantar más investigaciones sobre el tema que permitan informar decisiones de política e intervenciones que maximicen los posibles beneficios de dichas tecnologías y ayuden a mitigar sus riesgos.

## 3. Marco de política y recomendaciones

Hasta hace poco, el marco colombiano de protección a la primera infancia no abordaba explícitamente los entornos digitales ni la IA. El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y la Política de Estado De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016) son anteriores a la masificación de estas tecnologías, y ni la protección de datos (Ley 1581 de 2012) ni la política de transformación digital e IA (CONPES 3975 de 2019) se diseñaron desde el desarrollo infantil temprano. Esto empezó a cambiar con la Ley 2489 de 2025 y su reglamentación (Decreto 0769 de 2026), que establecen una política de entornos digitales sanos y seguros para niñas, niños y adolescentes, basada en la corresponsabilidad entre Estado, industria tecnológica, instituciones educativas y familias. El decreto desarrolla obligaciones para los proveedores de servicios digitales, incluyendo medidas de protección diferenciadas según la edad y mecanismos para reducir la exposición de los menores a riesgos y violencias en línea. El nuevo marco, aun así, todavía no se traduce en acciones centradas en la díada niña, niño, adolescente y cuidador. Esa díada también puede beneficiarse de herramientas digitales bien diseñadas, como los programas de crianza entregados digitalmente (Fink et al., 2026), siempre como complemento de la interacción humana, no como su sustituto. Las propuestas para cerrar ese vacío se presentan en la sección Recomendaciones de política.

# Sistemas de datos, monitoreo y valoración del desarrollo infantil temprano

Más allá de los avances en la consolidación de la política pública de primera infancia, el seguimiento al desarrollo de niños y niñas constituye un desafío estructural para el país. Este reto no se origina necesariamente en la ausencia de información, sino en la forma en que los datos disponibles se encuentran organizados: múltiples fuentes, con distintos niveles de representatividad, periodicidad y unidades de análisis, que en conjunto configuran una arquitectura fragmentada para la medición del desarrollo infantil. En Colombia, esta arquitectura se ha construido de manera incremental alrededor de tres grandes tipos de fuentes: (1) registros administrativos, (2) encuestas de hogares y (3) encuestas y estudios específicos.

### 1. Registros administrativos

Los registros administrativos conforman el núcleo del seguimiento a la provisión de servicios de primera infancia. En este grupo se incluyen, por ejemplo, el sistema Cuéntame, el Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) y el SSDIPI, entre otros. Estos sistemas consolidan información sobre la atención a la primera infancia, incluyendo cobertura de beneficiarios, modalidades de atención y cumplimiento de indicadores asociados a las atenciones priorizadas, a partir de datos provenientes de múltiples entidades del Estado. Dichas fuentes han sido claves para monitorear el estado de la niñez colombiana tanto a nivel agregado, permitiendo analizar avances y brechas a escala nacional (por ejemplo, mediante la serie Datos para el Cambio), como a nivel individual, posibilitando el seguimiento niño a niño. No obstante, estos sistemas presentan altos niveles de fragmentación, no ofrecen valoraciones estandarizadas del desarrollo infantil y, además, gran parte de sus datos resulta de difícil acceso para la comunidad académica y de investigación.

### 2. Encuestas de hogares nacionales

En segundo lugar, mientras los registros administrativos permiten observar la oferta institucional de servicios, las encuestas de hogares nacionales posibilitan caracterizar el contexto en el que dicha oferta se inserta. En este grupo se destacan la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), la ENUT y la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), entre otras. Estas encuestas cuentan generalmente con representatividad nacional

y subnacional y ofrecen información sociodemográfica, sobre arreglos de cuidado, acceso a servicios de atención integral, salud materno-infantil, nutrición, algunas prácticas de crianza y condiciones del hogar de niños y niñas menores de cinco años. Sin embargo, ninguna de ellas incorpora mediciones directas del desarrollo infantil temprano y, en términos generales, abordan de manera limitada dimensiones clave como las prácticas de crianza, la violencia en el hogar o la calidad de la educación inicial.

**3. Encuestas y estudios específicos**

Finalmente, Colombia dispone de encuestas y estudios específicos que incluyen información más detallada sobre el desarrollo infantil. Un ejemplo es la ELCO, que, aunque no se centra exclusivamente en la primera infancia, incorpora un módulo específico para este grupo etario con información sobre desarrollo infantil, prácticas de crianza y acceso a educación inicial. En el marco de esta encuesta se han utilizado instrumentos como el Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP), el Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) y el Ages and Stages Questionnaire (ASQ). Otro referente es el estudio de Medición de la Calidad de la Educación Inicial en Colombia (Maldonado-Carreño et al., 2022), que empleó el instrumento International Development and Early Learning Assessment (IDELA) para valorar el desarrollo infantil temprano y MELQO para medir la calidad estructural y de procesos en la modalidad institucional del ICBF. Adicionalmente, se destaca el estudio longitudinal liderado por el Ministerio de Educación cuya línea de base se recogerá en 2026.

**4. Estado de la valoración del desarrollo infantil temprano en Colombia**

A pesar de estos avances, la valoración del desarrollo infantil temprano en Colombia sigue siendo limitada, dispersa y poco sistemática. Aunque se han utilizado diversos instrumentos, entre ellos TVIP, SDQ, ASQ e IDELA, su aplicación ha estado circunscrita principalmente a estudios específicos y no se ha integrado de manera consistente en sistemas de monitoreo poblacional. Asimismo, herramientas ampliamente utilizadas en el país, como la Escala Abreviada de Desarrollo (EAD) y la Escala Cualitativa de Desarrollo (ECD), presentan limitaciones en términos de estandarización, comparabilidad y disponibilidad de datos para investigación. La evidencia sugiere que la utilidad de los instrumentos de medición depende críticamente de su validez, adecuación cultural y capacidad para generar datos comparables en el tiempo y entre poblaciones.

En este sentido, iniciativas globales como el Índice de Desarrollo Infantil Temprano (ECDI) y las Escalas Globales de Desarrollo Temprano (GSED) ofrecen referentes relevantes sobre cómo mediciones integrales y comparables podrían fortalecer una agenda nacional de valoración del desarrollo infantil que articule sistemas de información y promueva el uso de métricas estandarizadas para orientar la política pública.

Estas limitaciones no se circunscriben exclusivamente a la medición del desarrollo infantil temprano, sino que reflejan un problema más estructural del país: el significativo progreso en la medición de la cobertura de atenciones y servicios contrasta con una carencia persistente de mediciones y valoraciones de procesos y calidad. La medición de la calidad de la educación inicial constituye un ejemplo ilustrativo de este desbalance; sin embargo, es necesario avanzar de manera decidida hacia la valoración sistemática de otras dimensiones igualmente determinantes para el desarrollo integral de niñas y niños. Entre ellas se destacan las prácticas de crianza en el contexto colombiano, la exposición de niños y niñas a distintas formas de violencia en el hogar y las comunidades, así como su relación con la naturaleza y su exposición a eventos climáticos extremos, por ejemplo mediante el uso de datos georreferenciados y espaciales. Asimismo, resulta cada vez más pertinente incorporar mediciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes al interior de los hogares. La integración de mediciones de proceso y calidad con valoraciones del desarrollo infantil temprano será fundamental para informar políticas y programas que permitan capitalizar los avances logrados en cobertura y maximizar su impacto en el desarrollo integral de niños y niñas.

Más allá de identificar oportunidades para fortalecer la medición y valoración del desarrollo integral, los procesos y la calidad, existen también oportunidades claras para robustecer los sistemas actuales de información con el fin de mejorar la valoración del desarrollo infantil, los contextos de desarrollo y los logros de la política pública. Entre ellas, se encuentra la necesidad de garantizar que los datos existentes puedan ser utilizados efectivamente para investigación y seguimiento, mediante la generación de versiones anonimizadas, completamente abiertas y accesibles en repositorios públicos. Idealmente, el país debería avanzar en la integración de fuentes dentro de estos repositorios, reduciendo la fragmentación de la información. En esta línea, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, en su informe 107 sobre primera infancia (LEE, 2024), destaca la coexistencia de múltiples sistemas de

información y subraya la necesidad de fortalecer su articulación para un seguimiento integral del desarrollo infantil, señalando que la información existente no siempre se traduce en una capacidad efectiva de monitorear trayectorias de desarrollo.

Una oportunidad adicional consiste en avanzar hacia la inclusión de geocódigos o información sobre ubicación geográfica como práctica estándar en la recolección de encuestas de hogares y otros instrumentos poblacionales relevantes para la primera infancia, asegurando siempre protocolos adecuados de anonimización y protección de datos. La georreferenciación de los hogares, aun cuando sea utilizada en versiones anonimizadas o agregadas para investigación, puede convertirse en una pieza clave para vincular información sociodemográfica con un universo más amplio de datos espaciales y temporales. En particular, permitiría estudiar con mayor precisión la relación entre los objetivos de desarrollo infantil temprano y factores externos asociados a choques climáticos, desastres naturales y dinámicas de conflicto armado, tales como inundaciones, sequías, terremotos o proximidad a zonas de conflicto. Los geocódigos funcionan, en este sentido, como una llave de integración entre las encuestas tradicionales y nuevas fuentes de información de bajo costo y alta precisión, incluyendo imágenes satelitales, datos climáticos, registros de eventos de conflicto y, potencialmente, patrones agregados de actividad digital. Incorporar esta dimensión espacial fortalecería la capacidad del país para comprender no sólo las condiciones internas de los hogares, sino también los entornos físicos, ambientales y sociales que condicionan las trayectorias de desarrollo de niñas y niños.

En suma, el reto central para Colombia no es necesariamente producir más información, sino transformar la información existente en una infraestructura coherente de conocimiento para la acción pública. Avanzar hacia un sistema de medición del desarrollo infantil temprano integrado, estandarizado y accesible permitiría articular cobertura, calidad y resultados en un mismo marco analítico, fortaleciendo la capacidad del Estado para monitorear trayectorias de desarrollo, reducir brechas y orientar decisiones oportunas de política. Capitalizar los avances logrados en la expansión de servicios exige ahora un salto cualitativo: pasar de medir cuánto se atiende a comprender cómo, con qué calidad y con qué impacto se está promoviendo el desarrollo integral de niños y niñas. Solo así la arquitectura de datos en primera infancia podrá convertirse en una verdadera palanca para maximizar el bienestar presente y futuro de la niñez colombiana.

## Retornos a la inversión en la primera infancia

Existe un amplio consenso sobre la importancia social de invertir en desarrollo infantil temprano, pero el debate público aún no internaliza plenamente su retorno desde la perspectiva de las finanzas públicas. El gasto en primera infancia suele observarse como un costo anual, por ejemplo, un cupo en un CDI cercano a 6 millones COP por niño por año, equivalente a aproximadamente 30 millones COP en cinco años (ICBF, 2022), mientras que el gasto en seguridad, justicia o desempleo se percibe como urgente e inevitable. Esta sección propone comparar ambas lógicas: cuánto cuesta hoy intervenir de manera reactiva frente a problemas sociales y cuánto costaría prevenir una fracción de esos mismos problemas mediante inversión temprana.

### 1. Costo de la inacción

Una dimensión central que suele omitirse en este debate es el costo de la inacción. Evidencia reciente muestra que no invertir en educación inicial y cuidado temprano implica pérdidas sociales sustanciales: garantizar al menos un año de educación inicial de calidad a todos los niños y niñas de los países de ingreso bajo y medio costaría menos del 0,15 % del PIB de esos países, y los beneficios de hacerlo son entre 8 y 19 veces mayores que sus costos (Nores et al., 2024). La inacción, por lo tanto, genera pérdidas acumuladas en capital humano, productividad y cohesión social.

### 2. Evidencia nacional sobre beneficios de la inversión en desarrollo infantil temprano

La evidencia colombiana muestra que los programas de desarrollo infantil temprano generan mejoras medibles en nutrición, lenguaje, y bienestar socioemocional, variables estrechamente asociadas a trayectorias educativas, ingresos y comportamiento futuro, aunque la magnitud de estos efectos depende de la calidad de los servicios. La evaluación de DCAS documenta mejoras en lenguaje y desarrollo integral (Bernal et al., 2017), mientras que la expansión de los CDIs muestra efectos positivos en talla para la edad y salud (Bernal & Fernández, 2013; Bernal et al., 2015). La evaluación de la política De Cero a Siempre documenta mejoras en el desarrollo del lenguaje (Bernal & Ramírez, 2018). Los Hogares Comunitarios de Bienestar muestran efectos positivos en nutrición y desarrollo cognitivo entre los niños con exposiciones prolongadas al programa (Bernal & Fernández, 2013), y la transición de Hogares Comunitarios a CDIs mejoró

la talla para la edad y redujo el sobrepeso, pero no mejoró el desarrollo cognitivo, en parte porque la calidad de las rutinas y actividades pedagógicas resultó menor en los centros (Bernal et al., 2019). Esta última evidencia es relevante para la discusión de retornos: los beneficios que se estiman en esta sección suponen servicios de calidad adecuada.

Programas parentales como Semillas de Apego, con un costo cercano a 2,9 millones COP por díada cuidador-niño, presentan relaciones beneficio-costo entre 1,6 y 8,3 dependiendo del escenario de persistencia de impactos y los supuestos de monetización, lo que implica que cada millón COP invertido genera entre 1,6 y 8,3 millones COP en beneficios en valor presente (Jaramillo & Bonet de Vivero, 2024). En paralelo, la desnutrición aguda y crónica en la primera infancia tiene un costo anual estimado en USD 60,9 millones en Colombia, que incluye la atención en salud y los costos indirectos para los hogares, sobre los que recae cerca del 65 % de la carga. Esta cifra cubre únicamente los primeros cuatro años de vida de la cohorte afectada y no incorpora las pérdidas de productividad en la edad adulta, por lo que subestima el costo total (Londoño Trujillo et al., 2024).

**3. Estimación ilustrativa de retornos**

Para ilustrar el posible retorno de esta inversión, supongamos que un niño asiste a un CDI durante cinco años. Con un costo anual de cerca de 6 millones COP (ICBF, 2022), la inversión total sería de 30 millones COP, unos USD 7.000–7.500 a una tasa de cambio de entre 4.000 y 4.300 COP por dólar. Tomemos como referencia un ingreso anual de USD 8.000, cercano al PIB per cápita de Colombia en 2024 (32,4 millones COP; DANE, 2025). Aunque supera el ingreso laboral promedio actual, lo usamos como una aproximación al ingreso que podrían tener estos niños cuando entren al mercado laboral dentro de 15 a 20 años. Si la intervención aumentara sus ingresos futuros en un 10 %, el beneficio adicional sería de unos USD 800 al año por persona. Este supuesto está por debajo del aumento cercano al 25 % encontrado en una evaluación de largo plazo de un programa de primera infancia en Jamaica (Gertler et al., 2014). A lo largo de una vida laboral de 40 años, esto equivale a cerca de USD 32.000 en beneficios no descontados. Asumiendo que los beneficios se materializan en la edad adulta (aproximadamente 15 años después de la intervención) y descontando a una tasa social del 5 %, el valor presente del beneficio privado se sitúa en torno a USD 6.500–7.000.

Además de los mayores ingresos, la inversión puede generar beneficios sociales, como menor criminalidad, menor gasto en salud y mayor estabilidad laboral. Las evaluaciones de largo plazo de programas de primera infancia muestran que estos beneficios pueden representar una parte importante del retorno total e incluso superar las ganancias salariales de los participantes (García et al., 2020; Heckman, 2006). Para este ejemplo, supongamos que equivalen al 50 % del beneficio privado estimado, unos USD 3.300 adicionales por niño. Con esto, el beneficio total sería de entre USD 9.500 y 10.500 por niño. Frente a un costo de USD 7.000–7.500, esto equivale a un retorno de entre 1,3 y 1,5 dólares por cada dólar invertido. El cálculo es conservador porque no descuenta los costos. Si los beneficios comenzaran antes, diez años después de la intervención, o si los salarios crecieran un 2 % anual en términos reales, el retorno subiría a entre 1,8 y 1,9 dólares por dólar invertido. Al combinar ambos supuestos, llegaría a entre 2,0 y 2,5 dólares. Aunque estas cifras son menores que las estimaciones internacionales citadas antes, que incluyen intervenciones más intensivas o una valoración más amplia de los beneficios, apuntan en la misma dirección: invertir en la primera infancia puede generar beneficios superiores a sus costos y reducir la necesidad de gasto público para atender problemas más adelante.

## 4. Costos de intervenir tardíamente en Colombia

En Colombia, los costos de intervenir tardíamente son altos. Los costos directos estimados del crimen y la violencia, incluyendo pérdidas de capital humano (0,9 % del PIB), gasto privado en seguridad (1,8 % del PIB) y gasto público en policía, justicia y sistema penitenciario (1,0 % del PIB), equivalen a aproximadamente 3,6 % del PIB del 2022 (≈ 68 billones COP anuales) (Perez-Vincent et al., 2024). Reducir solo 1 % de este costo equivale a ≈ 680 mil millones COP anuales, magnitud comparable al costo de expandir cobertura en DIT a gran escala. La atención de trayectorias delictivas juveniles y la deserción escolar también implican costos directos por persona que superan el costo anual de un CDI (ICBF, 2022; MEN, 2022). A modo de comparación, un cupo en un Centro de Atención Especializada del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes cuesta entre 30 y 35 millones COP al año, es decir, cinco a seis veces el costo de un cupo en CDI (ICBF, 2024).

**Tabla 4.** Comparativo de Costos aproximados: Intervención Reactiva vs Inversión en desarrollo infantil temprano (COP)

| **Resultado de Política** | **Intervención Reactiva (orden de magnitud)** | **Prevención vía desarrollo infantil temprano** | **Interpretación** |
|---|---|---|---|
| Crimen y violencia | ≈ 68 billones COP/año (Perez-Vincent et al., 2024) | 30 millones COP por niño (5 años) | Reducir 1 % del costo del crimen financia desarrollo infantil temprano masivo |
| Justicia juvenil y trayectorias delictivas | 30–35 millones COP por adolescente/año en un Centro de Atención Especializada (ICBF, 2024) | 6 millones COP/año | Prevenir trayectorias es más barato que tratarlas |
| Desnutrición | ≈ USD 60,9 millones/año (Londoño Trujillo et al., 2024) | El cupo de CDI (6 millones COP/año) incluye alimentación y seguimiento nutricional | Prevención reduce gasto sanitario |
| Rezago educativo | Alto costo fiscal acumulado | Mejores habilidades al ingreso a primaria y menor repitencia, sin costo adicional al cupo | Reduce gasto remedial |
| Desempleo futuro | Pérdida salarial permanente | Aumento de ingresos futuros del 10 % (supuesto de | Amplía base tributaria |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | esta sección) al 25 % (Gertler et al., 2014) | |

La tabla muestra cómo estos costos se comparan con la inversión en primera infancia. En crimen y violencia, el país gasta cerca de 68 billones COP al año. Reducir ese costo en apenas un 1 % equivaldría a financiar unos 110 mil cupos de CDI durante un año. En justicia juvenil, atender a un adolescente en un Centro de Atención Especializada cuesta entre cinco y seis veces lo que cuesta un cupo de CDI. Esto muestra cuánto podría ahorrarse si la atención temprana ayuda a prevenir la vinculación al delito. En desnutrición, los USD 60,9 millones anuales cubren solo la atención en salud y los costos para los hogares durante los primeros años de vida. Los CDI ya incluyen alimentación y seguimiento nutricional como parte de la atención. En educación, llegar a primaria con mejores habilidades reduce la repetición de grado y la necesidad de apoyos adicionales, con ahorros para el sistema educativo. Por último, fortalecer las capacidades desde la infancia puede mejorar los ingresos durante la vida laboral y, con ello, aumentar el recaudo tributario.

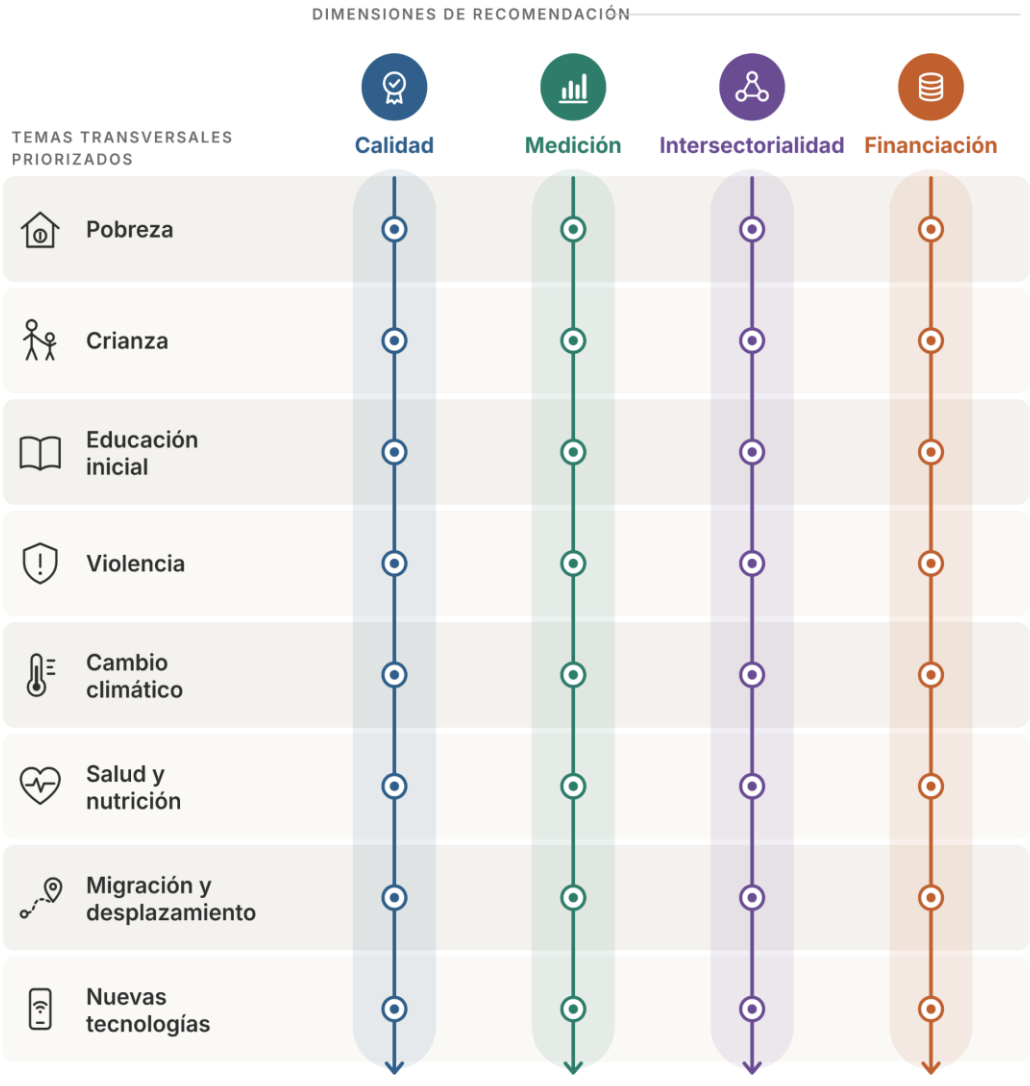
El análisis muestra que los programas de desarrollo infantil temprano generan múltiples beneficios simultáneamente: salud, educación, empleo y reducción de riesgos sociales. La simultaneidad de estos efectos (salud, educación, empleo y cohesión social), implica que el costo por dominio de beneficio es sustancialmente menor que el costo total, lo que ilustra la eficiencia multisectorial de estas intervenciones (Grueso et al., 2025).

En conclusión, el gasto reactivo es alto, recurrente y sectorial; el gasto en desarrollo infantil temprano es relativamente bajo, se concentra al inicio de la vida y es multisectorial. Incluso bajo supuestos conservadores, la inversión temprana se muestra más costo-efectiva para abordar problemas estructurales como criminalidad, desigualdad y desempleo. La evidencia colombiana y global subraya que la primera infancia no es solo una prioridad social, sino también una estrategia de eficiencia fiscal. Introducir la perspectiva preventiva conecta el desarrollo infantil temprano con la sostenibilidad del gasto público y maximiza el uso eficiente de los recursos.

# Recomendaciones de política

Para que la primera infancia ocupe un lugar prioritario en la agenda pública, se requieren acciones concretas y sostenidas en distintos niveles. Las siguientes recomendaciones recogen las perspectivas del grupo experto de coautores, los hallazgos de la revisión de literatura y las entrevistas, y se organizan en cuatro dimensiones transversales a los temas priorizados por el grupo como lo ilustra la Figura 5 a continuación.

**Figura 5.** Recomendaciones de política en cuatro dimensiones transversales a los temas priorizados por CIMIENTOS




Fuente: Autores, diagramado utilizando Inteligencia Artificial

Las recomendaciones se organizan en cuatro dimensiones transversales a los temas abordados en este documento: (1) la calidad de las atenciones y servicios, (2) el fortalecimiento de sistemas de datos e investigación, (3) la intersectorialidad y territorialización de la política y (4) la financiación. Su aplicación no se desarrolla de manera exhaustiva para cada tema; deben leerse como orientaciones comunes que pueden concretarse de distintas formas según el reto, la población y el contexto.

# Calidad

Garantizar que todas las atenciones y servicios dirigidos a la primera infancia y sus familias sean de calidad, estén basadas en la mejor evidencia disponible y respondan a sus necesidades, etapa del desarrollo y contexto.

- **Hacer de la calidad de las interacciones con la primera infancia y el bienestar de sus cuidadores componentes centrales en todos los servicios y atenciones dirigidos a esta población.** Estas interacciones y el bienestar deben garantizarse en los distintos entornos del desarrollo (ej. hogar, servicios de cuidado y educación inicial, salud, entornos comunitarios etc.) y considerar a los cuidadores relevantes (ej. madres, padres, otros familiares, cuidadores no familiares, orientadores, profesores). La calidad debe medirse y promoverse a partir de las interacciones cotidianas con niñas y niños que favorecen el desarrollo y el bienestar infantil, y no limitarse al cumplimiento de requisitos de infraestructura, dotación o funcionamiento. Esto requiere también reconocer y proteger el bienestar de quienes cuidan, como una condición para sostener interacciones de calidad.
- **Traducir esta visión de calidad en estándares claros y en un sistema de seguimiento que permita medirla y mejorarla de manera continua.** Los estándares deben adaptarse a cada tipo de atención y servicio, orientar su implementación y asegurar que cualquier ampliación de cobertura esté acompañada de garantías de calidad. El sistema debe, además, reconocer cómo la discapacidad, la diversidad étnica y territorial y otras características de las familias pueden afectar su acceso, experiencia y beneficio de los servicios, e incorporar estos factores en la definición y evaluación de calidad.

- **Fortalecer las capacidades, el acompañamiento y el reconocimiento de quienes prestan servicios dirigidos a la primera infancia y sus familias.** Esto debe iniciar en la formación técnica y universitaria y continuar con procesos de inducción, actualización y acompañamiento durante el ejercicio laboral.
- **Asegurar que los actores de sectores cuya misionalidad no está centrada en la primera infancia, pero que atienden a familias con niñas y niños pequeños, comprendan los principios básicos de este momento del curso de vida.** Esto incluye reconocer la importancia del bienestar de los cuidadores y de las interacciones para el desarrollo infantil (por ejemplo, en gestión integral del riesgo o transferencias monetarias).

## Datos e investigación

Fortalecer los sistemas de información existentes, consolidar unos nuevos, y fomentar la investigación en temas de primera infancia para poder hacer mejor seguimiento poblacional e individual con el fin de tomar decisiones basadas en evidencia.

- **Acordar un conjunto mínimo de indicadores que permita el seguimiento poblacional al desarrollo infantil temprano y a sus entornos del desarrollo**, priorizando los temas identificados como críticos en esta agenda. Estos indicadores deben ser comparables en el tiempo e incorporarse, en la medida de lo posible, en las encuestas de hogares y sistemas de información ya existentes, de manera que se aproveche la infraestructura de recolección disponible en lugar de crear instrumentos paralelos. Su definición debe hacerse de forma participativa entre entidades de gobierno, academia y sociedad civil, para que respondan tanto a necesidades de política pública como de investigación.
- **Armonizar las definiciones, categorías y desagregaciones** (ej. rangos de edad, grupos étnicos, zonas geográficas) que usan las distintas fuentes de datos nacionales y territoriales sobre la primera infancia. Este proceso debe acompañarse de protocolos claros de interoperabilidad entre los sistemas de información existentes, de forma que puedan integrarse sin comprometer la protección de datos personales.

- **Impulsar nuevos estudios longitudinales, así como estudios rápidos que aprovechen nuevas aproximaciones metodológicas y tecnológicas** (ej. encuestas telefónicas o digitales, sensores, administración remota de instrumentos) para entender tendencias y responder oportunamente a la coyuntura. Estos estudios deben permitir captar de manera complementaria un entendimiento profundo de la ecología del desarrollo humano al igual que los efectos de fenómenos emergentes sobre el desarrollo infantil y sus entornos, como los flujos migratorios, los choques económicos y los eventos climáticos extremos, e informar decisiones de política en tiempo real, sin depender únicamente de los ciclos más lentos de las grandes encuestas nacionales.
- **Aprovechar y cruzar fuentes de datos ya existentes pero poco utilizadas para el análisis de primera infancia**, como los datos georreferenciados de criminalidad, cambio climático, infraestructura y prestación de servicios. Cruzar esta información con los sistemas de información sobre desarrollo infantil permite identificar con mayor precisión los territorios y poblaciones más expuestos a riesgos del entorno, y diseñar respuestas focalizadas y anticipatorias en lugar de depender exclusivamente de la recolección de nueva información primaria.
- **Poner los datos existentes y generados al servicio de la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la investigación**, mediante mecanismos de acceso abierto y responsable que protejan la privacidad de los niños, niñas y sus familias. Esto fomentará la investigación interdisciplinaria, entre economía, psicología, salud pública y ciencias sociales y ambientales, entre otras, y permitirá interpretar estos datos desde distintas perspectivas y generar evidencia útil para el diseño, ajuste y evaluación de las políticas y programas dirigidos a la primera infancia.

## Intersectorialidad y territorialización de la política

Articular actores y sectores en los niveles nacional y territorial para hacer efectiva la política de primera infancia garantizando el cumplimiento y la calidad de las atenciones de la RIA y de otros servicios dirigidos a niñas, niños y sus cuidadores.

- **Fortalecer el liderazgo político de la CIPI, reubicándola en Presidencia para recuperar su capacidad de convocatoria, coordinación y seguimiento.** Desde allí, liderar una estrategia nacional de posicionamiento de la primera infancia y ampliar su agenda a retos emergentes como emergencias, nuevas tecnologías, cambio climático, y transversales como crianza, incorporando los actores pertinentes y definiendo responsabilidades claras para su seguimiento.
- **Utilizar el Plan Nacional de Desarrollo como instrumento para convocar y alinear a todos los sectores alrededor de la primera infancia, bajo el liderazgo del DNP,** y asegurar que esta prioridad se traduzca en metas claras y verificables en los planes de desarrollo territoriales. Estas metas deben definir responsables, recursos y mecanismos de seguimiento, y orientar el cumplimiento efectivo de la RIA en cada territorio.
- **Adaptar la implementación y el seguimiento de la RIA a las necesidades y condiciones de cada territorio y población.** Mantener un marco común de atenciones, pero permitir la flexibilización de los servicios, la priorización de atenciones y el ajuste de indicadores según contextos específicos, como emergencias o pobreza, sin perder de vista los resultados de desarrollo y bienestar que la RIA busca garantizar.
- **Fortalecer las capacidades de todos los sectores para reconocer cómo la primera infancia incide en sus propios resultados programáticos y de política, y cuál es su responsabilidad en el cumplimiento de la RIA.** Esto implica sensibilizar también a sectores que no tienen a la primera infancia como parte central de su mandato, pero cuyas decisiones y servicios afectan directamente a niñas, niños y sus cuidadores.

# Financiación

Aumentar y proteger la inversión pública en primera infancia, con recursos suficientes, sostenidos y plurianuales que permitan garantizar atenciones y servicios de calidad, fortalecer los sistemas de datos e investigación y asegurar la implementación de la política en los territorios.

- **Aumentar la inversión pública en primera infancia, tomando como referente el 1,16 % del PIB** estimado por CEPAL y ONU Mujeres (ONU Mujeres & Comisión Económica

para América Latina y el Caribe, 2022) para financiar sistemas integrales de cuidado infantil. Esta inversión debe permitir avanzar hacia una atención integral con calidad y hacer viables las demás prioridades de política, incluyendo datos e investigación, fortalecimiento territorial y sostenibilidad de los servicios.

- **Asegurar financiación plurianual para proteger la continuidad y la calidad de las atenciones y servicios de primera infancia.** La asignación y contratación de recursos debe trascender los ciclos fiscales anuales, reducir interrupciones en la prestación y permitir procesos sostenidos de acompañamiento, fortalecimiento de equipos y seguimiento a resultados verificables.
- **Asegurar financiación permanente para la medición, el seguimiento y la investigación en primera infancia.** Esto incluye contar con recursos estables para medir la calidad de los servicios, actualizar sistemas de información y producir evidencia periódica, con resultados públicos que orienten la toma de decisiones.
- **Fortalecer y ordenar la financiación territorial de la primera infancia, asegurando que las responsabilidades asignadas a los territorios cuenten con recursos suficientes, estables y claramente identificados.** Esto implica reducir la fragmentación de fuentes de financiación y evitar el traslado de competencias sin la correspondiente asignación presupuestal.

# Bibliografía


Acción contra el Hambre. (2025a, 7 de febrero). *¿Qué es la desnutrición crónica? Causas, consecuencias y tratamiento*. https://accioncontraelhambre.org/es/desnutricion-cronica-que-es

Acción contra el Hambre. (2025b, marzo). *Rutas marítimas de migración informal con tránsito por Colombia*. https://accioncontraelhambrelatinoamerica.org/wp-content/uploads/2025/05/03b_-Rutas-Maritimas-Migratorias-ESP_VF.pdf

Adhvaryu, A., Fenske, J., Kala, N., & Nyshadham, A. (2024). Fetal origins of mental health: Evidence from Africa. *Economic Development and Cultural Change, 72*(2), 493–515. https://doi.org/10.1086/722536

Aguilar-Gomez, S., Cardenas, J. C., & Salas Diaz, R. (2025). Environmental justice beyond race: Skin tone and exposure to air pollution. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(10), e2407064122. https://doi.org/10.1073/pnas.2407064122

Ai, H., & Tan, X. (2023). The effects of exposure to high temperatures during pregnancy on adolescent mental health: Evidence from China. China Economic Review, 80, 101991–101991. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2023.101991

Amar-Amar, J. J., Palacio-Sañudo, J., Romero-Orozco, D., Molina, C., Romero-Royert, D., & Chamorro-Coneo, A. (2023). Childcare practices among Colombian primary caregivers of under-five children: A comparison across socio-demographic characteristics. *Educación y Humanismo, 25*(44). https://doi.org/10.17081/eduhum.25.44.6245

Andrew, A., Attanasio, O. P., Bernal, R., Sosa, L. C., Krutikova, S., & Rubio-Codina, M. (2024). Preschool quality and child development. *Journal of Political Economy, 132*(7), 2304–2345. https://doi.org/10.1086/728744

Arcila Carmona, L. del P., Hurtado Castrillón, P. A., & Pacheco Orduz, M. (2023). *Causas de la desnutrición infantil y su impacto económico y social en Colombia y el mundo* [Trabajo de especialización, Universidad CES y Corporación Universitaria Alexander von Humboldt]. https://repository.ces.edu.co/server/api/core/bitstreams/c58a7f8d-82a3-49f8-92ee-d8f772a0166b/content

Atkinson, A. B. (1987). On the measurement of poverty. *Econometrica, 55*(4), 749–764. https://doi.org/10.2307/1911028

Attanasio, O., Cattan, S., & Meghir, C. (2022). Early childhood development, human capital, and poverty. *Annual Review of Economics, 14*(1), 853–892. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-092821-053234

Attanasio, O. P., Fernandez, C., Fitzsimons, E. O. A., Grantham-McGregor, S. M., Meghir, C., & Rubio-Codina, M. (2014). Using the infrastructure of a conditional cash transfer program to deliver a scalable integrated early child development program in Colombia: Cluster randomized controlled trial. *BMJ, 349*, g5785. https://doi.org/10.1136/bmj.g5785

Attanasio, O. P., Lopez Boo, F., Perez-Lopez, D., & Reynolds, S. A. (2023). *Inequality in the early years in LAC: A comparative study of size, persistence, and policies*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0005359

Backhaus, S., Blackwell, A., & Gardner, F. (2025). The effectiveness of parenting interventions in reducing violence against children in humanitarian settings in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Child Abuse & Neglect, 162*, 106850. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106850

Backhaus, S., Leijten, P., Jochim, J., Melendez-Torres, G. J., & Gardner, F. (2023). Effects over time of parenting interventions to reduce physical and emotional violence against children:

a systematic review and meta-analysis. *eClinicalMedicine, 60*. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102003

Banco Mundial. (2026). *Intentional homicides (per 100,000 people) - Colombia*. https://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5?locations=CO

Bang, M., Medin, D. L., & Atran, S. (2007). Cultural mosaics and mental models of nature. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 104*(35), 13868–13874. https://doi.org/10.1073/pnas.0706627104

Berens, A. E., & Nelson, C. A. (2019). Neurobiology of fetal and infant development: Implications for infant mental health. En C. H. Zeanah (Ed.), Handbook of infant mental health (4.ª ed.). Guilford Press.

Bernal, R., Attanasio, O., Peña, X., & Vera-Hernández, M. (2019). The effects of the transition from home-based childcare to childcare centers on children's health and development in Colombia. *Early Childhood Research Quarterly, 47*, 418–431. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.08.005

Bernal, R., & Camacho, A. (2010). *La importancia de los programas para la primera infancia en Colombia* (pp. 1-114). Universidad de los Andes, Facultad de Economía.

Bernal, R., & Fernández, C. (2013). Subsidized childcare and child development in Colombia: Effects of Hogares Comunitarios de Bienestar as a function of timing and length of exposure. *Social Science & Medicine, 97*, 241–249. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.10.029

Bernal, R., Gómez, M. L., Pérez-Cardona, S., & Baker-Henningham, H. (2023). Implementation quality of an early childhood parenting program in Colombia and child development. *Pediatrics, 151*(Supl. 2), e2023060221J. https://doi.org/10.1542/peds.2023-060221j

Bernal, R., & Ramírez, S. M. (2018). *Improving childcare quality at scale: The effects of "From Zero to Forever"* (Documentos CEDE No. 2018-40). Universidad de los Andes. https://ideas.repec.org/p/col/000089/016600.html

Bernal, R., & Ramírez, S. M. (2019). Improving the quality of early childhood care at scale: The effects of "From Zero to Forever". *World Development, 118*, 91–105. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.02.012

Betz, N., & Coley, J. D. (2022). Human exceptionalist thinking about climate change. *Sustainability, 14*(15), 9519. https://doi.org/10.3390/su14159519

Black, M. M., Walker, S. P., Fernald, L. C. H., Andersen, C. T., DiGirolamo, A. M., Lu, C., McCoy, D. C., Fink, G., Shawar, Y. R., Shiffman, J., Devercelli, A. E., Wodon, Q. T., Vargas-Barón, E., & Grantham-McGregor, S. (2017). Early childhood development coming of age: Science through the life course. *The Lancet, 389*(10064), 77–90. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31389-7

Bornstein, M. H. (2015). Children's parents. En M. H. Bornstein & T. Leventhal (Eds.), *Handbook of child psychology and developmental science: Vol. 4. Ecological settings and processes* (7.ª ed., pp. 55–132). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118963418.childpsy403

Brando, J. F., & Santos, R. J. (2014). La Niña y los niños: Effects of an unexpected winter on early life human capital and family responses. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2631736

Britto, P. R., Lye, S. J., Proulx, K., Yousafzai, A. K., Matthews, S. G., Vaivada, T., Perez-Escamilla, R., Rao, N., Ip, P., Fernald, L. C. H., MacMillan, H., Hanson, M., Wachs, T. D., Yao, H., Yoshikawa, H., Cerezo, A., Leckman, J. F., & Bhutta, Z. A. (2017). Nurturing

care: Promoting early childhood development. *The Lancet, 389*(10064), 91–102. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31390-3

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. En W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models of human development* (6.ª ed., pp. 793–828). Wiley.

Brown, C., Calvi, R., Penglase, J., & Tommasi, D. (2022). Measuring poverty within the household. *IZA World of Labor*, 492. https://doi.org/10.15185/izawol.492

Bueno, O. (2024, abril). *Research on child migration and displacement in Latin America and the Caribbean: Understanding evidence and exploring gaps* [Discussion paper]. UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight. https://www.unicef.org/innocenti/media/7801/file/UNICEF-Innocenti-Migration-Latin-America-Caribbean-2024.pdf

Cabra, H. W. (2023). Three approaches to modeling the relationship among durable goods, academic achievement, and school attendance in Colombia. *Heliyon, 9(12),* e22732. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22732

Cabra, H. W., & Rozo, J. (2024). The role of possession of durable goods in gender-based developmentally-situated educational disparities in Colombia. *International Journal of Educational Research Open, 7, 100356.* https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100356

Canal Laiton, X. (2025, mayo). *Dinámicas migratorias y desafíos para la niñez migrante en América del Sur: Informe de investigación con personas migrantes cuidadoras de menores de edad*. Mixed Migration Centre. https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2025/05/377_Child-Migration-in-South-America-REPORT-ES.pdf

Chatterjee, R. (2023, 16 de octubre). *How Bogotá cares for its family caregivers: From dance classes to job training*. NPR. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2023/10/16/1205218707/how-bogota-cares-for-its-family-caregivers-from-dance-classes-to-job-training

Colombia Aprende. (2018, 11 de julio). *Medición e innovación para la calidad en la educación inicial: Parte 3* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=QGmTkmgJ3Lk

Colombia Aprende. (2023, 13 de diciembre). *Conoce las orientaciones para implementar la política: Evaluar para Avanzar.* https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/evaluar-para-avanzar

Comisión de Regulación de Comunicaciones. (2024). *Infancia y medios audiovisuales: Consumo, mediación parental y apropiación 2024* [Informe ejecutivo]. https://www.crcom.gov.co/system/files/Biblioteca%20Virtual/Informe%20ejecutivo%20del%20Estudio%20de%20infancia%20y%20medios%20audiovisuales%202024/Informe-Ejecutivo-Estudio-Infancia-Medios-Audiovisuales-2024.pdf

Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia. (2013). *Estrategia de atención integral a la primera infancia: Fundamentos políticos, técnicos y de gestión*. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-177829_archivo_pdf_fundamentos_ceroasiempre.pdf

Conger, K. J., Rueter, M. A., & Conger, R. D. (2000). The role of economic pressure in the lives of parents and their adolescents: The family stress model. En L. J. Crockett & R. K. Silbereisen (Eds.), *Negotiating adolescence in times of social change* (pp. 201–223). Cambridge University Press.

Congreso de la República de Colombia. (1997, 18 de julio). *Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia*.

Congreso de la República de Colombia. (2006, 8 de noviembre). *Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=22106

Congreso de la República de Colombia. (2011, 10 de junio). *Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones*.

Congreso de la República de Colombia. (2012, 24 de abril). *Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones*.

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

Congreso de la República de Colombia. (2016, 2 de agosto). *Ley 1804 de 2016. Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones*.

Congreso de la República de Colombia. (2021, 14 de mayo). *Ley 2089 de 2021. Por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones*.

Congreso de la República de Colombia. (2021, 30 de julio). *Ley 2120 de 2021. Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones*. Diario Oficial, 51.751. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168029

Congreso de la República de Colombia. (2021, 4 de agosto). *Ley 2136 de 2021. Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano (PIM), y se dictan otras disposiciones*.

Congreso de la República de Colombia. (2022, 13 de diciembre). *Ley 2277 de 2022. Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial, 52.247. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=199883

Congreso de la República de Colombia. (2024, 26 de julio). *Ley 2388 de 2024. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza*. Diario Oficial, 52.829. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30052898

Congreso de la República de Colombia. (2025, 17 de julio). *Ley 2489 de 2025. Por medio de la cual se establecen disposiciones para el desarrollo de entornos digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes del país*. Diario Oficial, 53.185. https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30055273

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2019, 8 de noviembre). *Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial* (Documento CONPES 3975). Departamento Nacional de Planeación. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3975.pdf

*Constitución Política de Colombia* [Const.]. (1991). Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125

Corte Constitucional de Colombia. (2004, 22 de enero). *Sentencia T-025 de 2004* (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm

Cotte Poveda, A. (2012). Violence and economic development in Colombian cities: A dynamic panel data analysis. *Journal of International Development, 24*(7), 809–827. https://doi.org/10.1002/jid.2819

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3.ª ed.). SAGE.

Cristancho, J. C., Maldonado-Carreño, C., Bailey, D. H., Duncan, G., Escallón, E., & Norza, E. (2026). The effects of homicides on childcare classroom quality and child development. *Educational Researcher. Publicación anticipada en línea*. https://doi.org/10.3102/0013189X261482105

Cuartas, J. (2018a). Neighborhood crime undermines parenting: Violence in the vicinity of households as a predictor of aggressive discipline. *Child Abuse & Neglect, 76*, 388–399. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.12.006

Cuartas, J. (2018b). Physical punishment against the early childhood in Colombia: National and regional prevalence, sociodemographic gaps, and ten-year trends. *Children and Youth Services Review, 93*, 428–440. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.08.024

Cuartas, J. (2021). *Violencia contra niños, niñas y adolescentes: Etiología, consecuencias y estrategias para su prevención* (Documentos de Trabajo No. 81). Universidad de los

Andes, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. https://ideas.repec.org/p/col/000547/020152.html

Cuartas, J., Balza, L. H., Camacho, A., & Gómez-Parra, N. (2026). Ambient heat and early childhood development: A cross-national analysis. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 67*(6), 929–940. https://doi.org/10.1111/jcpp.70081

Cuartas, J., Borbón, J., Beccassino, L., García, I., Rey-Guerra, C., Guerra, M., Moreno, G., Agudo, M. C., Valderrama, M., Trujillo, D., & Pineda Díaz, O. I. (2026). The Apapacho early childhood violence prevention parenting program: A mixed methods pilot evaluation. *Child Abuse & Neglect, 174*, 107951. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2026.107951

Cuartas, J., Gershoff, E. T., Bailey, D. H., Gutiérrez, M. A., & McCoy, D. C. (2025). Physical punishment and lifelong outcomes in low- and middle-income countries: A systematic review and multilevel meta-analysis. *Nature Human Behaviour, 9*(7), 1365–1379. https://doi.org/10.1038/s41562-025-02164-y

Cuartas, J., Jeong, J., Rey-Guerra, C., McCoy, D. C., & Yoshikawa, H. (2020). Maternal, paternal, and other caregivers' stimulation in low- and- middle-income countries. *PLOS ONE, 15*(7), e0236107. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236107

Cuartas, J., & Leventhal, T. (2020). Exposure to community violence and children's mental health: A quasi-experimental examination. *Social Science & Medicine, 246*, 112740. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112740

Cuartas, J., McCoy, D. C., & Molano, A. (2018). The acute effect of community violent crime on maternal engagement in cognitive and socioemotional stimulation. *Early Childhood Research Quarterly, 45*, 143–154. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.06.001

Cuartas, J., McCoy, D. C., Rey-Guerra, C., Britto, P. R., Beatriz, E., & Salhi, C. (2019). Early childhood exposure to non-violent discipline and physical and psychological aggression in low- and middle-income countries: National, regional, and global prevalence estimates. *Child Abuse & Neglect, 92*, 93–105. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.03.021

Cuartas, J., & Morris-Perez, P. (2026). Bringing natural ecosystems into the bioecological model of human development. *Nature Human Behaviour, 10*, 7–9. https://doi.org/10.1038/s41562-025-02334-y

Cuartas, J., Moya, A., & Restrepo-Sáenz, A. M. (2025). *La atención integral a la primera infancia en situaciones de crisis prolongadas: Un llamado que no da espera* [Nota de política]. Sesame Workshop. https://portalsuin.icbf.gov.co/sites/suin/Documents/Documentos%20primera%20infancia/Nota_de_Politica_P.I_Emergencias_fuente_nueva_3.pdf

Cuartas, J., Ramírez-Varela, L., Spitzer, J., Brieant, A., Ghazanfar, A., Lansford, J. E., & Sanson, A. (2026). Climate change, families, and human development: Review of the evidence. *Journal of Cognition and Development, 27*(1), 3–25. https://doi.org/10.1080/15248372.2025.2468187

Cuartas, J., Rey-Guerra, C., & Borbón, J. (2025). Parenting beliefs and psychological distress → stimulation and punishment → young children's behavior: A descriptive study in Colombia. *PLOS One, 20*(11), e0336106. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0336106

Cuartas, J., Rey-Guerra, C., McCoy, D. C., & Hanno, E. (2020). Maternal knowledge, stimulation, and early childhood development in low-income families in Colombia. *Infancy, 25*(5), 526–534. https://doi.org/10.1111/infa.12335

Cuartas, J., Salazar, A., Backhaus, S., Little, M. T., McCoy, D., Yoshikawa, H., Bass, M., Metheny, N., & Knaul, F. (2024). Strategies to prevent violence against children in the home: A systematic review of reviews. Trauma, Violence, & Abuse, 25(4), 3419–3433. https://doi.org/10.1177/15248380241247018

Cuartas, J., Ward, K. P., Ma, J., & Grogan-Kaylor, A. (2020). Physical punishment and Colombian children and adolescents' cognitive and behavioral outcomes. *Journal of Applied Developmental Psychology, 68*, 101140. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101140

Daelmans, B., Nair, M., Hanna, F., Lincetto, O., Dua, T., & Hunt, X. (2021). Commentary: Supporting maternal mental health and nurturing care in humanitarian settings. *Journal on Education in Emergencies, 7*(1), 171–183. https://doi.org/10.33682/9s48-6d0x

Dávalos, M. E., & Monroy, J. M. (2025). *Where you are born matters: Inequality of opportunities and intergenerational mobility across Colombia's territory* (Policy Research Working Paper No. 11126). World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099721005192589316/pdf/IDU-e9f9cc35-993a-4061-af5a-4e5fde8cb328.pdf

Defensoría del Pueblo. (2026). *Informe global constata alarmante panorama de desplazamiento y confinamiento por conflicto y cambio climático en Colombia* [Comunicado de prensa]. https://www.defensoria.gov.co/-/informe-global-constata-alarmante-panorama-de-desplazamiento-y-confinamiento

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2025a). *Proyecciones de población y estudios demográficos (PPED): Colombia, 1950-2070* [Conjunto de datos]. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2025b). *Resultados pobreza monetaria 2023*. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/pres-PM-2023.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2026, 14 de abril). *Pobreza multidimensional en Colombia: Año 2025* [Boletín técnico]. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PMultidimensional-2025.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2018). *Evaluación institucional y de resultados de la Política de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre, para determinar sus efectos sobre la población beneficiaria* [Informe de resultados, elaborado por Unión Temporal Econometría–SEI; contrato CM-003-17]. DNP. https://www.icbf.gov.co/system/files/evaluacion_de_cero_a_siempre_documento_dnp_2018.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2019, marzo). *Familia, infancia y adolescencia* (Boletín No. 12). Observatorio de Familias. https://observatoriodefamilia.dnp.gov.co/Documents/Boletines/BOLETIN%20No%2012.pdf

Departamento Nacional de Planeación. (2026). *Pobreza en las niñas, niños y adolescentes de Colombia: Primera medición 2023, 2024, 2025.* https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Pobreza_ninas_ninos_y_adolescentes_de_Colombia%20.pdf

Dirksen, J., & Alkire, S. (2021). *Children and multidimensional poverty: Four measurement strategies* (OPHI Working Paper No. 138). Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford. https://ophi.org.uk/Publications/WP-138

Draper, C. E., Barnett, L. M., Cook, C. J., Cuartas, J. A., Howard, S. J., McCoy, D. C., Merkley, R., Molano, A., Maldonado-Carreño, C., Obradović, J., Scerif, G., Valentini, N. C., Venetsanou, F., & Yousafzai, A. K. (2023). Publishing child development research from around the world: An unfair playing field resulting in most of the world's child population under-represented in research. *Infant and Child Development, 32*(6), e2375. https://doi.org/10.1002/icd.2375

Draper, C. E., Yousafzai, A. K., McCoy, D. C., Cuartas, J., Obradović, J., Bhopal, S., Fisher, J., Jeong, J., Klingberg, S., Milner, K., Pisani, L., Roy, A., Seiden, J., Sudfeld, C. R., Wrottesley, S. V., Fink, G., Nores, M., Tremblay, M. S., & Okely, A. D. (2024). The next 1000 days: Building on early investments for the health and development of young children. *The Lancet, 404*(10467), 2094–2116. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(24)01389-8

Eltanamly, H., Leijten, P., Jak, S., & Overbeek, G. (2021). Parenting in times of war: A meta-analysis and qualitative synthesis of war exposure, parenting, and child adjustment. *Trauma, Violence, & Abuse, 22*(1), 147–160. https://doi.org/10.1177/1524838019833001

Evans, G. W. (2019). Projected behavioral impacts of global climate change. *Annual Review of Psychology, 70*(1), 449–474. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-103023

Evans, M., Nogales, R., & Robson, M. (2024). Monetary and multidimensional poverty: Correlation, mismatches, and a combined approach. *The Journal of Development Studies, 60*(1), 147–170. https://doi.org/10.1080/00220388.2023.2252140

Feleke, D. G., Kassahun, C. W., GMariam Wmariam, T., Tassaw, S. F., & Chanie, E. S. (2021). Non-exclusive breast feeding and its factors in the first 6-month life of infants among mother-infant pairs of 6–12 months in Debre Tabor town, Northwest Ethiopia, 2019:

Community-based cross-sectional study. *Heliyon, 7*(4), e06922. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06922

Fergusson, L., Díaz, A. M., & Sánchez, J. E. (Comps.). (2024). *Una década de Colombia en movimiento, 2010–2019: Una mirada a los hogares a partir de la Encuesta Longitudinal de Colombia (ELCO)*. Ediciones Uniandes. https://datoscede.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/Una-decada-colombia-en-movimiento-2010-2019.pdf

Ferro, M. (2017). *Efectos de la salud mental y el agotamiento laboral de los maestros de educación inicial sobre el desarrollo temprano de los niños.* https://hdl.handle.net/1992/34296

Fink, G., McCoy, D. C., Jäggi, L., Hinckley, K., Castellanos, A., Huaylinos Bustamante, M. L., Aguilar, L., Gastiaburu Cabello, M. C., Alvarado, M., Hatch, S. F., Dormal, M., Cuartas, J., Zhang, C., Hartinger Peña, S., & Mäusezahl, D. (2026). Digital support systems to improve child development in Peru: A cluster-randomized controlled open-label trial. *Science Advances, 12*(10), eaeb9403. https://doi.org/10.1126/sciadv.aeb9403

Fiscalía General de la Nación. (2017, 21 de diciembre). *Capturados funcionarios del ICBF de El Carmen de Bolívar, señalados de apropiarse de más de $100.000.000 de los programas de alimentación infantil*. https://www.fiscalia.gov.co/seccionales/capturados-funcionarios-del-icbf-de-el-carmen-de-bolivar-senalados-de-apropiarse-de-mas-de-100-000-000-de-los-programas-de-alimentacion-infantil/

García, J. L., Heckman, J. J., Leaf, D. E., & Prados, M. J. (2020). Quantifying the life-cycle benefits of an influential early-childhood program. *Journal of Political Economy, 128*(7), 2502–2541. https://doi.org/10.1086/705718

García, S., & Ritterbusch, A. (2015). Child poverty in Colombia: Construction of a multidimensional measure using a mixed-method approach. *Child Indicators Research, 8*(4), 801–823. https://doi.org/10.1007/s12187-014-9274-2

Garibotto, G., & Curbelo, D. (2023). *Instrumentos y metodologías de evaluación del desarrollo infantil temprano: Relevamiento en países seleccionados de América Latina*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y FLACSO Argentina. https://www.unicef.org/argentina/media/24376/file/Desarrollo%20Infantil%20Temprano.pdf.pdf

Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. *Science, 344*(6187), 998–1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178

Gillespie, S., Banegas, J., Maxwell, J., Chan, A. C. Y., Darawshy, N. A.-S., Wasil, A. R., Marsalis, S., & Gewirtz, A. (2022). Parenting interventions for refugees and forcibly displaced families: A systematic review. *Clinical Child and Family Psychology Review, 25*(2), 395–412. https://doi.org/10.1007/s10567-021-00375-z

González González, C. A. (2018). *Estrés laboral en docentes de la primera infancia* [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Minuto de Dios]. https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/45bf881e-ad77-40dc-81c8-8215912e6c2a/content

Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. *Science, 312*(5782), 1900–1902. https://doi.org/10.1126/science.1128898

Heilmann, A., Mehay, A., Watt, R. G., Kelly, Y., Durrant, J. E., van Turnhout, J., & Gershoff, E. T. (2021). Physical punishment and child outcomes: A narrative review of prospective studies. *The Lancet, 398*(10297), 355–364. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)00582-1

Hutton, J. S., Dudley, J., Horowitz-Kraus, T., DeWitt, T., & Holland, S. K. (2020). Associations between screen-based media use and brain white matter integrity in preschool-aged children. *JAMA Pediatrics, 174*(1), e193869. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2019.3869

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (s. f.). *Modalidades de atención.* https://www.icbf.gov.co/modalidades-de-atencion-0

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2011). *Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010 (ENSIN)*.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2023, 12 de julio). *Anexo técnico: Portafolio de formación 2024. Sanar para Crecer: Estrategia para la promoción del desarrollo socioemocional de niñas y niños en primera infancia.* https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/a2.g1.lm5_.pp_anexo_sesiones_sanar_para_crecer_v1.pdf

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2024, septiembre). Boletín estadístico Dirección de Protección. [Boletín]. https://www.icbf.gov.co/system/files/boletin_direccion_proteccion_septiembre_2024_0.pdf

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2024, noviembre). *Datos para el cambio: Violencias* [Boletín]. https://portalsuin.icbf.gov.co/sites/suin/Documents/Boletines%20Datos%20para%20la%20

acci%C3%B3n/Datos%20para%20el%20cambio%20violencias%20-%20VF_OBNSUIN.pdf

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2025a). *Informe anual de implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia "De Cero a Siempre", Ley 1804 de 2016: Vigencia 2024*. Cámara de Representantes de Colombia. https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2026/05/INF-ICBF-O-A-SIEMPRE-LEY-1804-16-COM-7.pdf

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2025b, abril). *Datos para el cambio: Situación de la primera infancia* [Boletín]. https://portalsuin.icbf.gov.co/sites/suin/Documents/Boletines%20Datos%20para%20la%20acci%C3%B3n/Datos%20para%20el%20cambio%20primera%20infancia%20VFR_OBN_SUIN.pdf

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2024, 12 de diciembre). *El Ideam presenta nuevas proyecciones climáticas para Colombia: Escenarios de cambio climático al 2100* [Comunicado de prensa]. https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/noticia/el-ideam-presenta-nuevas-proyecciones-climaticas-para-colombia-escenarios-de-cambio-climatico-al

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento Nacional de Planeación, & Cancillería. (2017). *Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia: Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático*. IDEAM.

Instituto Nacional de Salud. (2025). *Boletín epidemiológico semanal: Semana epidemiológica 11*. https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2025_Boletin_epidemiologico_semana_11.pdf

Instituto Nacional de Salud. (2026). *Boletín epidemiológico semanal: Semana epidemiológica 10, 8–14 de marzo de 2026*. https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2026_Boletin_epidemiologico_semana_10.pdf

International Committee of the Red Cross [ICRC]. (2025). *2025 set to be the decade's worst year in humanitarian terms*. https://www.icrc.org/sites/default/files/2025-07/2025%20set%20to%20be%20the%20decade%E2%80%99s%20worst%20year%20in%20humanitarian%20terms.pdf

Ives, C. D., Abson, D. J., von Wehrden, H., Dorninger, C., Klaniecki, K., & Fischer, J. (2018). Reconnecting with nature for sustainability. *Sustainability Science, 13*(5), 1389–1397. https://doi.org/10.1007/s11625-018-0542-9

Jaramillo, N., & Bonet de Vivero, M. (2024). *Inversión en cuidadores, salud mental y desarrollo infantil: Un análisis costo-beneficio de Semillas de Apego* (Documentos CEDE No. 2024-36). Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE. https://doi.org/10.2139/ssrn.4959453

Jaramillo-Echeverri, J., Otero-Cortés, A. S., Tribín-Uribe, A. M., & Villaveces-Niño, J. (2025). *The elusive domestic revolution: Time use and gender roles in Colombia* [Cuadernos de Historia Económica]. Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/en/publicaciones-investigaciones/cuadernos-historia-economica/elusive-domestic-revolution-time

Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. *Review of Educational Research, 79*(1), 491–525. https://doi.org/10.3102/0034654308325693

Jennings, P. A., Jeon, L., & Roberts, A. M. (2020). Introduction to the special issue on early care and education professionals' social and emotional well-being. *Early Education and Development, 31*(7), 933–939. https://doi.org/10.1080/10409289.2020.1809895

Jensen, S. K. G., Berens, A. E., & Nelson, C. A., III. (2017). Effects of poverty on interacting biological systems underlying child development. *The Lancet Child & Adolescent Health, 1*(3), 225–239. https://doi.org/10.1016/s2352-4642(17)30024-x

Jeong, J., Adhia, A., Bhatia, A., McCoy, D. C., & Yousafzai, A. K. (2020). Intimate partner violence, maternal and paternal parenting, and early child development. *Pediatrics, 145*(6), e20192955. https://doi.org/10.1542/peds.2019-2955

Jeong, J., Franchett, E. E., Ramos de Oliveira, C. V., Rehmani, K., & Yousafzai, A. K. (2021). Parenting interventions to promote early child development in the first three years of life: A global systematic review and meta-analysis. *PLOS Medicine, 18*(5), e1003602. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003602

Kalil, A., & Ryan, R. (2020). Parenting practices and socioeconomic gaps in childhood outcomes. *The Future of Children, 30*(1), 29–54. https://doi.org/10.1353/foc.2020.0004

Karlsson, O., & Subramanian, S. V. (2023). Refrigerator ownership and child health and nutrition in low- and middle-income countries. *Global Food Security, 37*, 100698. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100698

Kimmerer, R. W. (2013). *Braiding sweetgrass: Indigenous wisdom, scientific knowledge, and the teachings of plants*. Milkweed Editions.

Knudsen, E. I. (2004). Sensitive periods in the development of the brain and behavior. *Journal of Cognitive Neuroscience, 16*(8), 1412–1425. https://doi.org/10.1162/0898929042304796

Knudsen, E. I., Heckman, J. J., Cameron, J. L., & Shonkoff, J. P. (2006). Economic, neurobiological, and behavioral perspectives on building America's future workforce. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 103*(27), 10155–10162. https://doi.org/10.1073/pnas.0600888103

Koppensteiner, M. F., & Menezes, L. (2021). Violence and human capital investments. *Journal of Labor Economics, 39*(3), 787–823. https://doi.org/10.1086/711001

Laboratorio de Economía de la Educación. (2021, 7 de octubre). *Desafíos y brechas en cobertura en primera infancia en Colombia* (Informe No. 43). Pontificia Universidad Javeriana. https://lee.javeriana.edu.co/documents/5581483/7046588/INFORME-43-+COBERTURA-Y-DESAFIOS-PRIMERA-INFANCIA-LEE-PUJ.pdf

Laboratorio de Economía de la Educación [LEE]. (2024, 23 de octubre). *Primera infancia en Colombia: Cifras y contexto* (Informe No. 107). Pontificia Universidad Javeriana. https://www.javeriana.edu.co/recursosdb/5581483/11594517/INF107+-Informe+Infancia-2024+-LEE+VF.pdf

Laboratorio de Economía de la Educación. (2026a, febrero). *La matrícula en educación inicial, básica y media* (Informe No. 134). Pontificia Universidad Javeriana. https://lee.javeriana.edu.co/publicaciones-y-documentos

Laboratorio de Economía de la Educación. (2026b, mayo). *Primeros años, grandes retos: Radiografía de la primera infancia en Colombia* (Informe No. 139). Pontificia Universidad Javeriana. https://lee.javeriana.edu.co/publicaciones-y-documentos

Ladhani, S., & Sitter, K. C. (2020). Conditional cash transfers: A critical review. *Development Policy Review, 38*(1), 28–41. https://doi.org/10.1111/dpr.12416

Lai, B. S., La Greca, A. M., Colgan, C. A., Herge, W., Chan, S., Medzhitova, J., Short, M., & Auslander, B. (2020). Sleep problems and posttraumatic stress: Children exposed to a natural disaster. *Journal of Pediatric Psychology, 45*(9), 1016–1026. https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsaa061

Lam, D. P. M., Hinz, E., Lang, D. J., Tengö, M., Wehrden, H. V., & Martín-López, B. (2020). Indigenous and local knowledge in sustainability transformations research: A literature review. *Ecology and Society, 25*(1), Artículo 3. https://doi.org/10.5751/es-11305-250103

Lansford, J. E., Godwin, J., Uribe Tirado, L. M., Zelli, A., Al-Hassan, S. M., Bacchini, D., Bombi, A. S., Bornstein, M. H., Chang, L., Deater-Deckard, K., Di Giunta, L., Dodge, K. A., Malone, P. S., Oburu, P., Pastorelli, C., Skinner, A. T., Sorbring, E., Tapanya, S., & Alampay, L. P. (2015). Individual, family, and culture level contributions to child physical abuse and neglect: A longitudinal study in nine countries. *Development and Psychopathology, 27*(4, Pt. 2), 1417–1428. https://doi.org/10.1017/s095457941500084x

Laverde Rojas, H., Gómez Ríos, J. J., & Sellamén Garzón, A. (2019). Pobreza en la infancia: Enfoques y aproximaciones conceptuales. *Equidad y Desarrollo, 1*(33), 63–87. https://doi.org/10.19052/eq.vol1.iss33.4

Leventhal, T., & Brooks-Gunn, J. (2000). The neighborhoods they live in: The effects of neighborhood residence on child and adolescent outcomes. *Psychological Bulletin, 126*(2), 309–337. https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.2.309

Little, M. T., Butchart, A., Massetti, G. M., Hermosilla, S., Wittesaele, C., Pearson, I., Jochim, J., Swingler, S., Schupp, C., Böhret, I. A., Neelakantan, L., Backhaus, S., Martin, M., Mase,

M., Page, S., Janowski, R., Blackwell, A., Bernstein, K. T., Rakotomalala, S., & Cluver, L. (2026). Interventions to prevent, reduce, and respond to violence against children and adolescents: A systematic review of systematic reviews to update the INSPIRE Framework. *The Lancet Child & Adolescent Health, 10*(1), 49–61. https://doi.org/10.1016/s2352-4642(25)00214-7

Londoño Trujillo, D., Taborda Restrepo, P. A., De la Hoz, M. C., Burgos Castro, J. C., Arbelaez Vargas, J. S., & Pineda Ruiz, D. M. (2024). Burden of wasting and stunting in Colombia and its economic impact: A society's perspective analysis, 2021. *Nutrients, 16*(24), 4302. https://doi.org/10.3390/nu16244302

Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., & Tough, S. (2019). Association between screen time and children's performance on a developmental screening test. *JAMA Pediatrics, 173*(3), 244–250. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.5056

Maldonado-Carreño, C., Rey-Guerra, C., Cuartas, J., Plata-Caviedes, T., Rodríguez-De Luque, J. J., Escallón Largacha, E., Yoshikawa, H., & Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional. (2018). *Medición de la calidad de la educación inicial en Colombia en la modalidad institucional* (Notas de Política en Educación No. 1). Universidad de los Andes. https://educacion.uniandes.edu.co/sites/default/files/MEdicion%20Calidad.pdf

Maldonado-Carreño, C., Yoshikawa, H., Escallón, E., Ponguta, L. A., Nieto, A. M., Kagan, S. L., Rey-Guerra, C., Cristancho, J. C., Mateus, A., Caro, L. A., Aragon, C. A., Rodríguez, A. M., & Motta, A. (2022). Measuring the quality of early childhood education: Associations with children's development from a national study with the IMCEIC tool in Colombia. *Child Development, 93*(1), 254–268. https://doi.org/10.1111/cdev.13665

Malhi, F. N., Hassan, H., & Su, Q. (2025). Time-saving appliances and educational pitfalls: Evidence from Pakistan. *Energy Economics, 147*, 108599. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108599

Masten, A. S., & Cicchetti, D. (2010). Developmental cascades. *Development and Psychopathology, 22*(3), 491–495. https://doi.org/10.1017/s0954579410000222

McCoy, D. C. (2022). Building a model of cultural universality with specificity for global early childhood development. *Child Development Perspectives, 16*(1), 27–33. https://doi.org/10.1111/cdep.12438

McLaughlin, K. A., Sheridan, M. A., Humphreys, K. L., Belsky, J., & Ellis, B. J. (2021). The value of dimensional models of early experience: Thinking clearly about concepts and categories. *Perspectives on Psychological Science, 16*(6), 1463–1472. https://doi.org/10.1177/1745691621992346

Meyer, M., Adkins, V., Yuan, N., Weeks, H. M., Chang, Y.-J., & Radesky, J. (2019). Advertising in young children's apps: A content analysis. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 40*(1), 32–39. https://doi.org/10.1097/dbp.0000000000000622

Miller, K. E., Jordans, M. J. D., Tol, W. A., & Galappatti, A. (2021). A call for greater conceptual clarity in the field of mental health and psychosocial support in humanitarian settings. *Epidemiology and Psychiatric Sciences, 30*, e5. https://doi.org/10.1017/s2045796020001110

Ministerio de Educación Nacional. (2021). *Resultados de la medición de la calidad de la educación inicial, grado transición 2021*. https://www.colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/resultados-de-la-medicion-de-la-calidad-de-la-educacion-inicial-grado-transicion

Ministerio de Educación Nacional. (2024). *Atención integral a la primera infancia: Indicadores 2024*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-356107_recurso_18.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Plan estratégico institucional 2025*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-423383_recurso_01.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026a, 8 de julio). *Cobertura en cifras definitiva 2025* [Archivo de Excel]. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-350799_recurso_15.xlsm

Ministerio de Educación Nacional. (2026b, 26 de junio). *Modalidades de la educación inicial*. https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-inicial/Sistema-de-Educacion-Inicial/228881:Modalidades-de-la-educacion-inicial

Ministerio de Educación Nacional. (2026c, 14 de septiembre). *Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral* [Tablero de Power BI]. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGY2ZmRjNWQtZTdkOC00MGE2LThiMjEtNjAxZTRlM2U0OTQ4IiwidCI6IjMxZmNmYjNmLThhMGItNGFiNS1iNzkyLTc0YzkwNjJiOWM4ZSIsImMiOjR9

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2026, 16 de julio). *Decreto 0769 de 2026*. Por el cual se adiciona el Título 31 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para reglamentar la Ley 2489 de 2025 a través de disposiciones para la promoción, protección y garantía de entornos digitales sanos y seguros para niños, niñas y adolescentes.

Mixed Migration Centre, & ProLAC. (2025, mayo). *Dinámicas migratorias y riesgos de protección en los movimientos de retorno norte-sur en las Américas: Impactos de los*

*cambios en la política migratoria de Estados Unidos*. https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2025/06/387_ProLAC-MMC-Migration-dynamics-protection-risks-returns-South-America-ES.pdf

Moya, A., Torres, M. J., Sánchez-Ariza, J., Harker, A., Lieberman, A., Niño, B., & Reyes, V. (2024). *Caregiver mental health and early childhood development: Experimental evidence from a conflict-affected setting* [Documento de trabajo]. https://www.jointdatacenter.org/wp-content/uploads/2024/09/Moya.pdf

Munguía, A., Lara-Mejía, V., Ayvar-Gama, Y., Marquez, I., Flores, M., Barquera, S., & Tolentino-Mayo, L. (2026). Food and beverage marketing directed at youth in 11 Latin American countries: A scoping review. *BMC Public Health, 26*(1), 133. https://doi.org/10.1186/s12889-025-23481-x

Muñoz, C., Correa, C., & Matajudíos, J. (2020). Síndrome de burnout y estrategias de afrontamiento en docentes de primera infancia. *Revista Espacios, 41*(37), 145–158. https://www.revistaespacios.com/a20v41n37/a20v41n37p12.pdf

National Scientific Council on the Developing Child. (2005). *Excessive stress disrupts the architecture of the developing brain* (Working Paper No. 3). Center on the Developing Child, Harvard University. https://developingchild.harvard.edu/resources/wp3/

National Scientific Council on the Developing Child. (2014). *Excessive stress disrupts the architecture of the developing brain* (Working Paper No. 3, ed. actualizada). Center on the Developing Child, Harvard University. https://developingchild.harvard.edu/resources/wp3/

National Scientific Council on the Developing Child. (2020). Connecting the brain to the rest of the body: Early childhood development and lifelong health are deeply intertwined (Working Paper No. 15). Center on the Developing Child, Harvard University.

Neldner, K., Maurits, L., Junker, M., Abbas, L., Abbas, N., Abis, A., Amici, F., Arroyo-Garcia, B., Asghari, N., Pardo, G. B., Zhang, Z., Chumacero, J. P., Dzabatou, A., Eirdosh, D., Hanisch, S., Herrnsdorf, T., Hovehne, T., Junker, A., Kanngiesser, P., … Liebal, K. (2026). Children and adults across 15 countries believe in human uniqueness of mind: A cross-cultural investigation of cross-species mind perception. *Journal of Environmental Psychology, 109*, 102861. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2025.102861

Nelson, C. A., III, & Gabard-Durnam, L. J. (2020). Early adversity and critical periods: Neurodevelopmental consequences of violating the expectable environment. *Trends in Neurosciences, 43*(3), 133–143. https://doi.org/10.1016/j.tins.2020.01.002

Nelson, C. A., Sullivan, E. F., & Valdes, V. (2025). Early adversity alters brain architecture and increases susceptibility to mental health disorders. *Nature Reviews Neuroscience, 26*(10), 642–656. https://doi.org/10.1038/s41583-025-00948-9

NiñezYA. (2024). *Colombia: Segundo informe de progreso de políticas de primera infancia 2024*. Diálogo Interamericano.

Nores, M., Bernal, R., & Barnett, W. S. (2019). Center-based care for infants and toddlers: The aeioTU randomized trial. *Economics of Education Review, 72*, 30–43. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.05.004

Nores, M., Vazquez, C., Gustafsson-Wright, E., Osborne, S., Cuartas, J., Lambiris, M. J., McCoy, D. C., Lopez-Boo, F., Behrman, J., Bernal, R., Draper, C. E., Okely, A. D., Tremblay, M. S., Yousafzai, A. K., Lombardi, J., & Fink, G. (2024). The cost of not investing in the next 1000 days: Implications for policy and practice. *The Lancet, 404*(10467), 2117–2130. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(24)01390-4

Onsay, E. A., Arapoc, J., & Rabajante, J. F. (2025). Multidimensional impact evaluation of the national conditional cash transfer on poverty alleviation and economic development in the poorest region of Luzon, Philippines. *Development and Sustainability in Economics and Finance, 6*, 100053. https://doi.org/10.1016/j.dsef.2025.100053

ONU Mujeres, & Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *Hacia la construcción de sistemas integrales de cuidados en América Latina y el Caribe: Elementos para su implementación* (LC/TS.2022/26). https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47898

Organización Mundial de la Salud. (2025, 7 de mayo). *Enfermedades no transmisibles: Sobrepeso y obesidad infantiles*. https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/noncommunicable-diseases-childhood-overweight-and-obesity

Organización Panamericana de la Salud. (2019, 23 de octubre). *Alimentos ultraprocesados ganan más espacio en la mesa de las familias latinoamericanas*. https://www.paho.org/es/noticias/23-10-2019-alimentos-ultraprocesados-ganan-mas-espacio-mesa-familias-latinoamericanas

Orshansky, M. (1988). Counting the poor: Another look at the poverty profile. *Social Security Bulletin, 51*(10), 25–51. https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v51n10/v51n10p25.pdf (Trabajo original publicado en 1965).

Osofsky, J. D., Osofsky, H. J., Weems, C. F., King, L. S., & Hansel, T. C. (2015). Trajectories of post-traumatic stress disorder symptoms among youth exposed to both natural and technological disasters. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56*(12), 1347–1355. https://doi.org/10.1111/jcpp.12420

Østby, G., & Rustad, S. A. (2024, 31 de octubre). *473 million children live in conflict zones*. PRIO Blogs. https://blogs.prio.org/2024/10/473-million-children-live-in-conflict-zones/

Perez-Vincent, S. M., Puebla, D., Alvarado, N., Mejía, L. F., Cadena, X., Higuera, S., & Niño, J. D. (2024). *Los costos del crimen y la violencia: Ampliación y actualización de las estimaciones para América Latina y el Caribe*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/es/los-costos-del-crimen-y-la-violencia-ampliacion-y-actualizacion-de-las-estimaciones-para-america

Petridi, E., Magriplis, E., Karatzi, K., Charidemou, E., Philippou, E., & Zampelas, A. (2025). Ultra processed food consumption in children and adolescents: Main food group contributors and associations with weight status. *Nutrition Bulletin, 50*(2), 278–289. https://doi.org/10.1111/nbu.70001

Pizza, L., & Kelemen, D. (2023). Are humans part of the natural world? U.S. children's and adults' concept of nature and its relationship to environmental concern. *Topics in Cognitive Science, 15*(3), 452–479. https://doi.org/10.1111/tops.12675

Pizza, L., & Posada, R. (2026). How human exceptionalist assumptions impact environmental attitudes in low socioeconomic urban communities in Colombia. *Journal of Cognition and Development, 27*(1), 26–45. https://doi.org/10.1080/15248372.2025.2506058

Rawlings, L. B., & Rubio, G. M. (2003). *Evaluating the impact of conditional cash transfer programs: Lessons from Latin America* (Policy Research Working Paper No. 3119). World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-3119

Rey-Guerra, C., Borbón, J., & Guerra, M. (2026). Gendered attitudes and parenting practices of mothers and fathers in two culturally diverse Colombian cities. *Infant and Child Development, 35*(1), e70068. https://doi.org/10.1002/icd.70068

Rey-Guerra, C., Maldonado-Carreño, C., Ponguta, L. A., Nieto, A. M., & Yoshikawa, H. (2022). Family engagement in early learning opportunities at home and in early childhood education centers in Colombia. *Early Childhood Research Quarterly, 58*, 35–46. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2021.08.002

Rojas, D., & Puerto, P. (2019). *Revisión teórica sobre los factores que inciden en el desencadenamiento del estrés laboral en docentes de primera infancia*. Repositorio Institucional Universidad ECCI. https://repositorio.ecci.edu.co/server/api/core/bitstreams/9a22960b-3cea-4888-9fd7-e1c785a7bbe2/content

Rojas, M. V. (2023, 10 de septiembre). *Desnutrición en Colombia*. Razón Pública. https://razonpublica.com/desnutricion-en-colombia/

Rojas Romero, C. J., Moreno Angarita, M., Guerrero, Y., & Prieto Cifuentes, L. S. (2025). De cero a siempre: Reflections on the Colombian early childhood policy from a human rights perspective. *Social Sciences, 14*(3), 137. https://doi.org/10.3390/socsci14030137

Romero Royert, D., Amar, J. J., González, L., Romero Orozco, D., & Aragón, J. (2023). Actitudes hacia las prácticas de cuidado infantil en cuidadores rurales y urbanos con altos índices de pobreza. *Psicogente, 26*(50). https://doi.org/10.17081/psico.26.50.6583

Sánchez-Ariza, J., Cuartas, J., & Moya, A. (2023). The mental health of caregivers and young children in conflict-affected settings. *AEA Papers and Proceedings, 113*, 336–341. https://doi.org/10.1257/pandp.20231017

Santos, M. E. (2019). *Challenges in designing national multidimensional poverty measures* (Statistics Series No. 100). Economic Commission for Latin America and the Caribbean.

https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1c37b332-bcce-4050-95b2-dd9e60280604/content

Sapien Labs. (2023, 15 de mayo). *Age of first smartphone/tablet and mental wellbeing outcomes*. https://sapienlabs.org/wp-content/uploads/2023/05/Sapien-Labs-Age-of-First-Smartphone-and-Mental-Wellbeing-Outcomes.pdf

Save the Children. (2021). *The toughest places to be a child: Global childhood report 2021*. https://www.childhealthtaskforce.org/sites/default/files/2021-03/2021-global-childhood-report.pdf

Shankar, A., Cañizares, C., & Cardozo, F. (2026). ghosted: Deidentify transcript files with a local app (Versión 0.1.0.0) [Paquete de R]. https://github.com/abiraahmi/ghosted

Skinner, G. C., & Kennedy, E. (2025). The cost of poverty for child development: The adverse impact on maltreatment, education and mental health outcomes cannot be ignored. *Clinical Child Psychology and Psychiatry, 30*(2), 309–313. https://doi.org/10.1177/13591045241302121

Suárez Arias, A. L., García Ferrandis, I., & Cardona Hernández, L. C. (2020). La metodología de análisis de la percepción ambiental de los niños en una comunidad periurbana. *Sophia, 16*(1), 19–32. https://doi.org/10.18634/sophiaj.16v.1i.1004

Tamis-LeMonda, C. S. (2022). *Child development: Context, culture, and cascades*. Sinauer Associates/Oxford University Press.

Tobón Berrio, L. E., Palacio Sañudo, J., & Sabatier, C. (2025). El castigo físico desde las representaciones sociales de los padres y madres. *Opinión Jurídica, 24*(52), 1–25. https://doi.org/10.22395/ojum.a4295

Uenal, F., Sidanius, J., Maertens, R., Hudson, S.-K. T., Davis, G., & Ghani, A. (2022). The roots of ecological dominance orientation: Assessing individual preferences for an anthropocentric and hierarchically organized world. *Journal of Environmental Psychology, 81*, 101783. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2022.101783

UNICEF. (2023). *The changing face of child migration in Latin America and the Caribbean: A region like no other*. https://www.unicef.org/media/144656/file/LAC%20Migration%20Child%20Alert.pdf

UNICEF. (2025). *The state of the world's children 2025: Ending child poverty—Our shared imperative*. https://www.unicef.org/media/176436/file/SOWC-2025-full-report-EN.pdf

Universidad de los Andes, Tigo, & Aulas en Paz. (2024). *Riesgos y oportunidades del uso de internet para niñas, niños y adolescentes en Colombia: Resumen de resultados*. https://www.contigoconectados.com/wp-content/uploads/2024/03/RIESGOS-Y-OPORTUNIDADES-DEL-USO-DE-INTERNET-PARA-NNA-EN-COLOMBIA-RESUMEN-DE-RESULTADOS-V-FINAL.pdf

Vijaya, R. M., Lahoti, R., & Swaminathan, H. (2014). Moving from the household to the individual: Multidimensional poverty analysis. *World Development, 59*, 70–81. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.029

Wachs, T. D., & Rahman, A. (2013). The nature and impact of risk and protective influences on children's development in low-income countries. En P. R. Britto, P. L. Engle, & C. M. Super (Eds.), *Handbook of early childhood development research and its impact on global policy* (pp. 85–122). Oxford University Press.

Wamsler, C., Osberg, G., Panagiotou, A., Smith, B., Stanbridge, P., Osika, W., & Mundaca, L. (2023). Meaning-making in a context of climate change: Supporting agency and political

engagement. *Climate Policy, 23*(7), 829–844. https://doi.org/10.1080/14693062.2022.2121254

World Health Organization. (2016). INSPIRE: Seven strategies for ending violence against children. https://www.refworld.org/docid/57878f5e4.html

World Health Organization. (2019). *Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age*. https://apps.who.int/iris/handle/10665/311664

World Health Organization. (2023). *Global scales for early development (GSED) v1.0*. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MSD-GSED-package-v1.0-2023.1

Yoshikawa, H., Ponguta, L. A., Nieto, A. M., van Ravens, J., Portilla, X. A., Britto, P. R., & Leyva, D. (2014). *Evaluación de los mecanismos de implementación, gobernanza, financiación y sostenibilidad de la Estrategia Integral de Desarrollo de la Primera Infancia en Colombia De Cero a Siempre* [Informe no publicado]. Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia.